中图分类号：　　密　　级：

UDC：　　本校编号：10652

西南政法大学

新闻与传播硕士专业学位论文

论文题目：老年人购买保健品意愿的影响因素——基于保健品营销传播和虚假宣传的实证

研究生姓名：祁润梅　学号：20200552001631

校内指导教师姓名：贺建平　职　称：教　授

校外指导教师姓名：　职务职称：

申请学位等级：硕　士　专业方向：新闻与传播　学习形式：全日制

论文提交日期：2023 年 3 月 17 日　论文答辩日期：2023 年 5 月 30 日

中国知网　https://www.cnki.net

新 闻 与 传 播 硕 士 专 业 学 位 论 文

老年人保健品购买意愿的影响因素——基于保健品营销传播和虚假宣传的实证

Influencing Factors of Purchase Intention of Health Care Products for the Elderly —— Empirical Research Based on Marketing Communication and False Propagate of Health Products

作 者 姓 名：祁 润 梅

指 导 教 师：贺 建 平

西 南 政 法 大 学

Southwest University of Political Science and Law

中国知网 https://www.cnki.net

内容摘要

当“互联网+”行动遇上积极老龄化和“健康中国”政策推进老年健康的大环境时，我国的保健品行业迎来了新的市场机遇。但当老年消费者急于追求健康的心理被不法分子利用时，伪劣保健品成风扰乱市场，营销套路层出不穷，虚假宣传现象屡禁不止，“劣币驱逐良币”让我国保健品行业深陷信任危机。本文旨在从人际传播和媒介传播出发，以“信任”为切入点，发现我国老年人购买保健产品的影响因素，以期寻找降低保健品诈骗危害的解决方法，为老年人遇到的健康问题提供安全保障。

首先，本文借助认知信任和情感信任理论，在消费者相关研究、媒介传播相关研究和 SOR 理论现有研究的基础上，通过问卷收集数据，构建了一个结构方程模型，考察老年人在保健品营销传播活动中其购买意愿的影响路径，找出是何种因素影响着老年人对伪劣保健品的信任和购买。其次，通过访谈和参与式观察，对模型得到的数据结果进行溯因，分析老年消费者的心理和特性，进一步确证研究结论。

研究的主要发现有：（1）我国保健品行业深陷信任危机，老年人普遍认为保健产品有关宣传是骗局，对传统媒介和新媒介都表现出不信任。老年群体对两种媒介的态度存在细微的分化现象，虚假宣传广告和品牌假新闻让老人们对传统媒介失去信心，并更不愿信任新媒介。这意味着老年人对保健产品及对其展开宣传媒介的信任几乎都已经消耗殆尽，信任亟待重构。（2）媒介素养、媒介信任度、可靠性感知和消费者涉入度是认知信任的前因变量，认知信任和消费者涉入度是情感信任的前因变量，认知信任依旧被证实是情感信任建立的基础。（3）情感信任比认知信任对保健品购买意愿起着更重要的作用，且认知信任和情感信任产生的影响存在差异，反映出老年人购买伪劣保健产品主要是由情感驱动的。在此过程中，保健品销售人员与老年消费者之间的人际传播是两者情感纽带建立的主要方式，具体内容为：与老人成为朋友，为老年客户构建公共交流空间。（4）媒介素养对购买意愿发挥作用的机制较为复杂，其中媒介信任度和情感信任度是必要条件，认知信任是充分条件，说明媒介传播的效果

中国知网 https://www.cnki.net

与老年人对当下环境的判断结果相关。家庭数字反哺为老人识别虚假保健信息提供了一定帮助，但仍有缺陷。

研究结果关注了保健品消费中的积极老龄观，强调了情感信任的重要影响，丰富了集体主义背景下老年群体信任机制的现有研究，发现了线上与线下的消费环境中媒介素养复杂的作用机制，揭示了人际传播和媒介传播在其中的重要作用。

关键词：老年人；保健品；营销传播；虚假宣传；影响因素

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

When the "Internet+" initiative meets the positive aging and "Healthy China" policy to promote the health of the elderly, China's health care industry has ushered in new market opportunities. However, when the psychology of elderly consumers' eagerness for health is exploited by unscrupulous elements, the market is disrupted by shoddy health products, marketing schemes and false propaganda, and the industry is in a crisis of trust. The purpose of this paper is to find out the factors influencing the purchase of health care products by the elderly in China from interpersonal communication and media communication, and to find out the solutions to reduce the danger of health care fraud and to provide security for the health problems encountered by the elderly.

Firstly, with the help of cognition-based trust and affect-based trust theory, based on the existing research on consumer, media communication and SOR theory, this paper collected data through questionnaires, constructed a structural equation model, investigated the influence path of the elderly's purchase intention in the marketing and communication of health care products, and found out what factors influenced the elderly's trust and purchase of fake health care products. Secondly, through interviews and participatory observation, the data obtained from the model are traced back, and the psychology and characteristics of the elderly consumers are analyzed to further confirm the research conclusion.

The main findings of the study are: (1) China's health care industry is in a deep crisis of trust, and the elderly generally consider the publicity related to health care products as a scam and show distrust in both traditional and new media. There is a subtle divergence in the attitudes of the elderly group towards the two media, with false promotional advertisements and branded fake news causing the elderly to lose confidence in the traditional media and to be more reluctant to trust the new media. This means that the trust of the elderly in health care products and the media that promote them is almost depleted, and trust needs to be rebuilt. (2) Media literacy, media trust,

中国知网 https://www.cnki.net

reliability perception and consumer involvement are antecedents of cognition-based trust. Cognition-based trust and consumer involvement are antecedents of affect-based trust. Cognition-based trust is still proved to be the foundation of affect-based trust. (4) The mechanism that media literacy plays a role in purchasing intention is complicated. Media trust and affect-based trust are necessary conditions, and cognition-based trust is a sufficient condition, which shows that the effect of media communication is related to the judgment of the elderly on the current environment. Digital back-feeding at home has provided some help for the elderly to identify false health information, but it still has some defects.

The research results focus on positive views of aging in health care consumption, emphasize the important influences of affect-based trust, enrich the existing research on the trust mechanisms of the elderly group under the background of collectivism, discover the complex mechanisms of media literacy in the online and offline consumption environments, and reveal the important role of interpersonal communication and media communication.

Key words: elderly; health care products; marketing communication; false advertising; influencing factors

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

引言.....1
一、文献综述与理论基础.....7
(一)保健品营销传播的研究回顾.....7
1.保健品及虚假宣传.....7
2.保健品营销及传播活动.....8
3.伪劣保健品营销传播及虚假宣传的研究回顾.....9
(二)积极老龄化理论的本土化实践.....10
1.老龄化理论中“健康”的发展.....10
2.积极老龄化的健康维度.....12
3.积极老龄化的保障维度.....13
4.积极老龄化的参与维度.....14
(三)传统信任理论的研究回顾.....14
1.信任的界定.....14
2.信任的中西方差异与分类.....15
(四)认知信任和情感信任的研究回顾.....16
1.认知信任和情感信任.....16
2.认知信任和情感信任的影响因素.....17
(五)刺激-机体-响应(SOR)理论模型的研究回顾.....20
(六)研究方法.....21
(七)量化部分的问题提出.....22
二、定量研究:认知信任和情感信任的核心作用.....24
(一)理论模型.....24
(二)研究假设的提出.....25
1.有关认知信任和情感信任的假设.....25
2.有关媒介素养与媒介信任度的假设.....26
3.有关可靠性感知的假设.....28
4.有关消费者涉入度的假设.....29
5.有关中介效应的假设.....29
(三)变量测量与问卷设计.....30
1.媒介素养.....30
2.媒介信任度.....30
3.消费者涉入度.....30
4.可靠性感知.....31
5.认知信任.....31

中国知网　https://www.cnki.net

6.情感信任.....31
7.保健品购买意愿.....32
(四)数据收集与描述性统计.....33
(五)测量模型检验.....34
1.信度分析.....34
2.效度分析.....36
(六)结构模型检验.....36
1.直接作用检验.....36
2.中介效应检验.....38
3.假设结果汇总.....39
(七)多群组检验.....40
1.性别组别差异.....40
2.年龄组别差异.....41
3.受教育程度组别差异.....41
(八)结论、讨论与问题的提出.....42
1.虚假保健品营销中情感信任比认知信任作用更大.....43
2.老年人对保健品广告存在传统媒介与数字媒体的信任分化.....44
3.媒介素养的影响机制复杂.....45
4.可靠性感知是最重要的前因变量.....46
5.定性研究部分问题的提出.....47
三、定性研究:不知如何信任的僵局.....48
(一)巩固情感:保健品营销中的人际传播建立强连接.....50
1.塑造的“孝子”人设.....50
2.情感支持的“大家庭”.....51
(二)传统媒介:草木皆兵,难以信任.....53
1.“狼来了”效应:消耗殆尽的信任难以重建.....54
2.“披着羊皮的狼”:漏洞中的品牌假新闻.....55
(三)新媒介:网课直播新套路.....57
1.躲在网络监管死角的养生微信群.....57
2.“新瓶装旧酒”的健康网课直播.....59
(四)媒介素养.....61
(五)保健产品消费中的积极老龄观.....63
1.老年人追求健康与社会参与的积极心态.....63
2.家庭数字反哺的积极帮助.....65
四、结论.....68
(一)结论.....68
1.信任的核心作用.....69
2.信任危机与媒介偏见.....70

中国知网 https://www.cnki.net

(二)局限性与展望 71
参考文献 73
附录一:老年人购买保健品情况的问卷 84
附录二:受访者基本资料 87
附录三:访谈提纲 88

中国知网 https://www.cnki.net

引　言

随着收入水平和消费水平的提升，我国国民蛋白质缺乏和热能缺乏的现象得到了明显的控制，但仍然普遍存在维生素和无机盐等微量营养素缺乏的问题，正确适当地使用保健品能够补充人体缺少的微量元素[1]。特别是老年群体，在没有基础疾病的情况下，也可以通过食用保健品来补充因身体机能的衰老而流失的钙和各类维生素，使身体更加健康。这一内容与积极老龄化和“健康中国”政策所提倡的健康养老契合。保健品行业提供优质、正规的保健品，老年人正确认知和选择适合自己的保健品，是从保健层面实现健康养老的关键之一。

“互联网+”行动遇上积极老龄化和“健康中国”政策推进老年健康的大环境时，给保健品带来新的市场机遇。保健品不再仅限于传统的销售模式，网络购物等数字媒体平台的加入为保健品注入新的活力。数字化的不断渗透，也让老年群体成为了网络新生力量和消费新增长点。《银发经济崛起——2021 老年用户线上消费报告》显示，2021 年前三季度京东平台上线的老年适用品销量同比增长 73%，健康服务类商品数量同比增长超过 10 倍，市场需求逐渐旺盛。[2] 数字媒体为老年群体通过消费提升健康提供了更多的渠道。

然而保健品的使用价值表现在调节人体机能方面的作用过程相对缓慢，并不能像药物拥有立竿见影的效果[3]。一些无良的保健品商家便抓住老年消费者为了健康而急于求成的心态，把保健品包装成“神药”，除了通过传统媒体进行广告宣传外，还通过数字媒体传播错误健康信息的软文，或刷屏的广告轰炸以售卖生产的三无产品，并且衍生出一些“有剧本”的新套路，[4]、[5]让老年消费者防不胜防。《老年人消费状况调查报告》（2017）

[1] 新浪财经：《刘天鹏教授：对保健品要科学认知 不能期待过高也不用全盘否定》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1694296119140025599&wfr=spider&for=pc，2021 年 3 月发布，2023 年 3 月最后访问。

[2] 中国青年报：《京东发布“银发经济”大数据：老年用户网购销量同比增长 4.8 倍》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1713595300505123478&wfr=spider&for=pc，2021 年 10 月发布，2023 年 3 月最后访问。

[3] 新浪财经，同前注[1]，第 1 页。

[4] 扬子晚报：《花 15400 元微信看病，却入了特大性保健品诈骗团伙的坑》，https://www.yangtse.com/zncontent/476012.html，2020 年 4 月发布，2023 年 3 月最后访问。

[5] 中国新闻网：《广州一特大“保健品”诈骗集团被端掉 225 人落网》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1638132283449037229&wfr=spider&for=pc，2019 年 7 月发布，2023 年 3 月最后访问。

中国知网 https://www.cnki.net

显示，42.8%的老年人曾因购买保健品上当受骗[6]。《中老年人上网状况及风险网络调查报告》（2018）也指出，老年网民触网面临的风险之一是网络诈骗，其中保健品诈骗最为突出[7]。2022 年 4 月，我国展开了全国范围的打击整治养老诈骗专项行动，重点受理处置以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等名义，对老年人进行网络诈骗的相关举报[8]。其中，有关“养老产品”诈骗的诸多案例与伪劣保健品营销有关。这也意味着，我国保健品营销乱象十分需要重视，因为伪劣保健品及虚假宣传现象的普遍存在会对老年群体造成损失，给社会、行业带来极为严重的不良影响：刚跟上数字化时代节奏的受骗老年群体在财产和健康两失的同时，也对数字媒体的使用失去了信心，保健品行业同样扣死了“欺诈”的帽子，未能跳出“屡战屡败，屡败屡战”的“信任危机”[9]。

老年人购买保健品是为了身体健康和提高生命质量的积极老龄化意识的实践。但是目前我国老年人由于对保健品缺乏科学客观的认知易出现两种极端态度：一部分人因为健康需求把养生治病的希望寄托在保健品上，或因为孤独将情感需求寄托于保健品销售人员，对保健品寄予过高的期望，从而出现了盲目相信的现象；另一部分人由于受到过假冒伪劣保健产品的侵害，对保健品出现了“保健品都是骗人的”这种全盘否定态度。[10]对保健品的态度无论是极端信任抑或极端不信任，都并非对保健品有科学客观的认知。因此，只有去厘清老年人在保健品消费中信任的作用机制，才能有助于老年人正确对待和选择保健品，维持老年人“健康-社会参与-健康”的良性循环。

老年人对保健品正确认知缺席的同时，保健品食品安全的法规和市场监管力度也未到位。虚假宣传的违法成本低[11]，执法部门收集证据难[12]，老年人受骗后维权成本高，保健品网店的销售许可、质量监管不到位[13]，给了制假售假的保健品厂家商家继

[6] 长春日报：《超四成老年受访者曾被骗买保健品》，http://news.youth.cn/jsxw/201703/t20170330_9383618.htm，2017 年 3 月发布，2023 年 3 月最后访问。

[7] 央广网：《中老年人上网状况及风险网络调查报告正式发布》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1604933687196965091&wfr=spider&for=pc，2018 年 7 月发布，2023 年 3 月最后访问。

[8] 百度百科：《全国打击整治养老诈骗专项行动》，https://baike.baidu.com/item/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E6%89%93%E5%87%BB%E6%95%B4%E6%B2%BB%E5%85%BB%E8%80%81%E8%AF%88%E9%AA%97%E4%B8%93%E9%A1%B9%E8%A1%8C%E5%8A%A8/61072104，2022 年 6 月发布，2023 年 3 月最后访问。

[9] 邵长凤，师东菊，张洋等：基于“互联网+”背景下保健品营销市场现状及策略研究，《中国市场》，2018 年第 5 期，第 127-128 页。

[10] 新浪财经，同前注[1]，第 1 页。

[11] 温佳冰，常路，张媛等：浅谈我国中老年人保健品市场的虚假宣传及其治理，《医学与法学》，2018 年第 10 期，第 64-67 页。

[12] 同上注。

[13] 常路，温佳冰：城市老年群体保健食品的认知与消费行为研究，《特区经济》，2019 年第 7 期，第 74-77 页。

中国知网 https://www.cnki.net

续欺骗消费者的机会。总而言之，我国保健品行业在数字媒体时代的破局，不仅回应了对老年人积极追求健康和融入数字化的期待，也在社会保障层面提出了新的要求，这与积极老龄化所倡导的健康和保障一致。

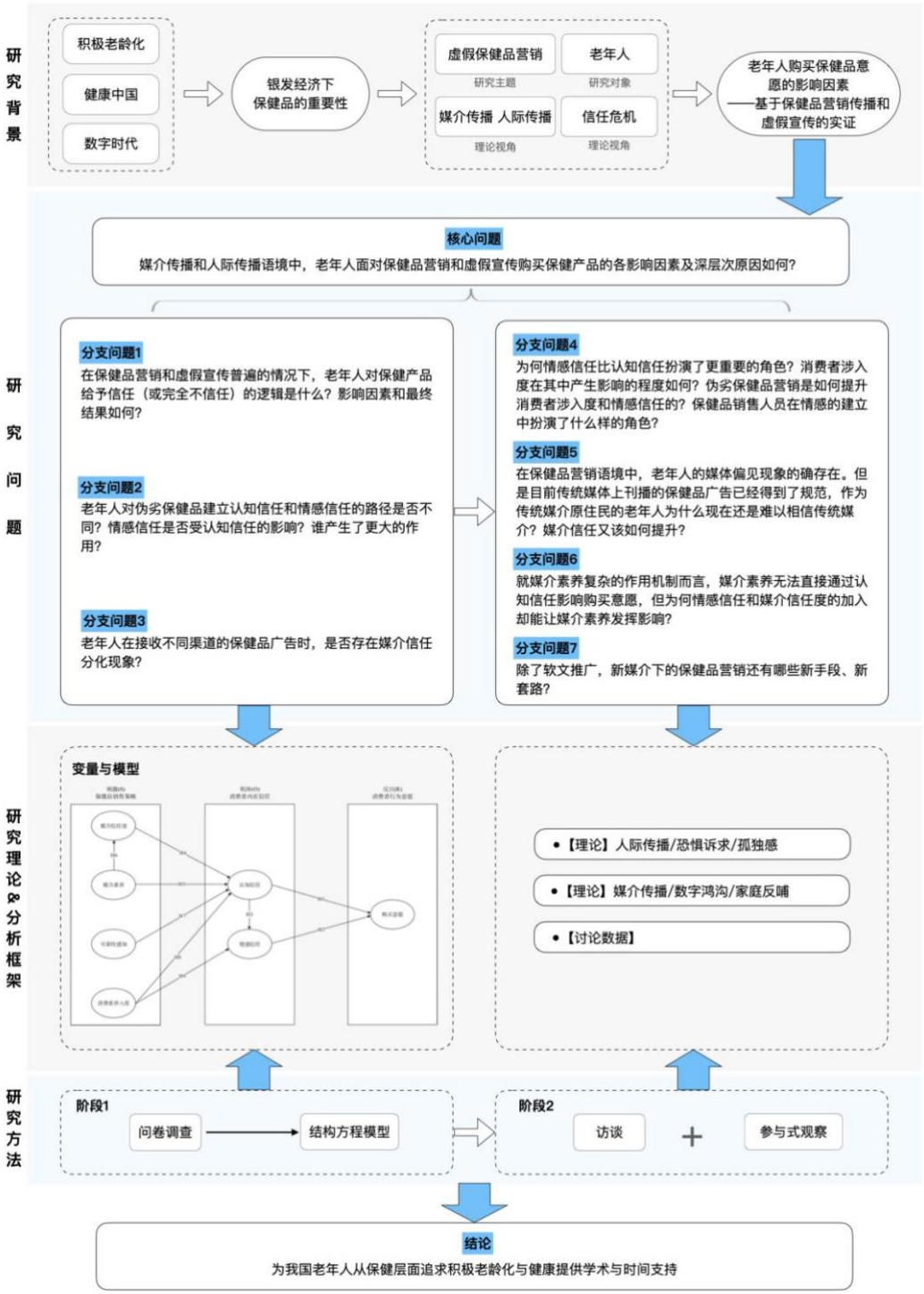

图 1.1 研究思路图

中国知网 https://www.cnki.net

本文将从积极老龄化的健康维度切入，同时就保障和参与维度进行探讨，以“信任”为核心深入分析购买老年虚假保健品营销的成因和影响路径。首先，本文将构建一个结构方程模型，从媒介传播的角度出发，将信任作为核心因素，考察传统媒体和新媒体背景下老年人的媒介素养和媒介可信度，以及老年人在保健品营销传播活动中的消费者涉入度和可靠性感知对保健品购买意愿的影响情况，找出是何种因素影响着老年人对伪劣保健品的信任和购买。其次，本文将结合人际传播和媒介传播，回归现实探讨这些成因为何为成因，结论又为何如此表现，进一步确证数据得到的结果，同时寻找降低保健品诈骗危害的解决方法，为老年人遇到的健康问题提供安全保障。通过上述探究，以回答本文的核心问题：**媒介传播和人际传播语境中，老年人面对保健品营销和虚假宣传购买保健产品的各影响因素及深层次原因如何？**本文的研究思路图如1.1所示。

从信任的角度研究老年人购买保健产品的影响因素，在理论上和实践上都具有重要的意义。在理论层面上，银发经济蓬勃下的老年群体消费行为逐渐被学界重视，有关保健品营销的研究虽有一定数量，但是其在理论运用上仍有欠缺。本文结合媒介传播与人际传播对我国保健品营销及虚假宣传的传播语境、购买意愿的影响因素进行深究，将我国保健品行业的信任危机作为切入点，将认知和情感信任、积极老龄化、刺激-机体-反应（SOR）作为理论基础，从认知和情感层面探究我国虚假保健品营销的内在机制，扩展现有研究和成果，也丰富了新媒体传播语境中保健品营销的实证。在实践层面上，本研究可以为我国老年群体从保健层面追求积极老龄化与健康提供支持，并为相关部门如何从保障层面帮助老年人正确、放心地选择保健品提供参考。同时，本研究综合我国老年群体的数字化现状，从健康消费视角为我国银发经济的发展提供新思路，并为我国保健品行业实现保健品营销传播正规化以达成良性的行业发展提供依据。

McAllister（1995）构建的认知和情感信任的模型[14]被广泛用于消费者行为[15]、[16]

[14] McAllister D J, “Affect- and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizatio ns,” *The Academy of Management Journal*, Vol.38:1, 1995, p.24-59.

[15] Punyatoya P , “Effects of cognitive and affective trust on online customer behavior,” *Marketing intelligence & planning*, Vol.37:1, 2019, p.80-96.

[16] 周彦莉，荣梅，冯群：社交消费中消费者信任及持久信任关系承诺的影响机制，《中国流通经济》，2020年第9期，第41-55页。

中国知网 https://www.cnki.net

或是组织中领导与成员信任[17]、[18]的研究中，多项研究进一步证实了认知和情感信任在中西方语境中的差异，但是所调查的研究对象的年龄都集中在 30 岁左右。本文的主要创新点为：将该理论模型研究几乎未曾给予关注的老年群体作为研究对象，探究更加注重集体主义和情感的中国老年人会在消费行为中的信任机制是如何运作的。同时，现有研究在论证认知和情感信任的作用机制时，或多或少考虑到了人际交流[19]或媒介使用[20]带来的影响，但未能综合考察人际传播和媒介传播发挥的作用，本文关注了两者的复合语境中认知和情感信任的建立会表现何种特殊性。

我国学界对积极老龄化理论的研究日益丰富，涉及到了养老模式[21]、社会参与[22]、社区服务[23]、老年教育与学习[24]、老年数字融入[25]等课题，但目前未有学者从保健层面出发，考察老年人通过使用保健产品的方式如何实现积极老化，以及保健行业能如何为我国推行“积极老龄化”政策助力。保健品营销乱象有关的实证研究[26]、[27]也更多关注的是传播效果、营销策略等主题，缺少了“积极老龄化”的视角。本研究突破了以往研究的局限性。

在研究案例上，先前以伪劣保健品营销和虚假宣传作为主题的研究多关注线下和传统媒介[28]、[29]上的营销，本文关注这两者的同时，还进一步关注了基于新媒介的保健

[17] Lascaux A & Kolesnikova I, “The emergence and evolution of cognition-and affect-based trust in Russian entre preneurial ventures,” *Strategic Entrepreneurship Journal*, Vol.15:4, 2021, p.685-715.

[18] 张慧，周小虎，高照龙：揭开信任的面纱——基于认知和情感视角的信任双中介模型，《科技管理研究》，2021 年第 9 期，第 154-160 页。

[19] 张慧，周小虎，高照龙，同前注[18]，第 4 页。

[20] Punyatoya P，同前注[15]，第 4 页。

[21] 陈际华：“时间银行”互助养老模式发展难点及应对策略——基于积极老龄化的理论视角，《江苏社会科学》，2020 年第 1 期，第 68-74 页。

[22] 胡宏伟，李延宇，张楚等。社会活动参与、健康促进与失能预防——基于积极老龄化框架的实证分析，《中国人口科学》，2017 年第 4 期，第 87-96+128 页。

[23] 姚进忠，潘静文：积极老龄化:社区为本老年社会工作服务项目行动研究，《社会工作与管理》，2018 年 3 期，第 12-19+58 页。

[24] 温书宇，李冰，穆星妍：助力新时代的积极老龄化:新型老年大学建设标准的探索与研究，《中国远程教育》，2022 年第 9 期，第 10-18+78 页。

[25] 刘述：积极老龄化视角下我国香港老年人数字融入路径研究，《中国远程教育》，2021 年第 3 期，第 67-75 页。

[26] 常路，温佳冰，同前注[13]，第 2 页。

[27] 冯桂平，刘爽：基于跨理论模型的老年人医疗保健品消费行为研究，《消费经济》，2018 年第 04 期，第 74-81 页。

[28] 于文洁，郑中玉。基于消费构建想象的社区——对某老年保健品消费群体及其行为的研究，《社会学评论》，2018 年第 1 期，第 80-92 页。

[29] 聂仕倩：针对老年人的保健品营销背后的传播学现象解读，《科技传播》,2015 年第 7 期，第 45-46 页。

中国知网 https://www.cnki.net

品营销。且该主题下的先前研究基本采用的是单一的研究方法[30]、[31]，本文运用了混合研究方法，通过创建结构方程模型，用数据解释伪劣保健品购买因素与购买行为之间的关系，加强了量化方面的论证，并结合访谈和参与式观察的结果，为保健品营销研究提供了更全面、完善的理论依据。

[30] 于文洁，郑中玉，同前注[28]，第 5 页。

[31] 王胜源，赵怡森：健康传播视野下保健品广告神话的建构与消解——从“权健事件”谈起，《新闻研究导刊》，2021 年第 10 期，第 77-79 页。

中国知网 https://www.cnki.net

一、文献综述与理论基础

（一）保健品营销传播的研究回顾

1. 保健品及虚假宣传

保健品涵盖保健食品、保健药品、保健化妆品、保健用品四大类，以保健食品居多，故大众通常认为保健品指保健食品。[32]对于国内约定俗称的保健食品，国外一般将其称为天然健康产品（NHP，Natural Health Product）。加拿大相关法律将 NHP 定义为自然界中发现的化合物，包括植物、动物、真菌、矿物质、维生素、必需脂肪酸、益生菌、顺势疗法药物和用于医疗目的的传统药物。[33]不同的是，国外的 NHP 被认为具有一定药用性，而我国规定的保健食品是不具备药用性的。据 2016 年中国《保健食品注册与备案管理办法》，保健食品可以定义为“具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品”[34]。因此，本研究所考察的保健品主要指以调节身体机能为目的、没有药用性的保健食品。

在我国，获得国家食品药品监督管理局审批认证的正规保健品的外包装上会标有“蓝帽子”标志，标志下方会标注出该保健食品的批准文号等信息。[35]伪劣保健品不具备上述特性，常常通过虚假宣传出现在人们的视野中。保健品虚假宣传内容主要包括了：虚构保健品的成分、功能、产地、保质期、检验报告等关键信息；宣扬保健品具有某种特殊的疾病预防和治疗功效，而保健品本身实际并不具备这种功效；刻意隐瞒保健品的适宜人群、不适宜人群等。[36]伪劣保健品营销及其虚假宣传是一个典型的欺诈行为和骗局，我国老年群体深受其害。

---

[32] 艾媒报告中心：《2019-2020 中国保健品行业研究报告》，https://report.iimedia.cn/repo12-0/39048.html，2020 年发布，2023 年 3 月最后访问。

[33] Boon H S & Kachan N, “Natural health product labels: Is more information always better?,” *Patient education and counseling*, Vol.68:2, 2007, p.193-199.

[34] 艾媒报告中心，同前注[32]，第 6 页。

[35] 百度百科：《蓝帽子标志》，https://baike.baidu.com/item/%E8%93%9D%E5%B8%BD%E5%AD%90%E6%A0%87%E5%BF%97/9461244?fr=aladdin，2021 年 12 月发布，2023 年 3 月最后访问。

[36] 韩玲，杨民：人口老龄化背景下保健品欺诈的刑法规制，《大连民族大学学报》,2019 年第 2 期，第 168-172 页。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 保健品营销及传播活动

美国市场营销学专家菲利普·科特勒提出：营销是一种帮助组织做想做的事的工具，营销的核心是运用以顾客为中心的理念，达成组织的目标[37]。Syed 等人认为，在医疗保健行业快速的发展中，由于可以帮助健康机构提高竞争力，营销工具被视作一种重要的商业资源，营销传播的渠道包括了广播、电视、广告牌、社交媒体和健康会议等。[38]Crié 和 Chebat 在健康和消费的视角下，进一步将生命科学营销、社会营销、健康服务营销整合，丰富了健康营销的概念[39]。

保健品营销即为保健品销售组织售卖保健产品盈利的手段，涉及了健康、社会、服务等内容，属于健康营销的范畴，营销的主要渠道也如 Syed 等人所述。在营销实践中，保健品营销的模式大致可分为直销模式和终端营销模式。直销模式是一种无店铺销售，通过直销员直接将产品送至消费者手中，减少中间销售和流通环节的成本，具体可分为单层直销和多层直销。采用直销模式的保健品企业主要有安利、权健。终端营销模式是指地面药店、专卖店进行保健品销售，保健品商家通过铺天盖地的广告宣传和概念炒作为产品引流，消费者前往终端店进行消费。采用终端营销模式销售的企业主要有三株、脑白金、巨人等。[40]在营销过程中，人际传播和媒介传播成为了保健产品信息流通的主要渠道。

直销模式由安利、雅芳等保健品牌引入国内，并不断发展，出现了依托健康会议形式的会议营销模式，让老年人可以免费体验和使用的体验营销模式，以产品优惠资格和质量吸引固定消费者的“会员制”营销模式等。保健品无良商家急于牟利，骗取老年消费者信任和财产，将直销演变为了传销。如权健企业采用会员制的销售方式吸引消费者，每个权健会员既是消费者，又是销售人员甚至经销商，不断发展线下会员，帮权健将“产品”转化为“货币”，深陷传销之中而不自知，成为了权健事件结束后承担最严重后果的群体。[41]

---

[37] 张琳：“4V”营销理论下的大学生媒介素养教育，《青年记者》，2019 年第 29 期，第 99-100 页。

[38] Syed M , Ahmed F , Zahid N , et al, “Essentials of Healthcare Marketing,” *Asian Journal of Medicine and Health*, Vol.19:2, 2021, p.73-79.

[39] Crié D & Chebat J C, “Health marketing: Toward an integrative perspective,” *Journal of Business Research*, Vol.66:1, 2013, p.123-126.

[40] 梁旭荣：我国保健品行业现状及发展趋势分析，《中国盐业》，2018 年第 3 期，第 31-35 页。

[41] 张静：国内保健品直销经营模式探究——以权健产品销售经营为例，《陕西行政学院学报》，2019 年第 2 期，第 82-88 页。

中国知网 https://www.cnki.net

健康营销本应通过“以病人为中心”的方法实现病人健康和消费者福利[42]，但是伪劣保健品的营销传播及虚假宣传违背了这一初衷，成为了我国养老诈骗的典型案例。因此，本文主要关注老年人因伪劣保健品营销受骗上当的影响因素和机制。同时，为了保证客观性，研究在设计和展开过程中所涉及到的保健品营销传播既包括了伪劣保健品，也包含了正规保健品，以避免陷入“老年人接触到的都是伪劣保健品和虚假宣传广告”和“老年人都会轻易被骗购买伪劣保健品”的预设中，因为并非所有媒介传播的保健品广告都是骗人的，并非所有老年人都无法分辨正规或伪劣保健品。

3. 伪劣保健品营销传播及虚假宣传的研究回顾

由于社会文化和老年群体的特殊性，虚假宣传伪劣保健品背景下的老年人消费行为的相关研究主要集中于国内学者。目前以老年人为研究对象展开的保健品消费研究已有一定数量（截止 2022 年 9 月 13 日，以“老年人”和“保健品”作为关键词在“中国知网”检索，检索结果有 517 篇学术期刊论文、学位论文 129 篇），但更多聚焦于消费情况、市场营销策略与受骗情况下的法理与对策分析。一部分学者对老年人非理性购买保健品的影响因素进行了探究，可概括为：（1）缺乏对保健品的基本认知[43]、[44]；（2）盲目相信广告“高科技化”“自然化”“神秘化”“故事化”的说辞或是“迷信”中医养生文化，认同“包装”出的“神医”“专家”[45]、[46]；（3）被“免费体验”“送小礼品”以及健康讲座等营销手段吸引[47]、[48]；（4）因为推销人员类似于儿女的热情关心，难以拒绝购买[49]、[50]。但目前大部分研究依旧是对保健品购买乱象进行的简单阐述和归纳，未能用科学的数据证明伪劣保健品购买因素与购买行为之间存在的因果关系和其中存在的逻辑性。

[42] Crié D & Chebat J C，同前注[39]，第 7 页。
[43] 曹冰，蒋文平，段林利等：重庆市市区老年人对保健品的认识及利用现况，《中国老年学杂志》，2013 年第 17 期，第 4231-4233 页。
[44] 叶少剑：中国保健品行业现状分析，《医学与哲学(人文社会医学版)》，第 2011 年第 5 期，第 28-30 页。
[45] 王胜源，赵怡森，同前注[31]，第 5 页。
[46] 谈煜鸿：老龄化背景下我国老年人保健品消费研究述评，《经济论坛》，2016 年第 6 期，第 108-111 页。
[47] 常路，温佳冰，同前注[13]，第 2 页。
[48] 马素雅：国内保健品市场主要营销模式与问题分析，《商业经济》，2019 年第 3 期，第 69-70 页。
[49] 聂仕倩，同前注[29] ，第 5 页。
[50] 于文洁，郑中玉，同前注[28] ，第 5 页。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）积极老龄化理论的本土化实践

1. 老龄化理论中“健康”的发展

世界人口日趋老龄化，全球所有国家都需要面临人口结构变化带来的一系列问题。我国自 2000 年进入老龄化社会以来，老龄化发展迅速，成为了世界上人口老龄化速度最快的国家之一。第七次人口普查数据显示，我国 60 岁以上人口已超过 2.6 亿，表现出未富先老、老龄化速度快的两大问题。面对我国社会进入快速老龄化进程的状况，十九届五中全会公报首次提出要“实施积极应对人口老龄化国家战略”，将积极应对人口老龄化上升到国家战略高度。而后，中共中央、国务院于 2021 年印发了《关于加强新时代老龄工作的意见》，新亮点可以总结为“用积极老龄观指导健康老龄化”。其中，积极老龄观与消极老龄观形成鲜明对比，要求“积极看待老龄化现象，积极应对老龄化挑战，积极创造老龄社会价值”[51]、[52]。2022 年，国务院办公厅印发的《“十四五”国民健康规划》也明确要求，提高老年人主动健康的能力需要树立健康老龄化、积极老龄化的观念。[53]为解决中国的老龄化问题，我国不断转变思路，构建积极老龄化的政策支持体系，大力倡导、稳步推进积极老龄化战略。

世界卫生组织（WHO）在 1987 年首次提出了“健康老龄化”概念，并在 1990 年的哥本哈根世界老龄大会上将“健康老龄化”作为应对人口老龄化的一项发展战略。健康老龄化理论的提出让被忽视的老年问题得到了重视，彼时学者们一致赞成“健康老龄化”的重点是老年群体追求健康长寿[54]，却未深入探讨老年人为什么要保持健康长寿，同时该理论对老年人的社会权利缺乏关注，仍暗含着将老年人视为社会负担的消极老龄观。[55]在 2002 年召开的第二届老龄问题世界大会上，世界卫生组织（WHO）在“健康老龄化”的基础上进一步提出了更加全面“积极老龄化”。相比健康老龄化理论，积极老龄化理论明确指出了老年人保持“健康”的目的是“参与社会、经济、文化和公共事务，成为社会财富

[51] 光明网：《“积极老龄观，健康老龄化” 新时代老龄工作的重磅文件来了！》，https://m.gmw.cn/baijia/2021-11/25/1302693741.html，2021 年 11 月发布，2023 年 3 月最后访问。
[52] 刘远立：树立积极老龄观 促进健康老龄化，《行政管理改革》，2022 年第 4 期，第 15-20 页。
[53] 中工网：《低龄老人“主动健康”需跨越几道槛？》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1743601013175505835&wfr=spider&for=pc，2022 年 9 月发布，2023 年 3 月最后访问。
[54] 王洵：“健康老龄化”研究的回顾与展望，《人口研究》，1996 年第 3 期，第 71-75 页。
[55] 宋全成，崔瑞宁。人口高速老龄化的理论应对——从健康老龄化到积极老龄化，《山东社会科学》，2013 年第 4 期，第 36-41 页。

中国知网 https://www.cnki.net

的创造者和社会发展的积极贡献者”[56]。积极老龄化理论将健康、参与、保障视作三大核心支柱，其中“健康”是基础，“参与”是核心，“保障”是前提，这三大支柱构建起了老年人提高生活质量的良性循环——老年人在身体和心理上保持健康，可以积极参与到各类社会活动中，为社会创造价值，也能在需要帮助的时候得到来自国家和社会的安全保障。[57]对“健康老龄化”和“积极老龄化”的发展过程进行回顾，可以发现后者是对前者的完善和发展，“健康老龄化”成为了“积极老龄化”中“健康”维度讨论的内容，并被赋予“积极”和“主动”的关键词——老年群体应积极、主动地追求健康，以再实现社会价值。

《关于加强新时代老龄工作的意见》提出“用积极老龄观指导健康老龄化”的思想，正是“积极老龄化”理论中“健康”维度在我国落地生根后的本土化成果，还在实现“主动健康”的主题下对老年群体积极“参与”和社会各界积极提供“保障”提出了要求：在“老有所养”与“老有所为”相结合，强调多方参与、共建共享，即坚持政府、社会、家庭、个人共同参与、各尽其责，一方面打造老年友好型社会，另一方面引导老年人树立主动健康和终身发展理念，鼓励老年人积极面对老年生活，在经济社会发展中充分发挥作用。[58]

在“健康中国”和“积极老龄化”的战略背景下，经国家卫生健康委批准，由中国老年保健医学研究会和国家老年医学中心发起的中国老年大健康智库（以下简称智库）成立，以应对疾病老龄化、贫困老龄化等问题给社会发展带来的巨大挑战，为我国老龄化社会建设提供智力支持。[59]针对保健行业存在的问题和多部门联合整治“保健”市场乱象的百日行动，智库成员召开专门会议，以“保健产品与健康”为主题进行了深入探讨，反映出精准保健、科学保健对老年群体追求健康的重要性，并对保健产品行业在科学技术、行业自律、行业标准上提出了要求。[60]由此可见，使用保健产品被认同是老年人主动追求健康的渠道之一，老年人能够在政府、职能部门、社会组织、相关企业齐心协力的保障下放心选择保健产品，维持身体健康，进而参与到社会活动中。在此过程中，老年人追求健康的主动性、积极性不会因伪劣产品或虚假宣传等问题受到打击。这符合推进积极老龄化的国家战略的题中之意。因此，本文将“积极老龄化”作为理论基础，探讨我国老

[56] 宋全成，崔瑞宁，同前注[55]，第 9 页。

[57] World Health Organization: "Active ageing: A policy framework," https://apps.who.int/iris/handle/10665/67215, 发布于 2002 年 4 月.

[58] 刘远立，同前注[52]，第 9 页。

[59] 新华社：《中国老年大健康智库在京成立》，http://www.cncaprc.cn/?c=i&a=sousuo_mod&gjz=%E6%99%BA%E5%BA%93&id=2911，2018 年 11 月发布，2023 年 3 月最后访问。

[60] 华研科技：中国老年大健康智库“关于促进保健产品市场健康发展”的建议，http://www.51hykj.com/newsinfo/1073588.html?templateId=1133604，2019 年 3 月发布，2023 年 3 月最后访问。

中国知网 https://www.cnki.net

年群体的保健品消费行为。

2. 积极老龄化的健康维度

“积极老龄化”中的“健康”是一个动态的、全生命过程的概念[61]，是“参与”和“保障”的前提。健康不仅仅是生理上没有病痛或衰弱，更指躯体和心理上即精神层面都要处于完满的状态，所以积极老龄化中的健康是一个多维度的概念，包含了自测健康（self-rated health）、身体健康（physical health）和心理健康（mental health）[62]。这三者也体现在老年人通过选择保健产品主动追求更健康状态的过程中：老年人自我感觉的健康程度、患有病症的数量与严重程度或心理健康与需求，都能成为老年人购买保健产品的原因。

但在保健品消费的过程中，常常会出现老年消费者与保健品商家信息不对称的情况，前者是信息弱势方，后者却有着多元信息渠道的优势。信息不对称易引起保健品商家的事前机会主义行为[63]，除了正规保健品广告之外，一些销售伪劣保健品的不良商家以“王婆卖瓜，自卖自夸”的说辞和伪专业术语在电视、报纸杂志等传统媒介上或是微信、购物 App 等新媒介上对保健产品进行虚假宣传，对老年人进行“看病难，看病贵”“求医不如求己”“是药三分毒”等心理诱导。老年消费者由于媒介素养较低，未能对伪劣保健品进行正确感知，在销售者使用的恐惧诉求的刺激下，对自身健康状况的估计产生偏差，或是对已患病症的认知失去理性，无法有效辨认信息的真伪和产品功效的强弱，产生了不必要甚至错误的健康需求。有研究证实孤独感与老人的心理健康密切相关。[64]独居群体老人由于缺少家人陪伴，孤独感让他们产生了较强的情感需求，极易成为伪劣保健品销售者的目标对象。在伪劣保健品营销传播、虚假宣传和与保健品销售者的交往中，老年群体对其建立基于认知和情感的信任，进而产生购买伪劣保健产品的意愿。

[61] 邬沧萍，彭青云：重新诠释“积极老龄化”的科学内涵，《中国社会工作》，2018 年第 17 期，第 28-29 页。
[62] 蒋俏蕾，陈宗海：银发冲浪族的积极老龄化：互联网使用提升老年人主观幸福感的作用机制研究，《现代传播》，2021 年第 12 期，第 41-48 页。
[63] 刘燕：“机会主义行为”内容与表现形式的理论解析，《经济问题探索》，2006 年第 5 期，第 122-125 页。
[64] 胡怡雯：城市老年人微信使用与孤独感的关系研究，湘潭大学硕士学位论文，2020 年。

中国知网 https://www.cnki.net

林宝灯和姚金丽（2019）指出，老年消费者更容易因伪劣保健品受到伤害[65]。虚假宣传传递的错误信息不利于老年人主动、积极追求健康，损害了积极老龄化中作为基础的“健康”，也阻碍我国保健品行业的良性发展。只有解决这一问题，才能使积极老龄化政策的基础稳固。

3. 积极老龄化的保障维度

“积极老龄化”中的“保障”指国家不仅要保障老年人在社会、经济、人身安全上的需要和权利，也要保障老年人在失能时受到保护和照顾。与以老年人为主体的健康、参与维度不同，保障是对国家、政府、社会、社区甚至家庭提出的要求。[66]因此积极老龄化中的“积极”，不仅指老年人要以积极的态度面对老化，也指国家和社会要积极帮助老人实现自我价值。

在保健品购买的语境中，国家和政府能为老年人提供的保障更多是制度层面上的保障。我国新闻办于 2006 年发表的《中国老龄事业的发展》白皮书与积极老龄化呼应，在“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐”的目标之外增加了“老年人合法权益保障”的内容，并对老年医疗保健的保障提出了要求，[67] 但未对保健品行业展开详细的论述。针对保健品广告的虚假宣传，目前已有《广告法》《药品管理法》《药品广告审查办法》及《保健食品广告审查暂行规定》对保健品广告在广告内容、功效上的宣传提出了等一系列的规制，但是规制的内容模糊，且更多的是对传统媒体上保健品广告的约束，数字媒体平台上发布软文或进行网络直播的自媒体、自营号能够钻空子继续行骗。[68] 概言之，要让老年人能放心购买保健品、实行积极老龄化健康维度的实践，国家和政府无论是针对整个保健品行业还是聚焦于其中的保健品广告，都需要形成更严格的监督管理体系来为老年消费者提供保障。只有完善好积极老龄化中作为前提的“保障”，才能让老年人实现好对“健康”的追求。

[65] 林宝灯，姚金丽：中老年群体网络消费信任影响因素实证研究，《贵州商学院学报》，2019 年第 3 期，第 38-47 页。
[66] WHO，同前注[57]，第 10 页。
[67] 新华社：《“中国老龄事业的发展”白皮书》，http://www.gov.cn/jrzg/2006-12/12/content_467201.htm，2006 年 12 月发布，2023 年 3 月最后访问。
[68] 刘涛，周蔚昕，寇强：报纸药品及保健品广告违法现状与对策研究，《成都大学学报(社会科学版)》，2017 年第 2 期，第 15-20 页。

中国知网 https://www.cnki.net

4. 积极老龄化的参与维度

“积极老龄化”将“参与”视作是老年人享有的一项重要权利，它强调老年人是问题的解决者而不是制造者，是社会发展的推动者而不是拖累者。[69]实现健康和保障，都是为了老年人能够进行更好的社会参与。老年群体参加保健品营销活动也是社会参与的一种形式，但营销活动中往往设下诸多骗局，老年人在其中的社会参与不一定符合积极老龄化所提出的“具有社会价值”的要求。如何在保健品有关活动中实现积极的参与，也是本文研究的要点之一。

（三）传统信任理论的研究回顾

1. 信任的界定

有关信任问题的研究始于 20 世纪初，在过去的一个世纪里，学者们从心理学、社会学、经济学甚至现代生物学等不同角度出发，进行了如人际信任、社会信任、政治信任、制度信任等研究，信任理论不断被丰富。罗特（Rotter，1967）认为，“信任是个体对另一个人的言词、承诺以及口头或书面的陈述之可靠性的一般性期望，即信任是对他人言行方面可靠性的信任”[70]，这一看法将信任的定义收窄到“人际信任”的范畴。齐美尔（Simmel，1978）在《货币哲学》中指出“信任是社会中最重要的综合力量之一”[71]；而卢曼（Luhmanm,1979）在《信任与权力》中将信任视作“简化复杂性的机制之一”[72]；李伟民和梁玉成（2002）则把信任看作是一个民族或国家的文化和社会产物，“在思想观念形态之文化和制度规范形态社会的共同影响下，人们才得以确立相互之间应有的关系与信任”。[73]信任的阐释也从人际层面到社会层面，从心理机制层面到文化层面。

[69] 南方日报：《健康、参与、保障：积极应对人口老龄化的三大支柱》，https://theory.southcn.com/node_4274ee5d35/7f7cbd011a.shtml，2021 年 4 月发布，2023 年 3 月最后访问。

[70] Rotter J B, “A new scale for the measurement of interpersonal trust 1,” *Journal of personality,* Vol35:4, 1967, p.651-665.

[71] Simmel G, *The philosophy of money*, Lonjdon: Routledge, 1978, p.178-179.

[72] Luhmann N, *Trust and power*, Chichester: John Wiley & Sons, 1979, p.71-72.

[73] 李伟民，梁玉成：特殊信任与普遍信任:中国人信任的结构与特征，《社会学研究》，2002 年第 3 期，第 11-22 页。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 信任的中西方差异与分类

信任根植于文化特征[74]。中国社会是一个关系本位的社会，多位学者的研究证实了中西方信任由于文化不同而大相径庭[75]、[76]。西方人在建立信任关系的过程中，信任者与被信任者的个人特征独立于关系因素，信任者是相对独立、可理性选择的。而生活在集体主义文化背景下的中国人，其人际关系很大程度是受到具有情感成分的“关系”影响的[77]。关系作为一种结构性力量影响了信任的建立方式，从人际关系中取得对他人的信任是中国文化、社会、历史的延伸[78]。因此，中国文化语境下的信任具有了不同内涵，更值得我们去考察其机制与影响因素。

由于研究角度和文化背景的不同，不同学者以不同标准和维度对信任进行了更为细致的分类，当前有关信任类别的建构多是依据“二分建构”或“三分建构”的范式。西方学者对信任的分类主要有：认知信任和情感信任[79]；人际信任和制度信任[80]；非自利型信任和动机型信任[81]；计算性信任、知识性信任和认同性信任[82]。国内学者根据中国人信任的结构和特征，或是将信任分为了特殊信任与普遍信任，认为中国人会以血缘、地缘关系为信任边界，对“自己人”给予特殊信任，对外人给予普通信任；[83] 或是将中国人的信任分为制度信任、关系信任、情感信任[84]。然而，由于中国人对公共领域和私人领域的理解不够清晰，这三种信任的边界也就比较模糊。总而言之，中国人的信任除了包含理性之外，被情感和关系支配的特点更为显著和重要。

[74] Boštjančič E, Ismagilova F & Maltcev A, “The Relationship between Control over a Deal and Cognitive-Based Trust in an International Business Partnership,” *Organizacija*, Vol.53:2, 2020, p.95-110.
[75] Migge T , Kiffin-Petersen S A & Purchase S, “When Western measures meet Eastern perspectives: A prototyping analysis of xinren in buyer-seller relationships”, *Industrial Marketing Management*, Vol.91, 2020, p.129-141.
[76] Bedford O, “The relation between guanxi and interpersonal trust in the workplace,” *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 2021, p.1-20.
[77] Migge T , Kiffin-Petersen S A & Purchase S, 同前注[75]，第 13 页。
[78] 薛天山：中国人的信任逻辑，《伦理学研究》，2008 年第 4 期，第 70-77 页。
[79] McAllister D J, 同前注[14]，第 4 页。
[80] Zucker L G, “Production of trust: Institutional sources of economic structure 1840–1920,” *Research in organizational behavior,* 1986, p.53-111.
[81] Nooteboom B, Berger H & Noorderhaven N G, “Effects of trust and governance on relational risk,” *Academy of management journal*, Vol.40:2, 1997, p.308-338.
[82] Roderick M K & Tom R T, *Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research*, SAGE Publications, 1995, p.114-139.
[83] 杨慧：现代社会的信任重构，《中国特色社会主义研究》，2020 年第 2 期，第 77-82 页。
[84] 徐尚昆：信任结构与信任重构论析，《中国特色社会主义研究》，2021 年第 1 期，第 71-79 期。

中国知网 https://www.cnki.net

目前，McAllister（1995）基于认知和情感的信任模型已被学界广泛使用，因为以交易成本理论和在位贡献理论为基础将信任划分为的认知信任和情感信任更能减小信任内涵的位移。[85] 后续的研究也证明了无论是在西方语境中还是在中国背景下，认知信任和情感信任是两个独立的、具有区别的概念，且以不同的方式发挥作用。[86]、[87]保健品虚假宣传渠道可以分为两类，一是通过传统的大众媒介和社交媒体播出保健品广告，二是通过线下活动（健康讲座、免费义诊、免费体检、小礼品赠送）和后续的情感介入（上门拜访、建立“亲人”关系）推销保健品。前者的传播效果更多取决于理性认知，后者则有着更多的情感成分。因此本章认为，认知信任和情感信任建立的路径是不同的，老年人对保健品的认知信任产生于对媒介广告和宣传话术的理性解读，接触的对象是媒介和保健品商家；对保健品的情感认知产生于对营销活动的感性参与，接触的对象是保健品推销者。因此，本研究分别从认知路径和情感路径出发，考察老年人保健品使用中的信任问题。

Urala 和 Lahteenmaki（2004）编制的保健品态度量表中，信任度是一个重要的测量维度，指个人对保健品功能和广告宣传的信任程度。信任度越高，个人对保健品的态度越积极，更倾向于购买和服用保健品。[88] 本研究认为，老年人购买保健品，不仅会根据自身的认知对保健品产品本身建立正向程度的信任，也有会对保健品推荐者建立基于人际或组织正向程度的信任、对播放保健品广告的特定媒介建立正向程度的媒介信任等。因此，本章中的信任是广义的，因为老年人购买保健品时信任的对象并不仅限于具体个人，还包括了组织和媒介。

（四）认知信任和情感信任的研究回顾

1. 认知信任和情感信任

认知信任是基于对他人可信程度的理性考察而产生的信任，情感信任是基于强烈的

[85] 张慧，周小虎，高照龙，同前注[18]，第 4 页。
[86] Punyatoya P，同前注[15]，第 4 页。
[87] Chua R Y J, Morris M W & Ingram P, “Guanxi vs networking: Distinctive configurations of affect-and cognition-based trust in the networks of Chinese vs American managers,” *Journal of international business studies*, Vol.40:3, 2009, p.490-508.
[88] Urala N & Lähteenmäki L, “Attitudes behind consumers' willingness to use functional foods,” *Food quality and preference*, Vol.15:7-8, 2004, p.793-803.

中国知网 https://www.cnki.net

情感联系而产生的信任。[89] 它们的前因变量和后果变量既有相同也有相异之处[90]。

Tomlinson 等人（2020）将认知信任和情感信任同信任的另一个范式结合考虑，指出能力（Ability）和行为完整性（Behavioral Integrity）是基于认知的信任的最重要预测因素，而仁慈（Benevolence）和价值观一致性（Values Congruence）是基于情感的信任的最重要预测因素。[91] 认知信任是由知识驱动且更多取决于信息本身，而情感信任更多取决于双方属性及情感关系强度，表现在基于对方关心，感情的加深会让人们的信任超出现有知识证明的范围。[92]、[93]可见，对认知信任和情感信任前因尚未达成理论共识。

2. 认知信任和情感信任的影响因素

(1)媒介素养

对媒介发布保健品广告的信任表现为公众信任某种媒体及其发表的信息，除了源于媒体自身的属性以及公众对该媒体的距离、接触频率和使用情况[94]，还与公众自身的媒介素养相关[95]。所以媒介素养水平不仅会影响老年消费者对媒介的信任度，还会影响老年消费者对保健品广告在认知层面上的信任。

有研究发现，老年消费者对保健品的认知主要来源于电视广播这类传统媒体[96]。但随着移动网络的发展与智能手机的普及，电视、报纸杂志等传统媒体上的保健品广告逐渐开始在微信、淘宝等新媒体平台“施展拳脚”，并衍生出新的模式：软文推广，即写手通常会以“健康科普”“用户体验”“测评笔记”的形式将广告隐藏在文中，用“实诚型”与“煽动型”的话术技巧，宣传健康知识、养生方法、亲测使用心得等内容，配合恐

[89] McAllister D J, 同前注[14]，第 4 页。

[90] Johnson D & Grayson K, “Cognitive and affective trust in service relationships,” *Journal of Business research*, Vol.58:4, 2005, p.500-507.

[91] Tomlinson E C, Schnackenberg A K, Dawley D, et al, “Revisiting the trustworthiness–trust relationship: exploring the differential predictors of cognition-and affect-based trust,” *Journal of Organizational Behavior*, Vol.41:6, 2020, p.535-550.

[92] 韩剑磊，明庆忠，史鹏飞等：视频社交媒体用户的旅游行为意向影响因素分析——基于信任的中介效应，《旅游研究》，2021 年第 4 期，第 1-14 页；

[93] Johnson D & Grayson K, 同前注[90]，第 15 页。

[94] 贾哲敏，孟天广：信息为轴:新冠病毒疫情期间的媒介使用、信息需求及媒介信任度，《电子政务》，2020 年第 5 期，第 14-27 页。

[95] 谢金文，王健美：社会信任的多学科研究及影响因素，《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》，2021 年第 6 期，第 63-73 页。

[96] 贾敏敏，孙建萍，杨支兰等：老年人保健品知-信-行研究进展，《中国临床护理》，2018 年第 5 期，第 448-451 页。

中国知网 https://www.cnki.net

惧诉求的手段，最后顺势进行保健品推销。[97] 这类保健品软文推广发布平台多为微信、淘宝等在我国影响力较大、老年人使用较多、最信任的新媒体平台[98]。但是与传统媒体不同的是，数字媒体平台上保健品软文推广的发布者包括了保健品商家自营账号、大 V 账号和普通用户账号，甚至老年人的转发，正规保健品和伪劣保健品广告混杂在一起，大量健康信息亦真亦假。传统媒介上发行保健品广告更加严格，而新媒介上的保健品广告、软文难被监管。由于老年人通过新媒介接收信息的过程中缺少把关人，辨别信息的真伪更依靠自身，所以媒介素养在新媒体使用的语境中更为重要。

⑵媒介信任度

Strömbäck 等人（2020）将受众视为委托人，将媒介视为受托人，把媒介信任定义为受众和媒介之间的一种委托关系，因为“受众期望在与媒介的互动中得到益处”。[99] 从媒介反映论视角来看，受众对媒介的信任来源于媒介内容的真实性以及媒介机构的权威性[100]。在对商品产生信任的机制中，用户个体的认知和广告生产者的信用在用户的信任建构中扮演着重要角色[101]。所以在保健品消费的语境中，媒介作为广告生产者，其信用或是值得被信任的程度，会影响消费者对商品产生信任。目前国内相关研究对媒介信任度（Media Trust）和媒介可信度（Media Credibility）这两个概念存在混用的情况[102][103]。实际上，媒介信任度的主体是受众，受众对媒介发起了一种关系，即信任[104]。而媒介可信度的主体是媒介，是媒介本身的一个属性，在狭义上的媒介可信度指无关传播内容的、令受众没有怀疑而去信赖的一种品质。[105]在保健品消费的语境下，老年人希望通过可靠的媒介获取能让他们放心的保健品信息，这可以理解为一

[97] 中新经纬：《软文写手把没用过的保健品"吹上天":一天写几十篇 精美图片配表情》，https://finance.sina.com.cn/consume/puguangtai/2020-08-31/doc-iivhvpwy3999690.shtml?cref=cj，2020 年 8 月发表，2023 年 3 月最后访问。

[98] 严琳：新媒体影响老年人消费行为的理论机制研究——以广州市中心城区老年人为例，《中国商论》，2020 年第 21 期，第 69-71 页。

[99] Strömbäck J, Tsfati Y, Boomgaarden H, et al, “News media trust and its impact on media use: Toward a frame work for future research,” *Annals of the International Communication Association,* Vol.44:2, 2020, p.139-156.

[100] 江根源：媒介信任的解构与重构——评马妍妍博士的新作《信息时代媒介、受众与社会的关系研究》，《白城师范学院学报》，2020 年第 4 期，第 125-128 页。

[101] 程明，赵静宜：广告信任生成机制的新发展，《中南民族大学学报(人文社会科学版)》，2020 年第 1 期，第 143-147 页。

[102] 吴建：媒介可信度的实证研究——基于省域居民的大样本调查，《西南民族大学学报(人文社科版)》，2016 年第 2 期，第 147-152 页。

[103] 贾哲敏，孟天广，同前注[94]，第 16 页。

[104] Strömbäck J, Tsfati Y, Boomgaarden H, et al, 同前注[99]，第 17 页。

[105] West M D, “Validating a scale for the measurement of credibility: A covariance structure modeling approach,” *Journalism quarterly*, Vol.71:1, 1994, p.159-168.

中国知网 https://www.cnki.net

种想获得益处的委托关系，符合 Strömbäck 等人对媒介信任度的定义。因此本文采用媒介信任度来测量作为受众的老年人对刊播保健品广告的媒介的信任程度。

现有发现证明，媒介信任的水平，不仅取决于媒介本身的性质（报刊等传统媒介或是社交媒体等新媒介）[106]，也取决于媒介所报道的内容和选择的主题[107]。因此，本文探讨媒介信任度针对传统媒介或新媒介上的保健品广告及内容展开。

(3)可靠性感知

消费者基于认知建立信任的过程，不仅包括了对播发保健品广告的媒介产生信任，还包括了感知到保健品商家产生的可靠性，对保健品商家产生信任。对保健品商家的信任在于，保健品商家常常借助“高科技”“纯天然”“古法秘制”“家传秘方”等专业性术语，包装出“养生大师”“民族名医”“医学专家”，并以现身说法虚构出一个个相对完整的“患者绝症痊愈”的动人故事，让宣传产品的广告内容表现出更高的“专业性”，进而使老年人感知到所宣传保健品有很强的可靠性和有效性，对保健品商家产生更高的信任。[108]

(4)消费者涉入度

人的情感需要不断得到满足、宣泄和释放，在正常情感得不到满足和释放的情况下，商业就自然进入了情感世界，甚至人们会主动把情感卷入到售卖行为中。[109] 李涛等人（2018）发现，越是感到孤独的老年人，他们的保健支出的绝对水平和相对比重都会越高。产生这种影响的重要作用机制是社会互动，老年人在保健品消费的过程中与销售人员交流，有效缓解了孤独感。[110] 保健品销售人员通过陪老人聊天、下棋、打扫卫生、逢年过节送礼等，或是以认老人为“干妈”“干爸”的方式，建构了模拟性的“强关系”[111]，这种关系正是一种包含亲情和经济属性的双重关系。Dăniasă 等人（2010）指出，在营销

[106] Newman N, Fletcher R, Schulz A, et al, “Reuters Institute digital news report 2021,” *Reuters Institute for the study of Journalism*, 2021.
[107] Strömbäck J, Tsfati Y, Boomgaarden H, et al, 同前注[99]，第 17 页。
[108] 王胜源，赵怡森，同前注[31]，第 5 页。
[109] 淡卫军：情感,商业势力入侵的新对象评霍赫希尔德《情感整饰:人类情感的商业化》一书，《社会》，2005 年第 2 期，第 184-195 页。
[110] 李涛，徐翔，张旭妍：孤独与消费——来自中国老年人保健消费的经验发现，《经济研究》，2018 年第 1 期，第 124-137 页。
[111] 费爱华：从消费的空间到空间的消费与再生产——以保健品“联谊会”为例，《华东经济管理》，2010 年第 2 期，第 95-98 页。

中国知网 https://www.cnki.net

中积极情绪被证明发挥着重要作用，更能提高消费者的满意度[112]。在模拟性亲情空间中，保健品销售人员调动了老人们的积极情绪，老人自然对“干女儿”“干儿子”建立了基于情感的信任，愿意为了这份“亲情”买单，进而购买保健品。根据 Vaughn 提出的 FCB 网格模型商品的分类，保健品属于“高涉入-情感型”的商品，这一类商品通常采用情感策略进行营销。[113]有研究表明，产品消费者涉入度更高的老年人对保健品的购买意愿显著高于消费者涉入度低的老年人[114]。同时，伪劣保健品营销的案例都反映出，老年消费者可能会被增送小礼品、试吃试用体验等线下活动吸引，活动中销售人员会宣传其保健品用到的新技术、新成分，让老年人对保健品更加“了解”。老年人会根据自己的认知进行判断，若符合自己的认知，则会对保健品产生基于认知的信任。因此，老年人的保健品产品消费者涉入度也可以视作是认知信任和情感信任的前因。

（五）刺激-机体-响应（SOR）理论模型的研究回顾

Mehrabian 和 Russell 于 1974 年在心理学的基础上提出了刺激-机体-反应（Stimulus-Organism-Response，SOR）理论模型，该模型包含了刺激（Stimulus）、机体（Organism）和反应（Response），认为外界环境能够影响个体的认知、情绪，进而影响个体的行为。[115] 一个完整的 SOR 模型要具有刺激变量、一组或多组中介变量以及反应变量，通过中介变量可以很好地表达刺激和反应之间的关系。[116] SOR 理论模型后来成为研究和解释消费者使用行为、参与行为、购物行为的关键理论之一，强调了个体的心理作用在外部刺激和行为反应之间的重要作用，并被广泛引入到了不同的研究情境中，内容也不断丰富。

SOR 理论模型已被证实能够用于消费者购物行为的研究，亦可用于分析和研究老年消费者保健品购买行为。Liu 和 Lu（2020）以 SOR 理论和认知-情感人格系统理论为

[112] Dăniasă C I, Tomiţă V, Stuparu D, et al, “The mechanisms of the influence of viral marketing in social media,” *Economics, Management & Financial Markets*, Vol.5:3, 2010, p.278-282.

[113] Vaughn R, “How advertising works: A planning model,” *Journal of Advertising Research*, Vol.26:1, 2986, p.27-33.

[114] 杨逊，余林：保健品广告对老年人的影响研究——卷入强度，诉求方式影响保健品广告在老年人中的效果研究，《西南农业大学学报（社会科学版）》，2014 年第 1 期，第 162-165 页。

[115] Mehrabian A & Russell J A, *An Approach to Environmental Psychology*, Cambrige: MIT Press, 1974, p.222-253.

[116] 史烽，孟超，李晓锋等：基于 SOR 模型的网络团购消费者购买意愿研究，《商业经济研究》，2017 年第 20 期，第 53-55 页。

中国知网 https://www.cnki.net

基础，发现了工作场所安全氛围（S）可以通过作为中介变量的认知信任和情感信任（O）影响医务工作者的出勤和缺席（R）[117]。李琪等人（2020）整合了 SOR 理论模型和承诺信任理论，指出用户机体从用户情绪变化扩展到情绪和认知变化，外部环境刺激能够影响用户认知上的反应和情绪、情感上的反应，其中情绪、情感可分为积极和消极两类，认知主要指用户针对情景和行为的认知。[118]认知信任基于认知建立，情感信任基于情感建立，因此将认知和情感信任理论与 SOR 理论模型整合是符合逻辑的。

（六）研究方法

混合研究被视作是与定性研究和定量研究并列的“第三种”主要研究方法[119]，强调质性和量化方法二者不可偏废，体现了“质性”和“量化”研究者分别用一种方法来弥补另一种方法不足之处的思想[120]。在研究中不局限于一种方法，能够使得研究问题得到更深入、完善的回答。研究者通过整合和证实其中一种方法发现的结果，往往能对另一种方法发现的结论提供更好的证明。[121]不同于仅在得出研究结论后进行整合的多重方法（Multimethod），混合方法（Mixed methods）要求研究者在研究展开期间就实现各个方法的整合和实践相关的假设、原则、价值观的有机统一，因为形式上的方法混用并不能对现象获得更全面的了解和更深入的理解。[122]

使用混合研究方法的目的可以概括为加强研究的广度和深度，以获得更全面的验证和进行更深入的解释，为研究问题提供更丰富、更有力的答案。[123]纵观我国保健产品的现有研究，除对保健品购买乱象进行的简单阐述和归纳的文章外，实证类研究较

[117] Liu B & Lu Q, “Creating a sustainable workplace environment: Influence of workplace safety climate on Chinese healthcare employees’ presenteeism from the perspective of affect and cognition,” *Sustainability*, Vol.12:6, 2020, 2414.doi:10.3390/su12062414.

[118] 李琪，李欣，魏修建：整合 SOR 和承诺信任理论的消费者社区团购研究，《西安交通大学学报(社会科学版)》，2020 年第 2 期，第 25-35 页。

[119] Johnson R B, Onwuegbuzie A J & Turner L A, “Toward a definition of mixed methods research,” *Journal of mixed methods research*, Vol.1:2, 2007, p.112-133.

[120] 张绘：混合研究方法的形成、研究设计与应用价值——对“第三种教育研究范式”的探析，《复旦教育论坛》，2012 第 5 期，第 51-57 页。

[121] Johnson R B & Onwuegbuzie A J, “Mixed methods research: A research paradigm whose time has come,” *Educational researcher,* Vol.33:7, 2004, p.14-26.

[122] Johnson R B, Onwuegbuzie A J & Turner L A, 同前注[119]，第 20 页。

[123] ibid.

中国知网 https://www.cnki.net

少。其中，质性研究虽已有一定数量但比例不大，量化研究和混合研究的数量极少。研究方法范式单一化导致了现有研究成果在面对我国保健产品行业的实际问题时只能“隔靴搔痒”，因此，要规避经验性总结结论、寻找规律性证据来提升理论含量的同时，又要注意不能脱离实际，必须需要采用混合研究方法，在方法论上进行相互补充，获得相互支持的论据，统一为研究主题服务。

本研究采用了混合研究方法，并根据顺序解说型模式进行研究的设计，即量化数据先行，后通过质性数据对非预期结果进行更深入的分析和检验[124]，实现对研究发现的强化与深化。具体包含了量化和质化研究两个阶段：在量化部分，采用 SPSS28.0.0.1 和 SmartPLS3.0 对问卷调查收集到的数据进行分析，构建结构方程模型，探讨保健产品购买意愿的影响因素，验证认知信任和情感信任的中介效应；在质化部分，笔者从曾填写过问卷的受访者中选择了 8 位有较丰富保健品购买经验的对象进行了访谈，对上一部分中结构方程模型显示的结论提供更有力、全面、深入的解释，并寻找以年轻老年人为主要成员的微信养生群，展开参与式观察，对所得结论进行完善。

（七）量化部分的问题提出

我国保健品行业现面临着十分严重的信任危机。老年人对保健品的信任程度很极端，或十分信任以致迷信，或十分不信任以致抵制，缺少客观，不利于我国保健品行业的良性发展，也不利于老年人正确追求健康，所以本文将信任作为主要因素。同时，本文力求探究伪劣保健品购买因素与购买行为之间存在的因果关系和其中存在的逻辑性。基于此，本文提出以下问题：

QR1：在保健品营销和虚假宣传普遍的情况下，老年人对保健产品给予信任（或完全不信任）的逻辑是什么？影响因素和最终结果如何？

QR2：老年人对伪劣保健品建立认知信任和情感信任的路径是否不同？情感信任是否受认知信任的影响？谁产生了更大的作用？

有研究发现传统媒体是老年人获取保健品信息的主要来源[125]，以手机使用和互联

[124] Creswell J W, *A concise introduction to mixed methods research*, SAGE publications, 2014, pp.152.
[125] 贾敏敏，孙建萍，杨支兰等，同前注[96]，第 16 页。

中国知网 https://www.cnki.net

网使用为代表的新媒体使用未能对城市老年人的电视信任产生太大的影响[126]。但是由于近年来智能手机高度普及，老年人对数字媒体的认知度以及信任度不断提高，从最初对网络上一切事物的不信任、怀疑、试试看，到最后给予信任，他们的消费行为方式也在潜移默化中发生了改变。[127] 随着国家市场监督管理总局对传统媒体刊播的保健品广告审查力度加强，以及近年来社会对保健品诈骗案例的不断揭露，老年人虽然在一定程度上能够识别传统媒体上保健品虚假宣传的套路，但很难在面对数字媒体平台上保健品软文营销和剧本式圈套时做出清晰的判断。因此，在保健品消费中，老年人面对不同媒介提供的保健品广告和信息时可能会产生不同程度的信任，甚至会出现媒介信任分化现象。对处于不断正规化的过程中保健品行业而言，只有厘清信任分化的问题，才能分别从数字媒体和传统媒体入手为老年消费者提供最适合他们的健康信息普及和产品营销策略，实现积极老龄化之健康实践的落地。由于老年人从媒介接受到保健品相关信息，更多是对广告和产品建立的认知，因此提出研究问题：

QR3：老年人在接收不同渠道的保健品广告时，是否存在媒介信任分化现象？

[126] 李成波，杨茜，程云飞：新媒体使用对城市老年人电视信任的影响——基于西部三省市的实证调查分析，《特区经济》，2019 年第 10 期，第 103-106 页。
[127] 严琳，同前注[98]，第 16 页。

中国知网 https://www.cnki.net

二、定量研究：认知信任和情感信任的核心作用

（一）理论模型

本文基于 Mehrabian 和 Russell 的 SOR 理论模型，将商家、媒体的保健品销售策略（线下、线上传播）给老人带来的影响视作一种外部刺激（S），具体体现在老年人客观特征（媒介素养、消费者涉入度）和主观感知（可靠性感知、风险感知）的变化，将老年消费者个体视作具有认知和情感信任的有机体（O），在刺激的作用下产生的保健品购买意愿则被视作行为反应（R）。由此建构了一个基于认知信任和情感信任的双中介模型（图 2.1），探究老年人购买保健品的影响因素：

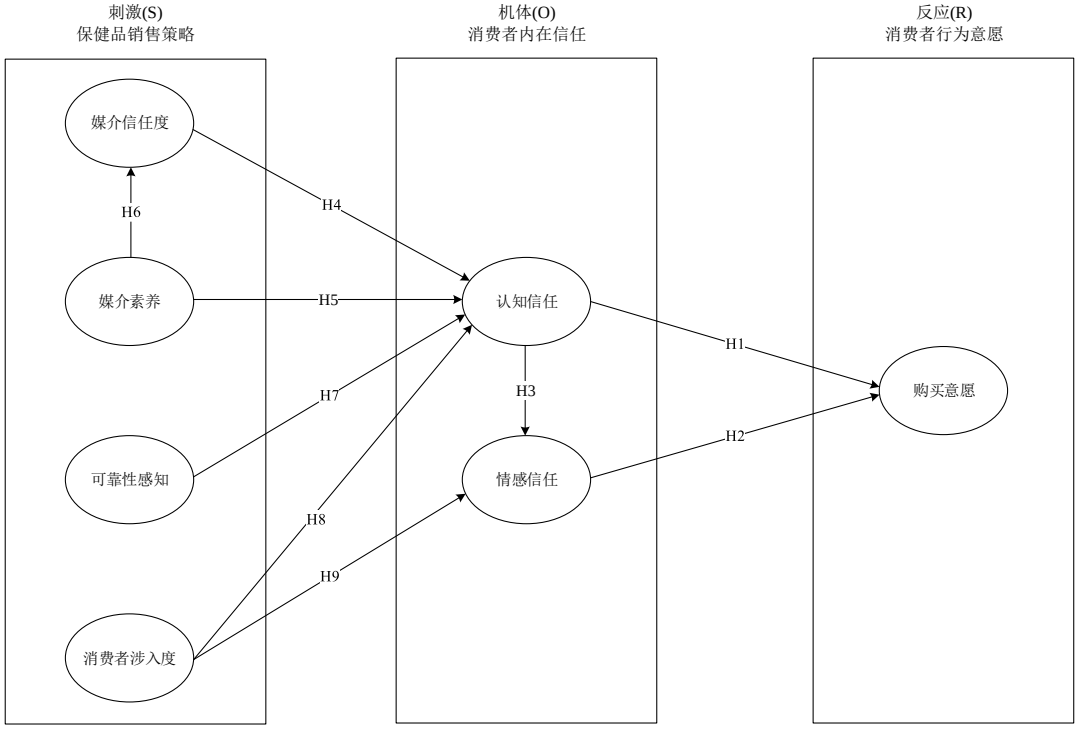

图 2.1 研究模型

中国知网 https://www.cnki.net

（二）研究假设的提出

1. 有关认知信任和情感信任的假设

多项研究已证明，消费者的信任是形成购买意愿的重要因素[128]、[129]。有学者以组织或企业为背景展开的研究证明，认知型信任与企业创新绩效之间存在倒 U 型关系，即认知型信任到一定值后，创新绩效反而会下滑。[130] 但老年人购买保健品并不是一个与保健品销售者“合作共赢”的过程，不会出现因一方高度信任而疏忽监督导致另一方造成破坏性结果，因此倒 U 型关系并不会出现在认知信任与保健品购买意愿之间。当用户形成认知信任时，他就愿意对所信任对象推荐的信息进行反应；当用户有着更强的情感信任，就会更愿意依赖所信任对象推荐的信息。[131] 此现象表现在老年消费者身上时，认知信任和情感信任的增加，会让他们对保健品信息做出反应、产生依赖，进而出现保健品购买行为。

因此，本文提出假设：

H1：老年人对保健产品的认知信任正向影响购买意愿。

H2：老年人对保健产品的情感信任正向影响购买意愿。

由于认知信任和情感信任形成的前提条件和内涵都有所不同，所以对保健品购买意愿产生的影响存在差异。Vivek 等人（2012）发现，情绪对消费者购买行为的影响比理性或认知因素更能起到决定性的作用[132]。所以本章会进一步探究认知信任和情感信任对老年消费者购买意愿所产生影响的异同。就认知信任和情感信任之间的联系而言，McAllister（1995）指出，高水平的认知信任会提高情感信任，认为情感信任是建立在认

[128] Oliveira T, Alhinho M, Rita P, et al, “Modelling and testing consumer trust dimensions in e-commerce,” *Computers in Human Behavior*, Vol.71, 2017, p.153-164.

[129] Bashir S, Anwar S, Awan Z, et al, “A holistic understanding of the prospects of financial loss to enhance shopper's trust to search, recommend, speak positive and frequently visit an online shop,” *Journal of Retailing and Consumer Services,* Vol.42, 2018, p.169-174.

[130] 程德俊，宋哲，王蓓蓓：认知信任还是情感信任:高参与工作系统对组织创新绩效的影响，《经济管理》，2010 年第 11 期，第 81-90 页。

[131] 韩剑磊，明庆忠，史鹏飞等，同前注[92]，第 16 页。

[132] Vivek S D, Beatty S E & Morgan R M, “Customer engagement: Exploring customer relationships beyond purchase,” *Journal of marketing theory and practice*, Vol.20:2, 2012, p.122-146.

中国知网 https://www.cnki.net

知信任基础之上的[133]。后续的一些实证研究也证实了 McAllister 的这一观点[134]、[135]。但也有学者认为上述所说是在西方文化下呈现的特点，情感信任在中国背景下可能扮演着更重要的角色[136]。Ng 和 Chua（2006）甚至发现基于情感的信任似乎对基于认知的信任有“溢出”效应，即人们可以通过建立高水平的情感信任培养认知信任，因为相比较在个人主义文化中最重要的认知信任，情感信任在集体主义文化中更受重视。[137] 而目前，国内学者在实证研究中很少讨论认知信任和情感信任两者是否对彼此存在着作用机制。探究我国老年人保健品消费中究竟是认知信任还是情感信任作为基础存在，有助于厘清我国老年人成为保健品诈骗高危人群的根本原因（老年人对保健品的认知匮乏或是由于没有子女陪伴的孤独需要对他人给予情感寄托），为国家进一步完善好与保健品市场相适应的管理机制提供根据。

因此，本文提出研究假设：

H3:老年人对虚假宣传保健产品的认知信任正向影响情感信任。

2. 有关媒介素养与媒介信任度的假设

当今以微信为代表的数字媒体逐渐深入老年群体，成为了老年人寻求健康信息的重要渠道，也为老年人的媒介素养提出了新要求。媒介素养包括了受众面对媒介所提供信息的评价能力（真实性、权威性）和分析能力（信息真伪辨别、信息处理策略）[138]，媒介素养水平越高的人被证明健康知识水平更高[139]，这也意味着他们能更好地分辨媒介提供的健康信息。Lee（2018）认为个人的媒介素养水平的提升可以很好地打击假新闻，消费者识别虚假信息的能力可以通过媒介素养教育来提升[140]。从前主要依靠电视、广

[133] McAllister D J, 同前注[14]，第 4 页。

[134] Wang W, Qiu L, Kim D, et al, “Effects of rational and social appeals of online recommendation agents on cognition-and affect-based trust,” *Decision Support Systems*, Vol.86, 2016, p.48-60.

[135] Punyatoya P , 同前注[15]，第 4 页。

[136] Zhu Y & Akhtar S, ”The mediating effects of cognition-based trust and affect-based trust in transformational leadership's dual processes: evidence from China,” *The International Journal of Human Resource Management*, Vol.25:20, 2014, p.2755-2771.

[137] Ng K Y & Chua R Y J, “Do I contribute more when I trust more? Differential effects of cognition-and affect-based trust,” *Management and Organization review*, Vol.2:1, 2006, p.43-66.

[138] 刘鸣筝，陈雪薇：基于使用、评价和分析能力的我国公众媒介素养现状，《现代传播(中国传媒大学学报)》，2017 年第 7 期，第 153-157 页。

[139] 闫文捷，张军芳，朱烨枢：“高选择媒体环境”下的媒介素养及其社会影响——基于新冠疫情期间中国城市居民的问卷调查，《新闻与写作》，2020 年第 8 期，第 31-42 页。

[140] Lee N M, “Fake news, phishing, and fraud: a call for research on digital media literacy education beyond the classroom,” *Communication Education,* Vol.67:4, 2018, p.460-466.

中国知网 https://www.cnki.net

播、报纸传播的保健品虚假广告，也将微信群、朋友圈、公众号或是网购平台作为了宣传的新渠道。但媒介素养水平较低的老年消费者，无论是在面对电视购物频道、广播和报纸虚假宣传的保健品，还是在面对朋友圈中的“医药微商”或是自称“医疗保健专家”的公众号、网店时，都很容易轻信其说辞，最后受骗上当。[141]

同时，Fisher（2016）也指出，目前存在普遍着“媒体偏见”的现象，即受众在一定程度上认为媒体是“不如实报道”“非公平客观”“假信息无处不在”的[142]，所以媒介信任度下降并不是因为新闻报道有偏见，而是受众采取了偏见的态度对待媒介。Vraga 等人（2012）认为，加强受众的媒介素养能够让受众减少一味偏见的看法，提高受众对媒介信任程度。[143]我国老年群体总体的新媒介素养不高[144]，面对新媒介上的保健品广告时，无论保健品产品是否正规，他们也可能会“一刀切”地不信任，出现了“媒体偏见”的现象。这样做虽然可以规避诈骗、钱财损失，但不利于老年人依靠自己的能力去判别健康和保健信息的真假。

媒介上的保健品广告亦真亦假。所以实际上，我国老年消费者在接收保健品信息时，既存在能够依据自身媒介素养水平判断信息真假的情况，也存在“一刀切”不信任的情况。探究何种情况居多，对厘清保健品消费语境下媒介素养产生影响的机制十分重要，可以为我国不断正规的保健品行业制定未来的销售策略提供参考。由于老年人从媒介接收到保健品相关信息，不仅包括了老年人对媒介产生信任的过程，还包含了老年人对媒介上内容建立基于认知的信任的过程。因此，本文提出假设：

H4：媒介素养影响老年人对保健产品的认知信任。

H5：媒介素养影响老年人对刊播保健品广告的媒介的信任度。

“媒介偏见”现象的存在，也意味着老年人对媒介的信任度会影响老年人对媒介上信息的信任度[145]。因此，本文提出假设：

H6：媒介信任度影响老年人对保健产品的认知信任。

---

[141] 新华网：《揭秘伪中医保健：打中药旗号卖保健品 投诉居高不下》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1623858521509688069&wfr=spider&for=pc，2019 年 1 月发布。

[142] Fisher C, “The trouble with ‘trust’in news media,” *Communication Research and Practice*, Vol.2:4, 2016, p.451-465.

[143] Vraga E K, Tully M, Akin H, et al, “Modifying perceptions of hostility and credibility of news coverage of an environmental controversy through media literacy,” *Journalism*, Vol.13:7, 2012, p.942-959.

[144] 孟博文，殷文：老年传播视角下新媒介适老性研究——以智能手机与微信、抖音等 APP 为例，《传媒观察》，2021 年第 8 期，第 74-79 页。

[145] Fisher C, 同前注[142]，第 26 页。

中国知网 https://www.cnki.net

3. 有关可靠性感知的假设

无论在西方还是中国语境下，可靠性都可被视作是信任的一个超越文化的特征[146]。认知信任通常建立在个人和组织的可靠性上[147]。Oliveira 等人（2017）指出，消费者的信任取决于供应商的可靠性[148]。Swan 等人（1985）发现，医药产品销售人员的可靠性是赢得顾客信任的重要因素[149]。Glikson 和 Woolley（2020）提出，可靠性在人类对人工智能技术建立认知信任的过程中起着重要作用[150]。Johnson 和 Grayson（2005）也证实了与可靠性密切相关的专业性对消费者信任的积极影响[151]。在保健品营销传播的的语境中，销售商的“可靠性”并非销售商自身具备，而是老年消费者经过自己的判断单向感知到的，因此本研究使用“可靠性感知”这一概念来探究保健品商家是如何通过将保健品包装得专业、权威、可靠让老年消费者产生认知信任的。

保健品广告神话的构建一般会运用高科技化（最新医学研究成果和顶尖科学技术）、自然化（产品源于自然，是纯天然产品）、神秘化（传统文化中的玄学、秘方和古法制作，如八卦、周易、中医理论、家传秘方等）、故事化（将“治愈故事”作为宣传典型案例）等修辞[152]。正规保健品广告的内容可能会涉及这四个维度，但是其内容是有科学依据的，通过对事实的处理让老年消费者建立信任。而伪劣保健品营销不择手段，夸大甚至虚构产品功效，如使用“中医经络磁疗治高血压”“量子科技预防癌症”“负离子水调节免疫系统”等伪健康概念表现出“专业性”，塑造“北大专家”“苗医传人”“藏医世家”等广告代言人形象表现出“权威性”，让老年消费者感知到该保健品产品是十分可靠的。因此提出假设：

H7：可靠性感知正向影响老年人对虚假宣传保健产品的认知信任。

[146] Migge T , Kiffin-Petersen S A & Purchase S, 同前注[75]，第 13 页。
[147] Lewis J D & Weigert A, “Trust as a social reality,” *Social forces*, Vol.63:4, 1985, p.967-985.
[148] Oliveira T, Alhinho M, Rita P, et al, 同前注[128]，第 24 页。
[149] Swan J E, Trawick I F & Silva D W, “How industrial salespeople gain customer trust,” *Industrial marketing management*, Vol.14:3, 1985, p.203-211.
[150] Glikson E & Woolley A W, “Human trust in artificial intelligence: Review of empirical research,” *Academy of Management Annals*, Vol.14:2, 2020, p.627-660.
[151] Johnson D & Grayson K, 同前注[90]，第 15 页。
[152] 王胜源，赵怡森，同前注[31]，第 5 页。

中国知网 https://www.cnki.net

4. 有关消费者涉入度的假设

在本研究中，消费者涉入度（又称卷入度）可以定义为老年消费者依据自身需要、价值观和认知而对保健品产品感兴趣的程度，具体表现为消费者涉入度越高意味着产品对于消费者越重要，因此高涉入度的消费者一般会花费更多的时间、精力考虑他们做出的选择。[153]消费者在进行考虑和选择时容易受到参照群体和外在环境的影响[154]，因此在面对保健品广告或线下的保健品销售活动时，尤其是被伪劣保健品所用的病毒式营销手段影响时，老年消费者容易被宣传的健康讲座、免费体检、优惠购买资格吸引，容易受到保健品推销者、医学专家的说辞或其他老人的“痊愈故事”的影响，成为保健品产品的高涉入度消费者，建立起基于认知和情感的信任。

姜素芳等人（2019）发现，消费者的食品购物涉入度越高，对食品的信任程度越高[155]。消费者在他们的购物周期中寻求可以提供信任的同伴的帮助越多，就能越积极地影响他们的信任。当老人在保健品推销中成为了高涉入度的消费者时，越有可能付之于认知信任和情感信任。因此提出假设：

H8：消费者涉入度正向影响老年人对虚假宣传保健产品的认知信任。

H9：消费者涉入度正向影响老年人对虚假宣传保健产品的情感信任。

5. 有关中介效应的假设

已有多项研究证明了认知信任和情感信任的中介作用[156]、[157]。当老年人对使用媒介的信任度不高、自身媒介素养水平较低、认为广告内容可靠性很高或是已对保健品销售相关的各类活动有着较高的涉入度时，老年消费者对保健品产品的认知信任越高，他们越认为保健品产品的功效真实，能够满足自身健康需求，从而更容易产生保健品购买意愿。因此我们提出假设：

H10a：认知信任中介媒介信任度、媒介素养、可靠性感知、消费者涉入度与保健品购买意愿之间的关系。

---

[153] Zaichkowsky J L, “Conceptualizing involvement,” *Journal of advertising,* Vol.15:2, 1986, p.4-34.

[154] Kandampully J, “The impact of demand fluctuation on the quality of service: a tourism industry example,” *Managing Service Quality: An International Journal*, Vol.10:1, 2000, p.10-19.

[155] 姜素芳，潘琪，陈志良：网络食品消费者风险感知能力影响因素的实证研究——以浙江省为例，《中国食物与营养》，2019 年第 6 期，第 37-42 期。

[156] Punyatoya P ，同前注[15]，第 4 页。

[157] 张慧，周小虎，高照龙，同前注[18] ，第 4 页。

中国知网 https://www.cnki.net

当老年人已对保健品产品产生认知信任，或是已保健品相关人员投入了情感时，老年消费者对保健品产品的情感信任越高，他们越相信保健品推销者是关心他们、为他们健康考虑的，因此老年人更愿意购买保健品。

H10b：情感信任中介认知信任、消费者涉入度与保健品购买意愿之间的关系。

老年人对保健品广告建立认知信任可以被个人的媒介素养直接影响，也会因为被媒介的信任度影响，同时媒介素养也决定着媒介信任度的高低。因此提出假设：

H10c：媒介信任度中介媒介素养与认知信任之间的关系。

（三）变量测量与问卷设计

初始问卷建立在前人文献的基础上，同时为了配合本研究的适用性，问卷首先对 30 个研究对象进行前测，然后根据回答修改完成。问卷所有题项均采用陈述句式，答案选项从赋值 1“非常不同意”到赋值 5“非常同意”，以李克特五点量表进行测量。

1. 媒介素养

媒介素养（Midea Literacy）指老年消费者面对媒介所提供保健品信息，能够对其真实性、权威性进行评价的能力，和对其真伪进行分析的能力[158]。媒介素养（ML）参考李金城（2017）的量表[159]设计了 4 个媒介素养的题项（如表 2.1 所示）。

2. 媒介信任度

媒介信任度（Media Trust）指老年消费者对刊播保健品广告的媒介的信任程度。[160]媒介信任度（MT）参考贾哲敏（2020）[161]的量表设计了 4 个题项（如表 2.1 所示）。

3. 消费者涉入度

消费者涉入度（Consumer Involvement）指老年消费者依据自身需要、价值观和认知

[158] 刘鸣筝，陈雪薇，同前注[138]，第 25 页。
[159] 李金城：《媒介素养的测量及影响因素研究》，上海：上海交通大学出版社，2017 年。
[160] Strömbäck J, Tsfati Y, Boomgaarden H, et al, 同前注[99]，第 17 页。
[161] 贾哲敏，孟天广，同前注[94]，第 16 页。

中国知网 https://www.cnki.net

而对保健品产品感兴趣的程度，受到保健品营销活动的参与程度以及与保健品推销者的交往程度的影响[162]、[163]。消费者涉入度（CI）参考 Michael（1995）的量表[164]设计了 4 个题项（如表 2.1 所示）。

4. 可靠性感知

可靠性感知（Reliability Perception）指老年消费者经过自己的判断单向感知到保健品产品的专业、权威和可靠的程度[165]。可靠性感知（RP）参考王胜源和赵怡森（2021）的文献[166]，设计了 4 个题项（如表 2.1 所示）。

5. 认知信任

认知信任（Cognition-based Trust）指老年消费者基于理性认知认为保健品产品可靠、专业、权威而产生的信任[167]。认知信任（CBT）参考 McAllister（1995）的量表[168]设计了 3 个题项（如表 2.1 所示）。

6. 情感信任

情感信任（Affect-based Trust）指老年消费者基于强烈情感联系和积极情绪而对保健品产生的信任[169]、[170]。情感信任（ABT）参考 McAllister（同上）的量表[171]设计了 3 个题项（如表 2.1 所示）。

[162] Zaichkowsky J L, 同前注[153]，第 28 页。
[163] 周伟，窦贤惠：网络信息消费风险感知的影响因素研究，《内蒙古农业大学学报(社会科学版)》，2021 年第 1 期，第 49-54 页。
[164] Rothschild M L, “Marketing communications in nonbusiness situations or why its so hard to sell brotherhood l ike soap,” *Journal of marketing*, Vol.43:2, 1979, p.11-20.
[165] Johnson D & Grayson K, 同前注[90]，第 15 页。
[166] 王胜源，赵怡森，同前注[31]，第 5 页。
[167] McAllister D J, 同前注[14]，第 4 页。
[168] ibid.
[169] ibid.
[170] Abou-Elgheit E, “Affect-based and personality-based trust and risk in social commerce,” *International Journal of Electronic Marketing and Retailing*, Vol.10:2, 2019, p.173-207.
[171] McAllister D J, 同前注[14]，第 4 页。

中国知网 https://www.cnki.net

7. 保健品购买意愿

保健品购买意愿（Purchase Willingness）指老年消费者购买保健品的主观意愿[172]。保健品购买意愿设计了 4 个题项（如表 2.1 所示）。

表 2.1 相关变量测量题项

变量	编号	测量题项
媒介素养	ML1	我能够从其它渠道找到证明资料，来判断保健品广告是否可以相信
	ML2	我能够通过广告标题及内容，判断保健品广告是否可以相信
	ML3	我能够通过信息发布来源的权威性，判断保健品广告是否可以相信
	ML4	我能够判断保健品广告的内容，是真实的健康知识还是售卖产品的套话
媒介信任度	MT1	我对电视上的保健品广告十分信任
	MT2	我对报纸/杂质上播放的保健品广告十分信任
	MT3	我对微信上的保健品广告十分信任
	MT4	我对网购 APP 上的保健品广告十分信任
消费者涉入度	CI1	我参加过保健品公司举办的健康讲座/免费体检/专家义诊等活动
	CI2	我参加过保健品公司的赠送小礼品/获得优惠购买资格等活动
	CI3	我参加过保健品公司组织的旅游团等活动
	CI4	我不排斥保健品的销售人员来家里拜访我
可靠性感知	RP1	保健品广告中，我认为宣传的最新医学研究和科学技术是可靠的
	RP2	保健品广告中，我认为宣传的“纯天然”“自然”成分是可靠的
	RP3	保健品广告中，我认为宣传的“家传秘方”“古法制作”是可靠的
	RP4	保健品广告中，我认为宣传的“患者痊愈”故事是可靠的
认知信任	CBT1	我相信我选择的保健品商家提供了保健品真实的信息
	CBT2	我相信我选择的保健品商家有能力提供正规的保健品
	CBT3	我相信我选择的保健品商家是值得我信赖的
情感信任	ABT1	我认为我与保健品销售人员建立了良好的情感关系
	ABT2	我认为保健品销售人员是在关心我健康的情况下为我推荐相应的保健产品
	ABT3	我承认我在保健品公司举办的活动中投入了一定的精力、情感和信任
保健品购买意愿	PW1	我会因为看了保健品广告，认为该产品对我有用而购买保健品
	PW2	我会因为接触了保健品销售人员，看在与他们的情分上购买保健品。
	PW3	比起药品，我愿意更购买保健品
	PW4	我愿意作为老消费者向其他人推荐我购买的保健品

[172] Taylor J W, “The role of risk in consumer behavior: A comprehensive and operational theory of risk taking in consumer behavior,” Journal of marketing, Vol.38:2, 1974, p.54-60.

中国知网 https://www.cnki.net

（四）数据收集与描述性统计

本研究以 55 岁以上的城市老年人为研究对象，以四川、重庆、江苏作为问卷发放的主要区域。鉴于新冠疫情不断零星出现，现场面访受到限制，因而本研究采用网络方便抽样形式，尽管有很大局限性，但仍不失为一种目前较广泛采用的可行且相对可靠的抽样方式。于 2022 年 3 月 10 日以匿名的方式发放问卷，于 2022 年 3 月 22 日完成问卷回收。通过调查网站“问卷星”制作好电子版问卷，发送给四川、重庆、江苏等地区的多个老年朋友群，并委托朋友、同学转发给老年长辈。问卷共回收 363 份，删除填答时间少于 1 分钟、填答者年龄不足 55 岁、全部选择同一选项等无效问卷后，有效问卷 315 份，有效比率为 86.8%。

本文首先通过 SPSS 28.0 对 315 份有效问卷进行样本特征分析，分析结果如表 2.2 所示。

表 2.2 问卷调查的人口统计 N=315

特征	选项	人数	百分比
性别	男	150	47.6%
	女	165	52.4%
受教育程度	初中及以下	87	27.6%
	高中/中专	105	33.3%
	大专/高职	66	21.0%
	大学本科及以上	57	18.1%
年龄	55~59 岁	93	29.55%
	60~64 岁	55	17.5%
	65~69 岁	52	16.5%
	70~74 岁	37	11.7%
	75~79 岁	43	13.7%
	80 岁及以上	35	11.1%
所属省份	四川	175	55.56%
	重庆	48	15.24%
	江苏	37	11.75%
	其他省市	55	17.45%

从表中数据可以看出，参与问卷填答的男性人数与女性人数基本持平，男女比例约为 1:1。从受教育程度看，“高中/高职”居多（33.3%），“初中及以下”次之（27.6%），符合我国老年人文化程度总体偏低的现状。[173]

[173] 新京报：《我国老年人小学及以下文化程度超七成，影响其生活质量》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=165442

中国知网 https://www.cnki.net

（五）测量模型检验

PLS-SEM 能处理更复杂的研究模型，且原始数据不需要满足正态分布（Hair et al.，2012）[174]。由于本研究的数据来自网络，数据不一定能满足正态分布的要求，因此本研究采用偏最小二乘法（Partial Least Square，PLS）分析模型和数据，以求得出最稳健的结果。在模型的拟合度上，PLS 拟合度计算方法为平均方差萃取量的均值和解释程度 R 均值的乘积开方，GOF=0.1 (小)，GOF=0.025（中），GOF=0.36（大）[175]、[176]。经过计算，本研究拟合度为 0.523，大于 0.36，表示模型的拟合度好。

$$GOF = \sqrt{\overline{AVE} \times \overline{R^2}} = \sqrt{0.684 \times 0.4} = 0.523$$

本研究将通过 SPSS 28.0.0.1.软件对 315 份正式量表问卷进行样本特征分析、描述性分析与信度分析，通过 SmartPLS 3.0 检验量表的收敛效度和区别效度，并进行完成结构方程模型评估和分析。

1. 信度分析

表 2.3 量表问卷的信度分析

	变量	测量题项数	Cronbachs α	组合信度（CR）
刺激 S	媒介素养 ML	3	0.736	0.833
	媒介信任度 MT	4	0.838	0.888
	可靠性感知 RP	4	0.788	0.863
	消费者涉入度 CI	4	0.797	0.868
机体 O	认知信任 CBT	3	0.909	0.943
	情感信任 ABT	3	0.826	0.896
反应 R	购买意愿 PW	4	0.835	0.890
总体	/	25	0.922	/

在信度检测上，如表 2.3 所示，所有变量的克朗巴哈 α 系数（Cronbachs α）均大于 0.7、组合信度（Composite Reliability）均大于 0.8，且问卷的整体信度大于 0.9，表

1668390192194&wfr=spider&for=pc，2019 年 12 月发布，2023 年 3 月最后访问。

[174] Hair J F, Sarstedt M, Ringle C M, et al, “An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research,” *Journal of the academy of marketing science*, Vol.40:3, 2012, p.414-433.

[175] Tenenhaus M, Vinzi V E, Chatelin Y M, et al, “PLS path modeling,” *Computational statistics & data analysis*, Vol.48:1, 2005, p.159-205.

[176] Wetzels M, Odekerken-Schröder G & Van Oppen C, “Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration,” *MIS quarterly*, 2009, p.177-195.

中国知网 https://www.cnki.net

明具有相当的信度。[177]

表 2.4 验证性因子分析（N=315）

变量	模型参数估计值			收敛效度	
	题项	平均值（M）	标准化因子载荷量	组合信度（CR）	平均方差萃取量（AVE）
媒介素养 M=3.25	ML1	3.07	0.797***	0.833	0.629
	ML2	3.34	0.913***		
	ML3	3.35	0.647***		
媒介信任度 M=2.30	MT1	2.56	0.840***	0.888	0.667
	MT2	2.46	0.885***		
	MT3	2.05	0.789***		
	MT4	2.11	0.746***		
可靠性感知 M=2.50	RP1	2.89	0.734***	0.863	0.612
	RP2	2.56	0.825***		
	RP3	2.31	0.789***		
	RP4	2.23	0.778***		
消费者涉入度 M=2.52	CI1	2.87	0.818***	0.868	0.623
	CI2	2.70	0.863***		
	CI3	2.34	0.760***		
	CI4	2.13	0.710***		
认知信任 M=2.72	CBT1	2.60	0.902***	0.943	0.846
	CBT2	2.76	0.937***		
	CBT3	2.81	0.919***		
情感信任 M=2.48	ABT1	2.46	0.897***	0.896	0.742
	ABT2	2.38	0.832***		
	ABT3	2.59	0.854***		
购买意愿 M=2.53	PW1	2.80	0.853***	0.890	0.669
	PW2	2.52	0.789***		
	PW3	2.23	0.780***		
	PW4	2.57	0.847***		

[177] Fornell C & Larcker D F, “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error,” *Journal of marketing research*, Vol.18:1, 1981, p.39-50.

中国知网 https://www.cnki.net

2. 效度分析

(1)收敛效度分析

效度的评估包括收敛效度和区别效度评估。如表 2.4 所示，在进行验证性因子分子后（CFA），基于收敛效度的检测，因子载荷量大于 0.6、组合信度大于 0.8、平均方差萃取量（AVE）大于 0.6，表明所有构念均具有足够的收敛效度。

(2)区别效度分析

在区别效度的检测上，如表 2.5 所示，对角线每个构念 AVE 平方根均大于对角线外的相关系数，[178] 因此本研究的每个构念具有良好的区别效度。

表 2.5 区别效度与 AVE 平方根值

	AVE	媒介素养	媒介信任度	可靠性感知	消费者涉入度	认知信任	情感信任	购买意愿
媒介素养	0.629	0.793						
媒介信任度	0.667	0.171	0.817					
可靠性感知	0.612	0.245	0.440	0.782				
消费者涉入度	0.623	0.104	0.397	0.478	0.790			
认知信任	0.846	0.248	0.478	0.534	0.445	0.920		
情感信任	0.742	0.133	0.434	0.520	0.670	0.658	0.861	
购买意愿	0.669	0.101	0.462	0.535	0.610	0.600	0.737	0.818

注明：对角线上值为 AVE 平方根值

（六）结构模型检验

1. 直接作用检验

在模型验证的结构模型评估中，本研究结构模型的假设检验与路径分析结果如表 2.6 和图 2.2 所示。

[178] Fornell C & Larcker D F, 同前注[175]，第 34 页。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.6 模型路径分析与假设检验结果

假设	结构模型路径	路径系数	T 值	P 值	检定结果
H1	认知信任→购买意愿	0.203***	3.681	0.000	支持
H2	情感信任→购买意愿	0.603***	11.404	0.000	支持
H3	认知信任→情感信任	0.449***	9.992	0.000	支持
H4	媒介素养→认知信任	0.110*	2.147	0.032	支持
H5	媒介素养→媒介信任度	0.171***	3.106	0.002	支持
H6	媒介信任度→认知信任	0.249***	4.719	0.000	支持
H7	可靠性感知→认知信任	0.308***	5.038	0.000	支持
H8	消费者涉入度→认知信任	0.187***	3.407	0.001	支持
H9	消费者涉入度→情感信任	0.471***	10.179	0.000	支持

注明： *p-value<0.05, ** p-value<0.01, *** p-value<0.005

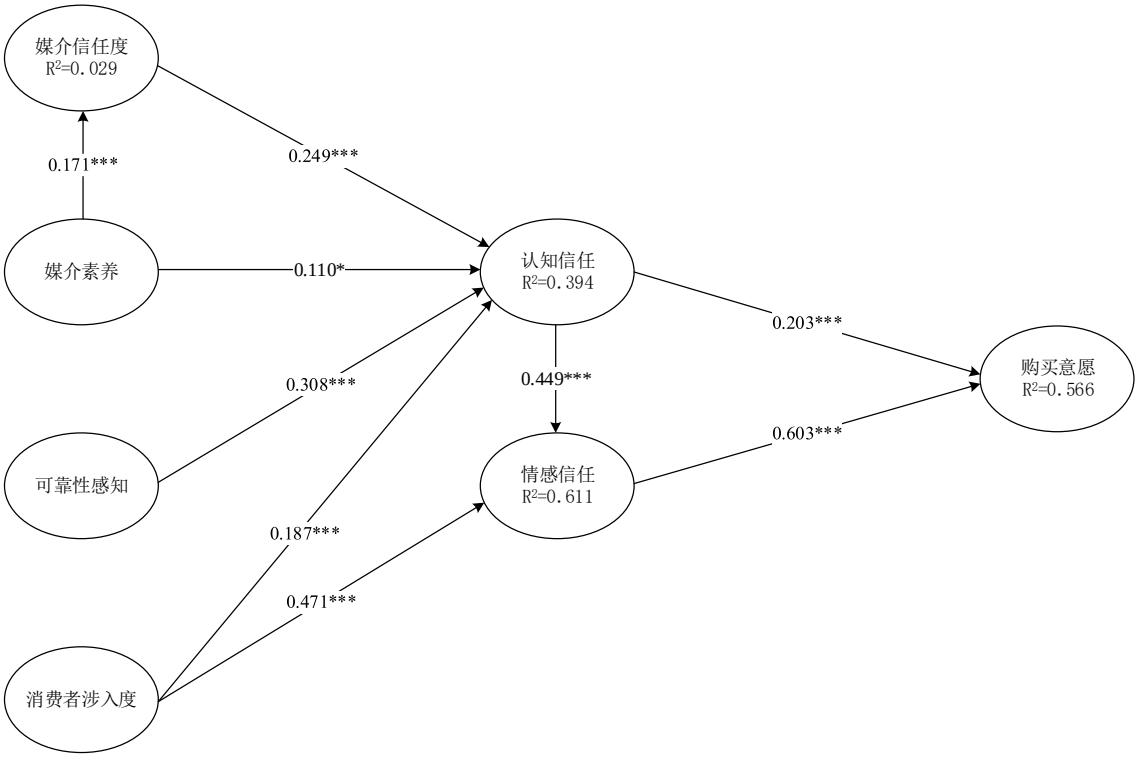

图 2.2 结构模型路径分析与假设检验

由结构模型分析结果可知：

首先，认知信任和情感信任均对保健品购买意愿产生了正向显著影响，且情感信任（β=0.603,p<0.005）的贡献大于认知信任（β=0.203,p<0.005）。认知信任也被证实能正向影响情感信任（β=0.449,p<0.005），H1、H2、H3 成立。第二，媒介素养、媒介可信度、可靠性感知、消费者涉入度均对认知信任有显著的正向影响，H4、H6、H7、H8 成立。其中，可靠性感知的贡献最大（β=0.308,p<0.005），其次是媒介信任度（β=

中国知网 https://www.cnki.net

0.249,p<0.005）、消费者涉入度（β=0.187,p<0.005）和媒介素养（β=0.110,p<0.05）。第三，消费者涉入度对情感信任有显著的正向影响（β=0.471,p<0.005），H9 成立。第四，媒介素养对媒介信任度有显著的正向影响（β=0.171,p<0.005），H5 成立。

2. 中介效应检验

本研究假设与研究问题涉及多个变量的直接与间接关系，在检定中介效果上，PLS3.0 可直接运用目前广泛使用的 Bootstrapping procedure 方法进行检测。本研究设定进行 5000 次重复抽样，计算中介效应。检测结果发现，在中介效应上，除了认知信任无法中介媒介素养和购买意愿的关系，其他中介效果都成立。

就简单中介效应而言（表 2.7），媒介信任度、可靠性感知、消费者涉入度透过认知信任影响保健品购买意愿，其中可靠性感知（β=0.063）的预测力最强，然后是媒介信任度（β=0.051）和消费者涉入度（β=0.038）。第二，媒介素养、媒介信任度、可靠性感知、消费者涉入度透过认知信任影响情感信任，可靠性感知（β=0.138）依旧是最重要的影响因素，接下来分别是媒介信任度（β=0.112）、消费者涉入度（β=0.084）和媒介素养（β=0.049）。第三，消费者涉入度、认知信任透过情感信任影响保健品购买意愿，消费者涉入度的预测力（β=0.284）大于认知信任（β=0.271）。最后发现，媒介信任度在媒介素养与认知信任之间起到中介作用（β=0.043）。

表 2.7 简单中介效果

中介关系	路径系数	T 值	P 值	检定结果
认知信任 → 情感信任 → 购买意愿	0.271***	8.443	0.000	支持
媒介素养 → 认知信任 → 购买意愿	0.022	1.866	0.062	不支持
媒介信任度 → 认知信任 → 购买意愿	0.051***	2.996	0.003	支持
可靠性感知 → 认知信任 → 购买意愿	0.063**	2.777	0.006	支持
消费者涉入度 → 认知信任 → 购买意愿	0.038*	2.268	0.023	支持
消费者涉入度 → 情感信任 → 购买意愿	0.284***	6.83	0.000	支持
媒介素养 → 媒介信任度 → 认知信任	0.043*	2.516	0.012	支持
媒介素养 → 认知信任 → 情感信任	0.049*	2.104	0.035	支持
媒介信任度 → 认知信任 → 情感信任	0.112***	4.251	0.000	支持
可靠性感知 → 认知信任 → 情感信任	0.138***	4.300	0.000	支持
消费者涉入度 → 认知信任 → 情感信任	0.084***	3.227	0.001	支持

注明： *p-value<0.05, ** p-value<0.01, *** p-value<0.005

中国知网 https://www.cnki.net

就链式中介效应而言（表 2.8），可靠性感知通过认知信任和情感信任对保健品购买意愿的影响力最大（β=0.083），然后依次是媒介信任度（β=0.067）、消费者涉入度（β=0.051）和媒介素养（β=0.030）。除此之外。媒介素养能够通过媒介信任度和认知信任分别影响情感信任（β=0.019）和购买意愿（β=0.009），还能通过媒介信任度、认知信任、情感信任影响购买意愿（β=0.012）。

由此可见，无论是直接效应还是中介效应，以媒介素养作为起点的中介关系都不算十分显著，甚至中介关系不成立。媒介信任度、可靠性感知、消费者涉入度在不同的路径中扮演着不同重要的角色。在有认知信任作为中介变量参与的中介关系中，可靠性感知都贡献了最大的预测力。但在只有情感信任作为中介变量的中介关系中，消费者涉入度成为了最重要的预测变量。

表 2.8 链式中介效果

中介关系	路径系数	T 值	P 值	检定结果
媒介素养 → 认知信任 → 情感信任 → 购买意愿	0.030*	2.077	0.038	支持
媒介信任度 → 认知信任 → 情感信任 → 购买意愿	0.067***	4.048	0.000	支持
可靠性感知 → 认知信任 → 情感信任 → 购买意愿	0.083***	4.213	0.000	支持
消费者涉入度 → 认知信任 → 情感信任 → 购买意愿	0.051***	3.247	0.001	支持
媒介素养 → 媒介信任度 → 认知信任 → 购买意愿	0.009*	2.039	0.042	支持
媒介素养 → 媒介信任度 → 认知信任 → 情感信任	0.019*	2.409	0.016	支持
媒介素养 → 媒介信任度 → 认知信任 → 情感信任 → 购买意愿	0.012*	2.382	0.017	支持

注明： *p-value<0.05, ** p-value<0.01, *** p-value<0.005

3. 假设结果汇总

本文涉及到的假设与检验结果汇总如表 2.9 所示。

表 2.9 研究假设检验成果

编号	假设内容	假设检验
H1	认知信任正向影响保健品购买意愿	成立（+）
H2	情感信任正向影响保健品购买意愿	成立（+）
H3	认知信任正向影响情感信任	成立（+）
H4	媒介素养影响认知信任	成立（+）
H5	媒介信任度影响认知信任	成立（+）
H6	媒介素养影响媒介信任度	成立（+）
H7	可靠性感知正向影响认知信任	成立（+）
H8	消费者涉入度正向影响认知信任	成立（+）

中国知网 https://www.cnki.net

编号	假设内容	假设检验
H9	消费者涉入度正向影响情感信任	成立（+）
H10a	认知信任中介媒介信任度、媒介素养、可靠性感知、消费者涉入度与保健品购买意愿之间的关系	部分成立
H10b	情感信任中介认知信任、消费者涉入度与保健品购买意愿之间的关系	成立
H10c	媒介信任度中介媒介素养和认知信任之间的关系	成立

（七）多群组检验

上文已论述性别、受教育程度可能是影响老年人通过社交媒体寻求保健品相关信息的重要预测变量。由于性别、受教育程度均为分类变量，无法做调节效果，所以本研究利用 PLS 中的多群组比较（multi-group analysis）对性别、受教育程度做多群组结构方程模型分析。

1. 性别组别差异

性别组别分为了为男性（150）、女性两组（165）两组，具体的假设检验结果如表 2.10 所示。结果显示，男性和女性仅在可靠性感知对认知信任上具有一定差异，其他假设无显著差异。

表 2.10 多群组结构方程模型（性别组别）分析检验结果

假设		性别检验 P 值	结果
H1	认知信任 → 购买意愿	0.786	不支持
H2	情感信任 → 购买意愿	0.583	不支持
H3	认知信任 → 情感信任	0.312	不支持
H4	媒介素养 → 认知信任	0.106	不支持
H5	媒介信任度 → 认知信任	0.949	不支持
H6	媒介素养 → 媒介信任度	0.651	不支持
H7	可靠性感知 → 认知信任	0.011*	支持
H8	消费者涉入度 → 认知信任	0.130	不支持
H9	消费者涉入度 → 情感信任	0.549	不支持

注明： *p-value<0.05, ** p-value<0.01, *** p-value<0.005

中国知网 https://www.cnki.net

2. 年龄组别差异

年龄组别分为了 65 岁以上（176）、65 岁及以下（148）两组。具体的假设检验结果如表 2.11 所示。结果显示，年龄组 65 岁以上老人与 65 岁及以下老人仅在媒介素养对媒介信任度上具有一定差异，其他假设无显著差异。

表 2.11 多群组结构方程模型（年龄组别）分析检验结果

假设		年龄检验 P 值	结果
H1	认知信任 → 购买意愿	0.212	不支持
H2	情感信任 → 购买意愿	0.388	不支持
H3	认知信任 → 情感信任	0.442	不支持
H4	媒介素养 → 认知信任	0.520	不支持
H5	媒介信任度 → 认知信任	0.486	不支持
H6	媒介素养 → 媒介信任度	0.016*	支持
H7	可靠性感知 → 认知信任	0.693	不支持
H8	消费者涉入度 → 认知信任	0.858	不支持
H9	消费者涉入度 → 情感信任	0.409	不支持
注明： *p-value<0.05, ** p-value<0.01, *** p-value<0.005			

3. 受教育程度组别差异

受教育程度组别分为了大专/高职及以上（123）、高中/中专及以下（192）两组，具体的假设检验结果如表 2.12 所示。结果显示，受教育程度较高的老人与较低者仅在媒介素养对认知信任上具有一定差异，其他假设无显著差异。

表 2.12 多群组结构方程模型（受教育程度组别）分析检验结果

假设		受教育程度检验 P 值	结果
H1	认知信任 → 购买意愿	0.799	不支持
H2	情感信任 → 购买意愿	0.906	不支持
H3	认知信任 → 情感信任	0.778	不支持
H4	媒介素养 → 认知信任	0.031*	支持
H5	媒介信任度 → 认知信任	0.210	不支持
H6	媒介素养 → 媒介信任度	0.417	不支持
H7	可靠性感知 → 认知信任	0.360	不支持
H8	消费者涉入度 → 认知信任	0.056	不支持
H9	消费者涉入度 → 情感信任	0.648	不支持
注明： *p-value<0.05, ** p-value<0.01, *** p-value<0.005			

中国知网 https://www.cnki.net

（八）结论、讨论与问题的提出

在保健品虚假营销背景下，本研究以城市老年人为研究对象，基于 SOR 理论模型和现有文献，将认知信任和情感信任作为核心的中介变量，将媒介素养、媒介信任度、可靠性感知、消费者涉入度作为前因变量，将保健品购买意愿作为结果变量，建构了一个老年人购买保健品的因果模型，用以解释与预测城市老年人的保健品购买行为。

本研究构建的以认知信任、情感信任为中介的老年人购买保健品的因果模型表现出了较好的预测能力，不仅一定程度上丰富了认知信任、情感信任的前因和 SOR 理论模型，还可以用于解释老年人对虚假广告保健品的购买意愿的影响因素。

研究表明，认知信任和情感信任能够直接影响购买意愿，且认知信任还能通过情感信任对购买意愿产生影响，说明在保健品营销传播中，信任确实扮演着十分重要的角色。对信任发挥作用的机制进行进一步分析，可以发现媒介素养、媒介信任度、可靠性感知、消费者涉入度能够直接影响认知信任，且能通过认知信任影响情感信任，但只有后三者能够通过认知信任影响保健品购买意愿。同时，老年人的媒介素养也会影响老年人对媒介的信任程度。

数据反映出，老年人的媒介素养水平和媒介信任度越高，感知到的保健品产品的可靠性越强，保健品相关各类活动的消费者涉入度越高，越能对保健品产品建立基于认知的信任。同时，消费者涉入度和认知信任对情感信任产生显著的正向影响，并通过情感信任影响保健品购买意愿。这意味着，老年人在保健品相关各类销售活动中的消费者涉入度越高，对保健品产品基于认知的信任越高，越容易对保健品产品建立情感信任，进而增强购买保健品的意愿。媒介信任度、可靠性感知、消费者涉入度也能透过认知信任到情感信任，最终对保健品购买意愿产生影响。而可靠性感知无论是在对认知信任的直接效应中，还是在对情感信任和购买意愿的间接效应中，都是最显著的影响因素。

媒介素养除了对媒介信任度有着显著影响，在其他的路径中都表现出较低的预测力。同时，媒介素养对媒介信任度（M=2.30<3）和认知信任（M=2.72<3）都产生正向影响，这也意味着，老年人通过媒介接触保健品广告时，存在着“媒介偏见”的现象，即无论针对正规保健品还是伪劣保健品，老年人都“一刀切”地不相信刊播保健品广告的媒介及内

中国知网 https://www.cnki.net

容。老年人在接收不同渠道的保健品广告时是否存在媒介信任分化现象？对于这一问题，数据也证实，在老年人普遍不信任保健品广告的情况下，仍存在着一定的媒介信任分化现象：与传统媒体上保健品广告（M=2.51）相比，老年人更不相信新媒体（M=2.08）上的保健品广告。

值得留意的是，媒介素养在模型中产生影响的机制极为特殊：媒介素养无法通过认知信任影响购买意愿，但是如果有媒介信任度或情感信任加入其中，媒介素养就能对购买意愿产生影响，即使产生的影响相比较其他变量较弱。

1. 虚假保健品营销中情感信任比认知信任作用更大

在消费者涉入度对购买意愿的影响路径中，认知信任（β=0.038）和情感信任（β=0.284）都起到了作用。在情感信任的直接效应中，消费者涉入度（β=0.471）比认知信任（β=0.449）做出了更大的贡献。由此可见，在伪劣保健品营销和虚假宣传的语境中，情感信任比认知信任对保健品购买意愿起着更重要的作用，且认知信任和情感信任产生的影响存在差异。这也说明，老年人对保健品广告的认知（认知信任，M=2.721<3）较为理性，但一旦情感介入，老年消费者容易失去理性产生购买行为。McAllister（1995）指出，情感信任是建立在认知信任基础之上的[179]。本研究在一定程度上证实了这一观点，同时也发现情感信任建立的基础并非仅是认知信任，消费者涉入度对情感信任表现出了更强的预测力。

一方面，情感信任已被发现在集体主义文化中更受重视[180]，已成气候的保健品虚假销售是近三十年来我国特有的现象，因此在保健品虚假销售中情感信任的影响力比认知信任更加显著。另一方面，近年来我国不断规范保健品广告的刊发，打击保健品产品的虚假宣传和营销，目前大部分老年人对虚假保健品的认知还是较为理性。但是当老年人身处于线下的保健品营销活动中时，积极情绪被调动起来，老年消费者的满意度得到提升，[181] 在经历专家讲解、厂家视频连线、老顾客反馈、优惠资格促销的一系列环节后，处于封闭环境的老年人建立了情感上的信任，则容易受到氛围感染失去理性，进而

[179] McAllister D J, 同前注[14]，第 4 页。
[180] Ng K Y & Chua R Y J, 同前注[137]，第 25 页。
[181] Dăniasă C I, Tomiţă V, Stuparu D, et al, 同前注[112]，第 18 页。

中国知网 https://www.cnki.net

产生冲动消费。[182]除此之外，保健品销售人员也通过与老年消费者建立情感纽带以增加信任。

保健品营销是如何提升消费者涉入度，销售人员又在老年人情感信任建立中扮演什么样的角色，值得进一步探讨。

2. 老年人对保健品广告存在传统媒介与数字媒体的信任分化

本研究就老年人对不同媒介上保健品广告的信任程度进行了测量，发现老年人对电视上的保健品广告信任程度最高（M=2.56<3），其次是报刊杂志（M=2.46<3），最后才会去信任网购 App（M=2.11<3）和微信朋友圈、公众号上（M=2.05<3）投放的保健品广告。从均值数可以看出，无论出自哪种媒介的保健品广告，甚至是正规的保健品，老年人都持着不太相信的态度。但老年人对传统媒介上保健品广告的信任度仍略高于新媒介，还是存在着一定程度的信任分化。

一方面，在传统社会中，人们可以基于确定性而依据熟悉关系建立信任。而在现代社会，网络技术产生的信息生产模式使传统社会具有的确定属性遭遇流动、变化、陌生的冲击，变为不确定性。这种不确定性不仅成为网络信息空间的普遍性特征，还波及网络信息技术连结的线下空间。[183] 熟悉传统社会模式的老年人成为网络社会中陌生的社会成员，对网络社会之不确定性的理解和态度，使其与作为网络社会原住民的年轻人有非常大的差别。因而老年人接受信息时，倾向于将匿名或半匿名的网络信息和活动看成是虚拟的、不可靠的，他们对网络信息、网络营销等皆心存疑虑，害怕上当受骗，不敢参与，更愿意选择书刊文件、商场选购等他们认为真实可靠的方式。当他们越认为网络信息社会具有很强的不确定性时，他们会更加坚定不移地保持他们所生活的传统社会依赖的客观自然或物质关系的信任视角、信任原则和信任模式。[184]

另一方面，曾经有部分传统大众媒体同保健品广告主一起牟利，让虚假保健品广告话语构建了一种社会认同的虚假“合法性-权威”现实[185]。老年消费者受骗后，只能通过不再赋予信任的“一刀切”方式来打破这虚假的现实，并将此做法延续到数字媒体的使用

[182] 中国日报网：《保健品虚假营销:套路满满、疯狂洗脑,只为拉老人入陷阱》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1605673083950507184&wfr=spider&for=pc，2018 年 7 月发布，2023 年 3 月最后访问。
[183] 刘少杰：不确定条件下社会信任的分化与协调，《江苏社会科学》，2020 年第 4 期，第 61-68+242-243 页。
[184] 同上注。
[185] 王凤翔：广告主对大众媒体的影响与控制分析——基于“广告话语权”视角并以中国医药、保健品广告为例，《新闻与传播研究》，2007 年第 3 期，第 7-14+94 页。

中国知网 https://www.cnki.net

中，出现了媒介偏见的现象。近年来，《广告法》《药品管理法》《药品广告审查办法》及《保健食品广告审查暂行规定》等出台规范和约束了传统媒体对保健品广告的刊播[186]，于是那些曾活跃在传统媒体的保健品无良商家和广告主转战至监管仍不完善的数字媒体平台。软文包装等防不胜防的新套路打击了老年群体的积极性，加重顾虑的老年群体只能对数字媒体的信息抱以不信任的态度。

因此，老年人对保健品“一刀切”的不信任使得老年人对任何媒介上的保健品广告都不信任（M<3），而骨子里对传统社会信任模式的依赖，又让他们对传统媒体上保健品广告的信任程度（M=2.51）高于数字媒体（M=2.08），出现了信任分化现象。这样的媒介信任分化，实则是横亘在老年群体与年轻世代之间的数字鸿沟。就以上两点而言，我们很难改变老年群体对媒介给予有区别信任的思维定式，因为我们无法改变他们生长在传统社会的这一现实。但是我们可以通过法律法规的完善和对平台商家和用户的监管，从积极老龄化重视的社会保障层面发力，打破曾经构建的保健品“合法性-权威”虚假现实。从个体内部击碎对数字媒体不可靠、不真实的先见，从而在积极老龄化的语境中可以放心地寻求健康信息，拥抱数字化。

3. 媒介素养的影响机制复杂

从认知信任（M=2.72<3）和情感信任（M=2.48<3）反映的数据可知，接受调查的大部分老年人不信任保健品，不愿意购买（M=2.53<3），即认为保健营销多为虚假宣传。媒介素养对媒介信任度和认知信任产生正向影响，这也意味着，媒介素养越低的老年人，对媒介的信任度越低，在认知层面越不愿意相信媒介上的内容，反映出老年人实际上并不能完全辨别保健品的真伪，甚至把正规保健品也视作伪劣产品，出现了“一竿子打死”和媒介偏见的现象。

诚然，自上世纪 90 年代以来，我国保健品市场一直面临着供给需求不平衡和社会支持不配套的问题，整个保健品行业水平不够，一度出现了劣币排斥良币的无序市场状态。[187] 若要我国保健品行业向好发展，未来的任务不应该仅停留在让老年人不轻信虚假宣传的保健品广告，而是应该让老年人从认知上能够辨别保健产品的真假好坏，

[186] 刘涛，周蔚昕，寇强，同前注[68]，第 12 页。

[187] 银发产业网：《从中国足球和保健品的管理失败，谈保健营养产业何去何从？》， https://baijiahao.baidu.com/s?id=1653401795140733408&wfr=spider&for=pc，2019 年 12 月发表，2023 年 3 月最后访问。

中国知网 https://www.cnki.net

从而做出正确的选择。如今我国的保健品行业正在不断规范化，消费者也应做出改变，保健品行业才能跳出消费者不信任和商家欺骗的死循环。年老老年人和年轻老年人在媒介素养影响媒介信任度的过程中出现了差异，受教育程度较高和较低的老年人也在也在媒介素养对认知信任的影响中表现出了不同。因此年龄和受教育程度不同的老年人个体在使用媒介时，在媒介素养发挥的作用大小也不同，甚至影响媒介后续的使用结果。[188]

表 2.13 媒介素养与购买意愿之间的中介关系

中介关系	路径系数	T 值	P 值	检定结果
媒介素养 → 认知信任 → 购买意愿	0.022	1.866	0.062	不支持
媒介素养 → 认知信任 → 情感信任 → 购买意愿	0.030	2.077	0.038	支持
媒介素养 → 媒介信任度 → 认知信任 → 购买意愿	0.009	2.039	0.042	支持
媒介素养 → 媒介信任度 → 认知信任 → 情感信任 → 购买意愿	0.012	2.382	0.017	支持
注明： *p-value<0.05, ** p-value<0.01, *** p-value<0.005				

媒介素养是间接影响保健品购买意愿的因素之一，但是其产生影响力的机制比较复杂，如表 2.13 所示。现有文献未能有效解释该结果，本文将会在后续的访谈中对这一结果展开分析。

4. 可靠性感知是最重要的前因变量

无论是对认知信任的直接效应，还是通过认知信任对情感信任、保健品购买意愿产生的简单中介效应抑或是透过认知信任和情感信任的链式中介效应中，可靠性感知都扮演了最重要的角色。这也说明，老年消费者面对保健品广告时直观感受到的可靠程度，很大程度上影响了他们对保健品产品基于认知的信任。男性和女性在可靠性感知对信任产生影响中出现了不同。。

保健品广告神话的构建一般会运用高科技化、自然化、神秘化、故事化等修辞。研究发现，老年消费者认为保健品广告中高科技化（M=2.89）的说辞和话术最为可靠，其次是自然化（M=2.56），最后是神秘化（M=2.31）和故事化（M=2.23）。[189]由此可见，有关高科技的保健品广告最容易迷惑老年消费者，让他们产生基于认知的信任。王凤翔

[188] 丁卓菁：新媒体环境下老年群体媒介素养教育探讨，《新闻大学》，2012 年第 3 页，第 116-121 页。
[189] 王胜源，赵怡森，同前注[31]，第 2 页。

中国知网 https://www.cnki.net

（2007）指出，保健品广告主在构建广告话语时有夸大与虚假嫌疑，而审查把关的大众媒体为了市场利益最大化，默许虚假宣传广告话语，这类广告话语的特征之一就是“科技含量高”。[190]虽然早在 2012 年出台的《保健食品广告审查暂行规定》就已要求保健品广告中禁止出现无法证实的 “科学或研究发现”等方面的内容[191]，但打着高科技名头虚假宣传保健品的广告仍屡禁不止。因此，相关部门应更严格地审核保健品广告内容、打击包装虚假保健品软文的同时，也需要分别完善和加大保健食品及相关广告的监管机制，让数字媒体平台和大众媒体组织对所刊发的保健品广告承担更多的法律责任。

5. 定性研究部分问题的提出

得到的数据虽然能够揭示保健品营销和虚假宣传现象下的因果关系，但也出现了一些新问题：

QR4：为何情感信任比认知信任扮演了更重要的角色？消费者涉入度在其中产生影响的程度如何？伪劣保健品营销是如何提升消费者涉入度和情感信任的？保健品销售人员在情感的建立中扮演了什么样的角色？

QR5：在保健品营销语境中，老年人的媒体偏见现象的确存在。但是目前传统媒体上刊播的保健品广告已经得到了规范，作为传统媒介原住民的老年人为什么现在还是难以相信传统媒介？媒介信任又该如何提升？

QR6：就媒介素养复杂的作用机制而言，媒介素养无法直接通过认知信任影响购买意愿，但为何情感信任和媒介信任度的加入却能让媒介素养发挥影响？

QR7：除了软文推广，新媒介下的保健品营销还有哪些新手段、新套路？

这些新问题难以通过分析数据得到答案。笔者试图通过对既购买过正规保健品也购买过伪劣保健品的老年消费者展开访谈，同时身临其境感受保健品营销活动，开展参与式观察，根据实际情况回答上述问题。

[190] 王凤翔，同前注[185]，第 44 页。

[191] 百度百科：《保健食品广告审查暂行规定》，https://baike.baidu.com/item/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%B9%BF%E5%91%8A%E5%AE%A1%E6%9F%A5%E6%9A%82%E8%A1%8C%E8%A7%84%E5%AE%9A/5711627?fr=aladdin，2012 年 10 月发表，2023 年 3 月最后访问。

中国知网 https://www.cnki.net

三、定性研究：不知如何信任的僵局

笔者根据上一阶段提出的新问题拟定了访谈提纲（见附录二）。从参与问卷的填答者中，寻找了 8 位有伪劣保健品购买经历的老年人展开了半结构化深度访谈，每个访谈的持续时间至少 30 分钟。这 8 位对象都有着一定的保健意识，并拥有较丰富的保健品购买经历，在伪劣保健品上的消费都超过了 3 万元，是因伪劣保健品营销传播和虚假宣传受害的典型人群，能够较好地对老年人购买伪劣保健品的作用机理进行解释。符合混合研究方法的要求。同时，笔者进入以年轻老年人构成为主、售卖伪劣保健产品的养生微信群和网课直播间进行了参与式观察，获取到伪劣保健品使用新媒介进行营销和虚假宣传的一手资料，对研究结论进行完善和补充。

首先对购买或不购买保健产品的老年人的特征进行了归纳，根据老年群体对保健产品的态度可以将老年保健品消费者分为尝试型购买者、无能力/不购买者、狂热型粉丝。

尝试型购买者较为理性，他们有自己的经济收入，具有一定的保健理念，会质疑保健品宣传真实性的同时也愿意进行尝试。访谈对象多为尝试型购买者，他们购买保健品的原因为：自己的慢性病没有特效药，想尝试下保健品是否能稍微改善下自己的身体状态，害怕被骗的同时也不指望保健品是神药能够治好疾病，所以就花一点钱买一些来试一下。如果有效果，可能会继续购买；如果无效果，也不会去维权或报警，就当自己吃了亏，因为花的钱也不多。5 号受访者曾购买过一款号称含有免疫球蛋白的保健产品，“也没指望过吃它能治病，只能说提高下免疫力，换季的时候不感冒……当时还去浙江台州看了生产的厂……后来看成分表发现用的就是牛奶粉，那个时候已经花了 3000 多了。我也想过要去拆穿他们（保健品销售人员），但是那个钱应该也要不回来。还有些人花的钱更多，十几万的都有，我怕我去拆穿了太伤那些人的心了，十几万不是小数目，要不回来更难过。问了女儿，女儿也说我自己只花了 3000 元钱，就算了，让我不要再管了，以后也不要再买了。”1 号受访者曾购买一款号称能降压的保健品，食用后出现副作用导致晕厥，最后因为摔倒后骨折住院治疗。在问到是否选择维权时，1 号受访者表示：“他们（保健品销售人员）领导来专门道歉，买了很多水果、牛奶来医院看我，也把钱全部退给我了。别人吃了也没出现我这种情况，他们道歉态度也很诚恳，我就没想着

中国知网 https://www.cnki.net

要维权了，可能是我自己身体不适合吃这种药（保健品）。那之后我再也没有乱买降压的保健品来吃了，都去医院开药。”其余几位受访者也有类似经历，但是都因为留证难、花的钱不多、怕麻烦、不知道如何举报等，放弃了维护自己的合法权益。并且他们普遍不愿意承认自己购买保健品是被骗了，只能说是“做出的尝试比较失败”，轻信了虚假宣传。

无能力/不购买者与尝试型购买者的区别在于前者并非保健产品的目标人群。笔者与几位从未购买过保健产品的老年人进行了交流。因为对保健品不感兴趣，或是对“保健品营销”相关信息存在戒心，所以笔者仅简单地了解到了他们不购买保健品的原因。一位老人是农民出身，自己没有收入来源，在老伴去世后被儿女接到城市居住，但儿女也并不是很有钱，孙辈也需要开销，儿女给老人的生活费仅能满足日常花销。该老人患有糖尿病，他常去的菜市场附近曾有一个售卖保健产品的门店，提供免费测血糖的服务，店员称售卖的产品可以控制血糖，老人去咨询过产品，但是因为价格太高未能购买，后来该老人前往门店想再免费测血糖，店员却不再搭理他，老人认为自己的自尊心受到了伤害。另三位老年人表示，自己的身体状况很好，没有慢性病，平时连药都不吃，更不需要买保健品。还有一位阿婆说，自己听说可以领鸡蛋跟随邻居去过两次健康讲座，但是她听不懂普通话，讲课的人语速也太快，她无法理解，去了两次也没有领到鸡蛋，后来就不去了，保健品销售人员也没有给她推荐产品。可以发现，不购买保健产品的老年人可以分为三类：（1）经济状况不佳，消费不起保健品；（2）身体状况很好，不需消费保健品；（3）文化水平较低，没有保健理念。具有这些特征的老人，并非因为对保健品有清晰的理解，或是对虚假宣传有特别高的辨别能力，而是因为没有能力或是不需要消费，都不属于保健品销售人员的目标客户。

另一类消费者是保健产品的**狂热型粉丝**。虽然笔者在访谈中未遇到这类对象，但是多位访谈对象提到了他们的某位朋友、亲戚很舍得为保健品花钱。其中 4 号受访者老人说，他朋友在妻子诊断癌症后，疯狂地为她购买各式各样的保健品，这位朋友可能也知道这些保健品宣传夸夸其谈，但自己还是病急乱投医，也抱着“人没了，要钱有什么用”的心态，不理性地购买保健品，一年花费十多万。除此之外，保健品诈骗的相关新闻也反映了部分老年人的狂热心理，如上海浦东 130 名老人被骗 140 多万元[192]，普陀区一

[192] 上观新闻：《买回假冒保健品 130 多名老人被骗 140 多万元》，https://www.jfdaily.com/sgh/detail?id=838242，2022 年 8 月发表，2023 年 3 月最后访问。

中国知网 https://www.cnki.net

老人投资保健品理财项目被骗 20 余万元[193]。作为保健品狂热粉丝的老年人，可能是因为盲目追求健康，愿意为伪劣保健产品并不存在的药用性买单，也可能是因为保健产品被包装上理财的外衣，在“你不理财，财不理你”的诱导下损失大金额钱财。

（一）巩固情感：保健品营销中的人际传播建立强连接

上文已证实，在伪劣保健品营销和虚假宣传的语境中，情感信任比认知信任对保健品购买意愿起着更重要的作用，认知较为理性的老人在情感介入后容易产生冲动消费行为。模型的数据也显示出，消费者涉入度对情感信任表现出了比认知信任更强的预测力。这意味着，提高消费者涉入度以增强情感信任是伪劣保健品营销手段达成的主要目的，消费者因试用体验、礼品赠送、好友介绍等与销售者认识，销售者留下老人联系方式，后续通过上门拜访或继续赠送相关增值服务与老人进一步接触，让老人卷入到保健品相关的活动中，提高消费者涉入度。一旦有了健康相关的共同话题，老年群体在与销售者就会进行高频次的人际传播，销售者通过改换称谓、上门帮忙等方式巧妙地转变了“外人”的身份，建立强连接关系，“亦子亦友”的陪伴让老年消费者相信这份情感的真实性，陷入了不得不为情感交往买单的陷阱。

1. 塑造的“孝子”人设

“在工作时留下了一些病，所以刚退休（1998 年）下来的那几年身体不太好。2001 年的时候，我一个朋友说他在用天年（全称为天年生物）的保健品，用了效果很好，我在报纸上确实也看到过这个品牌的广告，所以在我那个朋友的联系下，天年那边就来人（保健品推销人员）了，上家里来给我介绍产品。这个小妹叫小蔡，很热情，很热心，当时也是刚毕业参加工作。在了解我的身体状态后，小蔡也没有直接就给我卖东西，而是邀请让我去听一个健康讲座，然后回公司给我拿了很多资料来，让我先看一看，斟酌一下。东西买不买无所谓，她自己也有父母，她希望我们老年人能身体健康是最好的……听了讲座之后，我决定买点东西，她也给我们推荐哪些产品适合我，哪些产品不适合我，不让我们花冤枉钱，当时还是觉得挺真诚的。”（1 号受访者）

[193] 潇湘晨报：《保健品免费畅吃还返利？上海一老人被骗走 20 万丨打击整治养老诈骗》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1742331595094317985&wfr=spider&for=pc，2022 年 8 月发表，2023 年 3 月最后访问。

中国知网 https://www.cnki.net

“觉得她这个人很有孝心，她妈妈身体不好，她挣的钱全部寄回家里了……对我们挺上心的，一周要来家里两三次，问问我们身体怎么样了，专门给我们带一些赠礼（膏药、蛋白粉）来，母亲节还上门来给我送花……我们也很照顾她，在她那里买了很多东西。”（2 号受访者，与 1 号受访者为夫妻）

保健品销售人员除了“包装”为医学专业人士外，也会“包装”为一心一意为老年人考虑的“孝子”，获取老人信任。保健品销售人员邀请老年人参加健康讲座、阅读健康资料、赠送试用产品，提高消费者涉入度，而后与老人成为“知心朋友”，在情感的联系中塑造起“孝子”人设，得到老人的认可，讨老人欢心。老人在相信塑造的人设后，便会放下防备，愿意同保健品销售人员建立类似于亲子关系的纽带，逐渐在交往中将销售人员代入“儿女”的角色，自己作为“长辈”应该对“儿女”的“事业”有所“支持”,进而被后者以“假心意”骗取“真同情”。不难承认，打“感情牌”的这种做法是提高老年人的消费者涉入度的一种方式，老年人在满足健康需求和填补情感空缺的情境中，很容易付出金钱。因此，老年人与保健品销售人员的人际传播在发挥了信息沟通的功能后，主要起着沟通两者情感的功能，丰富的情感交流将经济交易的性质弱化，两者的人际关系由弱连接变为强连接。

2. 情感支持的“大家庭”

城市的现代化进程和单位制解体对我国家庭模式类型和社区居民的互动均产生了深远的影响，老年家庭的空巢化以及邻里关系的疏离使得现阶段很多老年人缺乏情感支持和社区归属感。[194]保健品营销为老年人提供了一个人际关系建立与再建立的公共空间，在这个公共空间中，老年人可以认识新朋友、和旧友再聚，保健品销售人员也成为了朋友中的一员，基于“友谊”展开保健相关的信息交流活动。由于朋友们的陪伴，老年人愿意参加保健品相关营销活动，他们的情感需求驱动了消费者涉入度对情感信任的影响，并在人际传播与互动中得到满足。正是这样情感方面的支持，老年人对构成的集体产生归属感，公共空间逐渐成为了老年人心目中的“大家庭”。

“好几年前说熊胆粉可以治疗眼底黄斑病变，我看了下九康公司的宣传，就在它那里买了不少……公司说组织客户去云南参观工厂，也相当于去云南旅游了，我和我老伴就报了名，出去走了一趟。工厂看下来，还是挺资格的，也更放心买他们的熊胆粉。路

[194] 于文洁，郑中玉，同前注[28]，第 5 页。

中国知网 https://www.cnki.net

上还结交了几个跟我一样患眼底黄斑的病友，大家还挺有共同话题的，大家一起分享了缓解视力模糊的经验……”（6 号受访者）

“春天天气好的时候，他们（保健品公司）包一个大巴，组织我们这些老客户出去玩，那一两年基本上把成都周边都玩了一圈。一起去的还有之前的老同学、朋友、同事，大家如果不是因为这个机会很难这样组织起来集体出去玩，还是很开心的……上下车、走路都有小妹小伙子（保健品销售人员）把你扶着，嘴很甜，一切都安排得巴巴适适的（十分周到）。”（1 号受访者）

在“大家庭”中，老人们年纪相仿，往往是几类常见慢性病的患者，大家都热衷于分享缓解病情的各类方法，还会拉其他朋友加入“大家庭”。保健品公司定期举办的健康讲座或病友茶话会，让老人们可以经常相聚。人际传播网络不断扩大，并得到巩固。

“我是有静脉曲张……我最开始本来不想听这种讲座，觉得没病都要给人吓出病，但是一个老朋友让我去，说是还有另外一个朋友也在那，我们也好久没见了，就让我去听着玩，当夏天免费吹吹空调……专家教了一个保健操，讲哪些穴位多按一按对身体有好处，然后就带着我们做，台下大家都在一起做操……后来我回家也在自己做这个保健操，是有点用，按了之后上下楼梯腿没那么难受了……隔几周就要请个专家来给我们讲怎么保健。我想着一个人在家也无聊，朋友也在，我就也去，人多也热闹。”（7 号受访者）

“那段时间糖尿病还有一些并发症把我折磨得有点痛苦，要天天去医院，心情也很郁闷。偶然参加了一个降糖病友会，里面都是和我同样情况的（老年人），还有比我更严重的，他们都还是很乐观，分享自己的经验、土方法……有老师分享卖降糖的药（保健品），我当时病急乱投医也买了一些吃，血糖还是高，看了成分发现其实对糖尿病没什么用，是我一直在控制饮食才把血糖降下来……后面还去参加了几次病友会，虽然东西（保健品）没什么用，但是心情会好很多，像是找到组织了。”（8 号受访者）

保健品营销中，保健品销售人员将某些具有较高消费能力的老人塑造为意见领袖也是一种提高消费者涉入度的手段。

“每次活动快结束的时候，还会从我们（老年消费者）中选一个代表来发言，总结这次活动开展得怎么样，使用了保健品感觉怎么样。一般都是选之前当领导的，他们工资高，有钱，可以买得起（保健品）……有些（退休之前当领导的人）还攀比着买（保健品），我知道的就花了几大万。”（2 号受访者）

中国知网 https://www.cnki.net

刚退休的老年人离开工作空闲下来，产生了生活上的失重感和情绪上的失落感。通过“作为代表发言”制造身份认同，满足了一些刚退休老人的虚荣心，让他们觉得自己在退休后还能受人尊敬，曾经的政治地位还未过期，“说话还是有分量的”，所以会更加依赖保健品活动构建的公共空间来满足自己的社会需求，进而通过消费行为维持关系。保健品销售商也达到了盈利的目的。

上一部分的数据显示，情感信任比认知信任扮演着更加重要的角色，几位受访者所述也证实了这一结果。老年人的消费行为虽然表面上表现为为保健产品买单，但实际上是在为维系情感的社交关系和社交空间买单，因此在保健品消费中情感信任的内涵远大于认知信任。保健品销售人员在情感的建立中扮演的角色是多元的：是愿意倾听老人想法和抱怨、认可老人年轻时经历的朋友，是十分有孝心的儿女、孙辈，是拥有健康养生知识的老师，是费心将老朋友们联系在一起的组织者……多重身份满足了老人各方面的情感需求，美化了牟利的真实目的。

（二）传统媒介：草木皆兵，难以信任

结构方程模型的数据显示，老年人无论是对传统媒介还是新媒介上的保健品广告都持着不太相信的态度。8 位被访者都表示，因为自己对新媒介的掌握度不高，无法独立进行移动支付、线上付款等操作或是认为网上售后操作过于繁琐，所以更愿意选择自己更有把握使用的传统媒介选择保健品。

4 号受访者（与 3 号受访者为夫妻）：“我老伴年纪大了，患有一些慢性疾病，虽然没有到必须要去医院开药的程度，但是平常还是会感觉身体这里不舒服、那里不对劲。为了让他不那么难受，我有些时候看报纸、杂志的时候发现上面登了一些保健品的广告，专门缓解他的症状，宣传的效果不错，就打电话联系那边（保健品公司）想买来尝试一下，那边就有人给你详细介绍。网上的东西，有时候我自己搞不明白怎么操作，太麻烦了。”

1 号受访者：“纸质的东西拿在手里，感觉起来更可靠，毕竟白纸黑字印出来的，应该不会是骗人的。电视上能放出来的（广告），多半也不会是胡编乱造的。但是网络上的信息太容易造假了，视频都能合成，我分不清楚真假。网上卖的保健品肯定有真有假，但是我觉得感觉受骗的概率更大。”

中国知网 https://www.cnki.net

8 号受访者："主要是在网上买东西太麻烦了。搞不清楚付款（的操作），就算多付了我也不知道……退货也麻烦，操作不来就只能吃哑巴亏。"

但老年人对传统媒介上保健品广告的信任度仍略高于新媒介，仍存在着一定程度的信任分化。作为传统媒介原住民的老年人难以相信传统媒介及其播发的保健品广告，是因为避免使用新媒介仅通过传统媒介选择保健品并非是万无一失的，信任也在此过程中被消耗。

1. "狼来了"效应：消耗殆尽的信任难以重建

"现在骗人的东西太多了，是真是假有时候自己心里也没底，所以就少买一点（保健品）来试试。之前在报纸上看到的一条保健品广告，说是能治我这个病症，就买了回来吃，但是吃了一瓶觉得没有什么效果。女儿有次回家来看我们，说这个保健品就是假的，让我们不要再买了，也告诉我们现在电视、报纸上也有骗人的，不要太容易相信了。"（3 号受访者）

"电视剧播完的时候，经常会继续放一些健康讲堂的节目，有几个专家是老中医，说的内容也挺有道理的，比如肠胃不好是因为湿气太重需要食疗之类的做法，我也是赞成的。但是在老中医分享结束之后，节目上还邀请了一些买了保健品的人分享自己的经历，这些人看起来太像托了，就是为了吸引我们去买保健品。所以我觉得这些健康类的电视节目都不太可信。"（5 号受访者）

多年来，传统媒介上的保健品虚假宣传广告令人诟病。2014 年，广电总局叫停了健康类养生节目"健康 365"。这样做看似让肆意妄为的伪劣保健品营销沉寂下来，但其随后摇身一变，更名为"枫叶正红"节目，同时在黑龙江卫视、吉林卫视、西藏卫视、河南卫视等 7 家省级卫视播出，以养生讲堂形式对保健品进行夸大宣传,打着养生的旗号继续售卖保健品[195]。不少伪劣保健品广告换汤不换药，钻法律法规的空子再次通过传统媒介进行宣传。2017 年，广电总局发布通知，要求立即停止播出"苗仙咳喘方"等 40 条违规广告，并指出这些广告"时长均长达 10-30 分钟，违反了总局医疗、药品、医疗器械、保健品、食品、化妆品等广告单条不得超过 1 分钟的规定""还存在以节目形态变相发布或以电视购物短片广告形式播出，夸张、夸大宣传，以医生、专家、患

[195] 海外网：《养生类电视节目"枫叶正红"被指顶风促销保健品》，http://m.haiwainet.cn/middle/352345/2014/1029/content_21299124_1.html，2014 年 10 月发表，2023 年 3 月最后访问。

中国知网 https://www.cnki.net

者、公众人物等形象作疗效证明等违规问题”。[196]但这依然未能根治传统媒介上伪劣保健品无良宣传的乱象，“神医宇宙”的广告再次进入人们的视野中。传统媒介上的伪劣保健品营销和虚假宣传未能扼杀又不断出现，反复之下，老年人对刊发伪劣保健品广告的传统媒介逐渐失去信任，且难以重构。

2. “披着羊皮的狼”：漏洞中的品牌假新闻

Lazer 等人（2018）将品牌假新闻定义为：在形式上模仿新闻媒体的内容，在意图上为达成自己的目的而捏造信息[197]。一些伪劣保健品的广告冒充传统媒体形式出现，传播品牌假新闻——虚假广告，让老年人难辨真假。

“前几年还在订报纸（华西都市报）的时候，送来的报纸中有时会夹一些彩页资料，是宣传健康信息的的报刊。我那时确实以为是报社在为新刊做宣传，夹在里面的，我当时还仔细看过，是专门讲心脑血管病的。我心脏不好，感觉它（资料）推荐的那个中药还挺有用的。报纸也订了那么多年了，宣传的东西应该不会假，就先花了 300 多买了两盒来吃。但是吃了感觉没什么用，他（销售人员）说至少吃够一个疗程才见效，我就又花了 1000 多买够一个疗程的药来吃，吃完了也没什么效果，我就不吃了。后来（销售人员）又打电话来，说现在他们在和（四川）电视台合作，回馈老客户，买一送一。我不愿意买了，管他和谁合作，我都不会信了。”（4 号受访者）

这些“健康资料”有时候裹在订阅的报刊中送达老年群体，有时候被包装为专业书籍免费给老年人。

“之前购买过一些保健品，留下了电话和地址。那之后就有另一个人给我打电话，是其他公司的，但不是要给我推销保健品，只是说给我寄点糖尿病有关的健康资料书，免费的，都是攻克了专业医学问题的专家写的，老年人可以多看看，对身体好。我想着是专业的老师写的书，而且也是免费的，寄就寄吧，他也没有强制购买什么东西。收到书籍后，他又给我打电话，说免费给我寄一盒药试一试，按照书上的方法去使用，我想着那就试试吧。试用之后觉得好像有点效果，毕竟是宣传的是军医大学教授的最新成果，就花钱买了一些（保健品）。但是后面就觉得效果不明显了，打电话

[196] 国家广播电视总局：《国家新闻出版广电总局办公厅关于立即停止播出“苗仙咳喘方”等 40 条违规广告的通知》，http://www.nrta.gov.cn/art/2017/6/23/art_113_34125.html，2017 年 6 月发表，2023 年 3 月最后访问。

[197] Lazer D M J, Baum M A, Benkler Y, et al, “The science of fake news,” *Science*, Vol.359:6380, 2018, p.1094-1096.

中国知网 https://www.cnki.net

过去问，已经是空号了……再到后来，没有人给我打电话推销的情况下，我也会收到陌生的快递，里面也是一些健康刊物、杂志。估计我的信息已经泄露出去了，我也没办法，不知道怎么办。”（2 号受访者）

2 号受访者为笔者提供了她收到的健康资料。资料之一为一本杂志，名为《发现中医》（长寿养生报专刊），如图 3.1 所示，在表面上与正规发行的刊物好像没有太大区别，但前者没有国内统一刊号，实则是保健品公司自制的野杂志。该杂志凭空捏造了一个名为徐洪良的“中国螺旋藻之父”，围绕这位“美国中医学科学院院士”的“研究成果”，将螺旋藻包装为能治疗多种慢性病的神药，附上后期合成的荣誉证书、科研成果奖证书，同时将慢性病相关的调查数据断章取义，给老年人制造疾病焦虑，然后附上患者痊愈的故事和健康热线，达成推销的目的。整本杂志的内容几乎都是没有科学依据的言论，属于虚假宣传，但是其呈现形式模仿了正规杂志，内容包括了新闻报道、专家评述、采访、科普等。

资料之二为一份报纸，名为《自然康》，如图 3.2 所示。翻阅该报，可以发现其刊登的内容包含了一些政治新闻（如我国航母威慑英国、贪污“老虎”落马、津巴布韦政变、巴铁大赞中国步枪等）和社会新闻（卖淫团伙被抓、00 后 CEO 回国融资、交警拦下摩托强制安装 GPS 等），仅有部分标注了转载来源，其它部分的真实性值得质疑。这些新闻排版穿插在作为该报主体内容的健康信息之中。报上的健康信息涉及到了眼部疾病、肠道问题、前列腺疾病、耳鸣耳聋、失眠问题、风湿骨病等，强调这些疾病会导致严重后果，再附上“国药秘方”“百用百灵”“不开刀”等词进行虚假宣传，吸引老年人购买保健产品。

保健品公司自制了所谓的健康养生期刊或是以养生电视节目的方式售卖保健品，虽然没有刊号、发行号，但却通过模仿与伪装，将媒介素养不高的老人迷惑。在老人眼中，他们是通过传统媒介选择的保健品。但是当老年人经历过欺骗之后，他们也不愿意再相信传统媒介上的健康信息，无论是否是正规报社发行的报纸、报刊杂志，出现了上文提到的“媒介偏见”现象，也解释了传统媒介原住民的老年人为什么现在还是难以相信传统媒介。

中国知网 https://www.cnki.net

图 3.1 伪健康杂志《发现中医》

图 3.2 伪健康报纸《自然康》

（三）新媒介：网课直播新套路

除了软文，网络直播也成为了伪劣保健品营销的渠道之一。网络直播让线下的健康讲座摇身一变为线上的健康网课，其内容皆为夹带“私货”。笔者通过一条社交网站上的留言联系到了邓小姐，邓小姐告诉笔者：“我妈妈从 19 年就开始看这类直播网课……2020 年疫情爆发后，这些人就开始说他们的产品可以治疗新冠，是国际上的最新成果，很多人信这些，群的规模越来越大。（他们）除了卖内服的，还卖香皂、药包……我妈妈特别信他们说的。”在邓小姐的帮助下，笔者联系到了邓小姐的母亲，并通过她进入了开展健康网课的养生微信群。

1. 躲在网络监管死角的养生微信群

邓小姐的母亲告诉笔者，群员要邀请新人进群首先需要向群主报备，同意之后才能拉人，邀请的人必须 50 岁以上。在等待后，笔者终于进入了两个养生健康微信群，开展参与式观察。

在进入有群成员 187 人的“身心灵皆健康 107 群”后，群主“邵艳”发出了群规（图 3.3），要求新成员遵守，否则将被踢出群聊。群主随后也添加了笔者，并告知可以向她咨询任何方面的健康信息。在该群中，群主每天早上都会在群里发布向群友们问候早安的信息，然后发出第一个红包，为上午场的直播预热，并为群成员留下“课堂作业”（图 3.4），调动群员学习“健康”知识的积极性。下午场直播开始前，群主会在群里分享健康、

中国知网 https://www.cnki.net

医疗有关的视频、讯息，以图 3.5 种的内容为例，群主分享了一条广西卫视报道有关一名心血管病人被放 7 个支架的新闻视频，该新闻本为事实，但是在群主的断章取义下，向群友们传达“现在医院治病乱象丛生，过度医疗现在屡屡皆是”的错误观点，并提出“保健养生提前做好”，暗示群友们“购买保健产品治好病，不要进医院，医院坑人”，吸引群友观看“养生保健”直播。多次提到的主讲人“孙院长”被介绍有着丰富的医学诊疗经验，曾在多家知名医院任职，擅长主治心脑疾病、骨科疾病、泌尿疾病和内分泌科（图 3.6），但是在互联网上却查无此人，身份信息皆为捏造。

另一个群为“蜂行天下福利群”，共有群员 263 人，也是需要群主同意、群员邀请才能进入。群主“A 奋斗”除了发布和“身心灵皆健康群”中类似的健康课程直播链接、健康养生信息和有奖答题之外，还会在每次直播结束后发布一些团购信息，以较高的价格售卖直播推荐的产品。邓小姐告诉笔者，该群为“风行天下大讲堂”的粉丝群，“风行天下大讲堂”曾邀请了多位“教授”讲课，其中一人为河南大学医学院某一教授（张清泉），邓小姐向河南大学进行了举报，河南大学表示之前也接到过类似举报，早已警告该教授禁止对外授课，而后“风行天下大讲堂”换了一位老太太作为主讲，并将原来的群解散，重新建立了新群。由此可见，行动在网络中的伪劣保健品销售人员都会对入群人员进行审核，避免“无关人员”进入，降低被举报的风险，在网络中难以被监管的死角里售卖伪劣保健产品。

图 3.3 “身心灵皆健康”群规

图 3.4 身心灵皆健康”上午场直播预热

中国知网 https://www.cnki.net

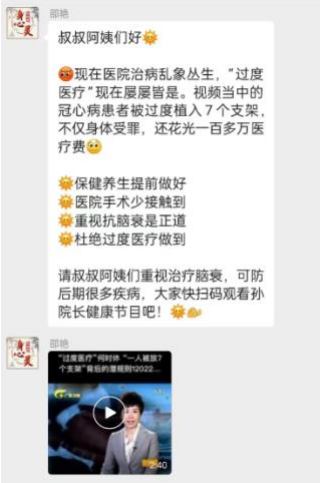

图 3.5 “身心灵皆健康”下午场直播预热　图 3.6 “孙院长”介绍

图 3.7 “身心灵皆健康”上午场健康直播　图 3.8 用户个人信息栏

2. “新瓶装旧酒”的健康网课直播

扫描“身心灵皆健康”群中的直播二维码后，首先需要进行用户注册，注册后才能观看直播。该直播是通过网页进行的，在用户观看直播的过程中，用户还可以在屏幕下方进行有奖答题（图 3.7），若答案正确，将答题界面截屏，联系群主领取红包。红包一般在 0.5 元左右。每个用户的资料栏中，还有观看健康直播的活动参与记录、领取到的“健康金”（小额红包）等信息，如图 3.8 所示。

“蜂行天下福利群”采用的直播平台为微信小程序“小鹅通”，在晚上 7 点直播的是名为《十二时辰》的养身节目，该节目的简介为“一档以‘传播养生之道、传授养生之术’为

中国知网 https://www.cnki.net

宗旨的大型社群专栏节目。它创办的初衷是：‘旨在让每个人成为养生知识的传播者和受益者’”。笔者收看了 2022 年 8 月 22 日的直播，如图 3.9 所示。主讲人为一位身穿橘色上衣的短发女性，评论互动区称其为“张老师”。虽然形式是直播，但是能发现有很明显的剪辑痕迹，实则为录播。视频中的张老师面前摆放了一个盛有茶水的茶壶和一个茶杯，和观众们侃侃而谈，在半个小时的直播中，聊到了甲状腺、失眠症、免疫力低下、妇科疾病、脑部疾病等问题，一边直播一边喝“龙须红”茶，并告诉受众“该茶含有矿物质微量元素，可以增强免疫力”“疫情还未结束，免疫力十分重要”“老百姓都知道是药三分毒”。虽然张老师基本在说提到疾病的病症，未明确说“龙须红”茶能治何种疾病，但是实际上是在引导受众将两者联系起来，暗示受众“龙须红”茶能治疗多种疾病，缓解各种不适症状。在直播的最后，张老师开始了推销：“99 元 3 盒就可以拿到，每一盒还是 30 袋，也就是说 3 盒 90 袋，我们今天争取到了 500 套，大家一定要尽快找到你的群主，名额有限下单购买。”在这场直播中，参与人数达到了 1.4 万人，直播过程中有观众在评论区积极互动，邀请人数排行榜显示一位用户邀请了 390 位好友参与这场直播。

图 3.9 《十二时辰》栏目直播

无论是线下的健康讲座，还是线上的养生网课、直播，实际上都是伪专家、伪医师用错误的健康信息诱导老年人购买没有实际功效的伪劣保健产品，从线下转移至线上，将鸡蛋、香皂等奖品换成了微信红包，不过是新瓶装旧酒。但是在部分老人眼中，听这样的健康网课既能增长健康知识，又能打发时间、有钱领，形式与以往的保健品诈骗不

中国知网 https://www.cnki.net

同，很难将两者联系起来。值得注意的是，无论是“风行天下大讲堂”还是“身心灵”健康讲座直播，都无法回放，且不能在互联网上搜索到相关信息。这说明伪劣保健品销售人员明白如何规避网络监督开展保健品营销和虚假宣传活动，也利用了老年人媒介素养不高、难以分辨信息真伪和信息不对称的弱点进行欺骗。

（四）媒介素养

上一部分中模型的结果显示，媒介素养无法直接通过认知信任影响购买意愿，但是媒介信任度和情感信任加入后，媒介素养便产生了影响力，即使没有感知可靠性和消费者涉入度的影响显著，但也不容忽视。武晓立（2020）指出，媒介素养的高低与媒介选择和使用结果有着密切的联系[198]，选择不同的媒介也反映出了老年人对媒介的信任程度是有所区别的，这使得媒介素养的作用机制变得复杂。

“因为花了几次冤枉钱，现在买保健品还是比较理性，会多比较一下。不管是看电视还是看微信，都不能只听宣传广告的一面之词，不然又要被敲（诈）。”（7 号受访者）

“好几年前我上街的时候，药店（工作人员）给我发脑白金的传单，说是做活动有优惠，我当时觉得这个宣传有点夸大了，就没买。后来看到电视上经常放脑白金的广告，印象很深刻，就慢慢觉得好像脑白金应该还挺用作用的……之后又经过那个药店，正好碰到邻居买了好几盒，说是跟我再拼一盒，更便宜点，我就也买了一盒。”（6 号受访者）

可以发现，当老年受众在媒介上看到了一条保健品信息时，如果他们认可信息内容，会对该信息产生基于认知的信任，但是这并不是老人们购买保健品的必要条件，因为他们“已经受骗上当过几次”，对自己的选择“不太自信”，所以没有足够的理由支持他们出现消费行为。而如果这条保健品信息也出现在常看的电视台、报纸、公众号上，或是熟人、朋友也对该信息进行转发推荐，老年人便会认为自己的选择得到了支持。除此之外，如果老年人在接受信息后，又接触到了保健品销售人员，在和销售人员的沟通和交流中产生了基于情感的信任，也会出现消费行为。所以，媒介信任度和

[198] 武晓立：跨越“数字鸿沟”:社交媒体时代老年人媒介素养的提升，《青年记者》，2020 年第 25 期，第 16-17 页。

中国知网 https://www.cnki.net

情感信任是媒介素养经认知信任对购买意愿产生影响的必要条件，其作用机制如图 3.10 所示。

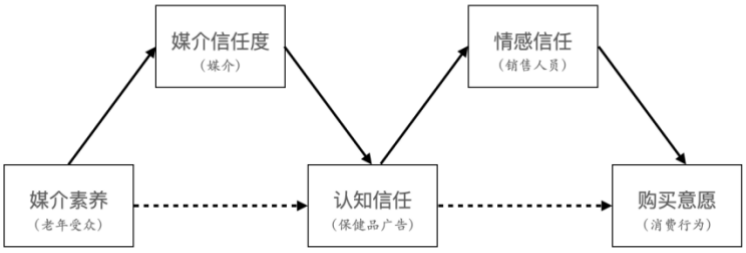

图 3.10 保健品语境下媒介素养作用机制

该机制在笔者对养生微信群的参与式观察中也得到了证实。在群中，面对群主发布的售货信息，老年群友可能会询问几句，但反应没有太强烈，而当他们收看完养生网课之后，自己的选择得到了网课主讲老师的肯定，同时“微信上的官方直播是正规的”的潜意识让他们对微信直播有着较高的媒介信任度，在其他群友纷纷下单“疯抢”的氛围下，老年人很容易产生消费行为，在网课结束后群中都会出现老年群友买货信息刷屏的现象。也有一些老年群友与群主建立了情感上的信任，据邓小姐的描述：“我妈妈的一位朋友很早就进群了，本来不怎么买东西，后来和群主关系搞好了之后，就更相信他们说的话，零零总总买了一堆东西，还一直在帮群主拉人，我妈也是她拉进去的……我妈是因为有我劝着，总共花了一千多，不然跟着那个朋友能花更多钱。”这也证明，网络中的情感信任依旧对购买意愿发挥着重要的影响。

根据模型部分得到的数据，上图中各变量涉及到的影响都是正向的。这也说明，媒介素养越高的老人，并不会仅因为有较高的认知信任便出现消费行为，而是会根据媒介的可信程度和销售人员的现实交往情况做出判断。因此，无论是正规保健品的突围，还是伪劣保健产品整治，媒介信任度的提升以及情感信任的正确建立都是需要重点关注的。

中国知网 https://www.cnki.net

（五）保健产品消费中的积极老龄观

1. 老年人追求健康与社会参与的积极心态

“积极老龄化”中的“健康”是一个动态的、全生命过程的概念[199]，是“参与”和“保障”的基础。健康的老年人被视作是家庭、社区及经济发展的宝贵资源。在保持健康的情况下，他们愿意学习新技能、新知识，进行社会参与，积极面对老化的心态让自己的老年生活焕发出新的生命力。受访者在聊到他们购买保健产品的动机时，都表达了积极、主动追求健康的意愿，保持健康的目的也是为了让自己的晚年生活更有意义。这正是积极老龄观的体现。

“（购买保健产品）目的主要还是为了身体健康……倒没有想去追求长命百岁，只要平时能自己去买菜、买东西，做家务活能自己做，有精力就练练字、看看报纸，了解下国家大事，就已经满足了……玩手机还能看到一些世界美景、名画、有深度的文章和视频，那些都是书上和电视上看不到的，我都 80 多岁了还能再了解新事物，如果放在几十年前基本是不可能的事。只要不和社会脱钩、意识还清楚、生活能自理，我的老年生活就是有意义的。”（1 号受访者）

“追求健康当然重要啊！吃药、吃保健品不就是为了身体健康嘛，身体好，心态好，人才有精气神，不然一天病恹恹的，还有什么活头……晚辈些来看我，应该是大家在家里开开心心一起聊天，如果是他们围在病床旁唉声叹气，我觉得（人生）就没意思了。”（7 号受访者）

“真的怀念年轻的时候，那个时候没有自来水，去河边担四五十公斤的水走两里地回家也不觉得累，还能砍树回来做家具……现在老了，手关节变形，做什么事都不顺手。如果能有缓解手变形、保持身体健康的法子，我当然愿意试试啊，谁不想再做做年轻时候做的事。”（8 号受访者）

可以发现，老人们的看法和经历都不约而同强调了健康的重要性，认为追求健康的目的并不是单纯地延长寿命。除了不想在生活上给家里晚辈添麻烦以外，老人们还指出了保持健康能够为持续学习、提升生命质量、进行社会参与和实现自我价值打好基础。其中，追求数字化成为了老年人提升晚年质量的方式和标志之一。

[199] 邬沧萍，彭青云，同前注[61]，第 11 页。

中国知网 https://www.cnki.net

“因为眼底黄斑病变，我的视力一直不太好，最严重那几年就只能勉强看看电视，因为可以听到声音，看书看报是很困难的。后来开始去医院治疗，动了手术，出院之后视力恢复了一些，可能因为年纪大了，恢复得不是很好。去打了针，也不见太大效果。所以去药店买了一些叶黄素咀嚼片（保健产品）来吃，也开始调整饮食，吃肝，吃胡萝卜、玉米……现在病情稳定下来了，视力说不上好，但平常生活也够了……女儿给我换了智能手机之后，我现在玩手机也比较熟练了，除了发微信，我还会用小年糕做电子相册，会编辑拼图，会拍视频，会微信转账和发红包。每次同学聚会结束，都是我把拍的照片做成电子相册，因为他们都不会做，只有我会做。比起同龄人，我还是算‘时尚’的。”（2号受访者）

“我会用拼多多网购，跟微信（免密支付）绑定的，点一下就直接下单了，很方便，买一些小东西还真的很划算。像我爱人（4 号），眼睛不行，没法长时间看手机，我想教她（网购）都没法教。我的眼睛比她健康，我就比她多掌握一项技能，所以当然要追求健康啊。”（3 号受访者）

可以发现，老人们拥有健康的身体条件是学习和掌握数字技术的基础，Ly 和 Sun 证明了老年群体的互联网使用行为和他们的自测健康有着显著正相关关系[200]。这佐证了积极老龄化理论中健康是社会参与的前提这一观点。

“退休之后，我喜欢上了打太极拳，打了那么多年，现在也成了我们那一片太极拳爱好者的老师……前年摔倒骨折了之后，就总觉得身体大不如前了，就算骨折伤恢复了，做事情都比以往更容易累，所以我就没有再去带学生打太极了。他们（太极拳学生）就一直打电话来，问我什么时候回去带他们打太极，说没了主心骨，他们都聚不起来了，特别盼望我回去。其实我知道他们说的话很大程度上还是为了哄我开心，但是我觉得他们还是需要我的，所以就想快快好起来。当时有个朋友说应该是摔那一跤伤到元气了，给我推荐了一个中药保健品，能够活血化瘀，我吃了之后确实好一些了，不过感觉药本身应该没什么药效，主要是给我了心理安慰，精神好一些了，没有之前难受了……我又继续去广场，先是说只带他们晨练，因为太容易累了，后来过了两周感觉没那么容易累了，就继续带他们晚练，像之前那样。老伴没和我住一起，我一个人在家，没人说话就容易东想西想，和出来学生们在一起有人说话，能感受到他们积极的心态，整个人也好

[200] Lyu S, Sun J, “Internet use and self-rated health among Chinese older adults: the mediating role of social capital,” *Geriatrics & Gerontology International*, Vol.21:1, 2021, p.34-38.

中国知网 https://www.cnki.net

起来了。我的学生们很感谢我教他们打太极，但我更很感谢我的学生们，陪伴我、认可我。”（5 号受访者）

从上述受访者的回答中可以发现，老年人可能因为不满足于身体现状，或是自认为身体需要某种物质才能调整而购买保健品，也可能为了寻求心理安慰购买保健品。积极老龄化理论认为，健康不仅仅是生理上没有病痛或衰弱，更指躯体和心理上即精神层面都要处于完满的状态，所以积极老龄化中的健康是一个多维度的概念，包含了自测健康（self-rated health）、身体健康（physical health）和心理健康（mental health）[201]，这三者也都体现在老年人通过选择保健产品主动追求更健康状态的过程中。但部分老年群体追求健康的心情是迫切的，一旦“操之过急”，就很容易落入伪劣保健品营销人员的虚假宣传和恐惧诉求的“陷阱”之中，对自身自测健康、身体健康和心理健康的认识产生偏差。目前可以肯定老年人购买保健产品的出发点是正确的，但是塑造老年人正确的健康观成为了更重要的议题，如何引导老年群体科学认识自测健康、身体健康、心理健康，理性选择保健品，是未来值得进一步探讨的问题。

2. 家庭数字反哺的积极帮助

积极老龄化理论要求老年人要以积极的态度面对老化，同时国家、社会、家庭要积极帮助老人实现自我价值。“保障”维度对家庭提出了要求，因为老人进行再社会化的最小场所是家庭，同时家庭反哺也是老人们在数字时代中学习新技术的最大依靠[202]。在保健品消费语境中，保健品商家往往利用信息不对称的相对优势欺骗老年消费者。当老年人无法根据自己的能力判断信息真伪的时候，会选择询问子女，因为年轻的子代们能通过互联网查询信息，帮助老年人消除了与保健品销售方之间的信息不对称。

“现在看电视，看到有些广告，还是会动心，想着是不是能治我这个病（前列腺）。但是自从上次女儿看到我买的东西，告诉我是被骗了之后，我现在看到哪样东西（保健品）好，也不会像之前那样直接去购买了，我就先打个电话问问我女儿，她分得清楚……有一次我看到四川卫视放了一个广告，我听起来不错，是一个澳洲的药

[201] 蒋俏蕾，陈宗海，同前注[62]，第 11 页。
[202] 周裕琼：数字弱势群体的崛起:老年人微信采纳与使用影响因素研究，《新闻与传播研究》，2018 年第 7 期，第 66-86+127-128 页。

中国知网 https://www.cnki.net

（保健品），害怕再向之前那样被骗，就问了她（女儿）。她去查了下，发现手机（淘宝）上有专门卖的，说这个是正规的，就给我买来吃。”（3 号受访者）

“报纸上推荐了一个太极磁疗仪，资料介绍说能疏通经络、能理疗，治疗风湿骨病。我每年一到冬天就难受，如果这个仪器能缓解我的症状（关节晨僵）就好了。但是买一个要花 3000 块钱，还是担心自己花冤枉钱，所以就把广告发给了我的孙子，让他帮我在网上查一下，年轻人懂得多。我孙子告诉我，这个（太极磁疗仪）根本没有广告上那些功能，就是一个能发热的塑料板子，网上也能查到和这个（太极磁疗仪）有关的骗局。幸好问了下，不然又要被骗了……”（5 号受访者）

王树新指出，积极老龄化指个人能继续参与社会活动，保持健康，对社会做出有益贡献，家庭和社会能为老年人创造参与活动和学习的一切可能机会和条件[203]。家庭的积极帮助为老年人选择保健产品提供了可靠的保障。但在访谈中也进一步发现，子代进行的数字反哺并未完全到位，尽管受访老年人会通过子代的帮助求证信息真伪，实际上大部分老年人仍不能通过自己的能力判断信息真假。

“孙子告诉我可以‘百度’，但是我打开（百度）之后，也不知道该怎么搜、搜什么……”（5 号受访者）

“……家里孩子说（购买保健品）要看什么标志，但是我记不太清楚。我上次碰到买生命酶的几个小妹（保健品销售人员），她们告诉我这个产品是能够减缓细胞衰老，能够治疗我的慢性病。这个产品是国家认证过的，还当着我的面在网上搜给我看，网上也有这个保健品的资料，包装盒上有批号，应该是正规的。”6 号受访者向笔者分享自己的经历，并展示购买的“生命酶”产品，如图 3.11 所示。但笔者发现该产品瓶身没有保健食品要求的“蓝帽子”标志和保健食品批准文号，仅有产品标准代号和生产许可证编号，且产品类型标注为“压片糖果”，配料成分也并不具备保健功能。查询相关资料后发现，瓶身上标注的生产执行标准 SB/T10347 是压片糖果的的国家规定标准。这也说明，该产品实质上是糖果，也是在符合国家标准的情况下生产的，但是保健品销售人员在推销环节用话术将普通糖果包装为神药，欺骗老年消费者。但是老年人很少采取视频、音频的方式留证，发现被骗后仅凭购买的产品很难维权。6 号受访者很遗憾地表示，“本以为留了一个心眼了，没想到还是被骗了。”

[203] 王树新：北京市人口老龄化与积极老龄化，《人口与经济》，2003 年第 4 期，第 1-7+13 页。

中国知网 https://www.cnki.net

老年人虽然有搜索信息判断真伪的主动动机，但媒介素养不高，有心无力，导致被保健品销售人员采用新手段行骗。老年人只有提高媒介素养，自己辨别信息真假，才能在无法及时与子女沟通和联系的时候做出正确判断。

“女儿上次发现我被骗之后，就让我通通别信报纸电视上宣传的，别信那些卖保健品的。”（3 号受访者）

“娃娃说不能买，是骗人的，我就不买了，但还是想让孩子教一下我怎么去看（辨别保健品真伪）……主要他们一天到晚工作也很忙，问多了怕他们觉得麻烦。”（6 号受访者）

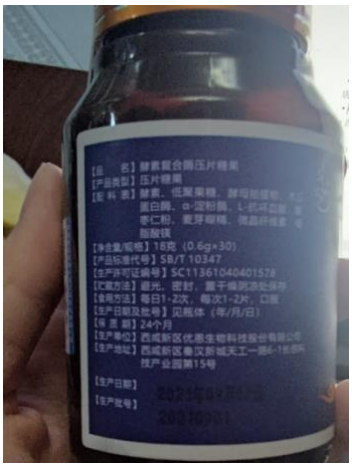

图 3.11 6 号受访者购买的“生命酶”产品

由此可见，儿女们面对老年人购买保健品的情况，更多的是去制止，告诉老年人不要相信，或是自己帮老年人做出判断。但事实上，儿女们将老年人“保护”得太好，不利于老年人追求健康，实现积极老龄化。老年人通过自己的能力选择正规保健品、抵制伪劣保健品，也是自我价值实现的一种方式，更加符合积极老龄化健康层面的议题。授人以鱼不如授人以渔，子代应该对老年人进行更有效的数字反哺。

中国知网 https://www.cnki.net

四、结论

（一）结论

在我国保健品营销的语境中，消费者的信任是核心要素。本研究构建的双中介模型揭示了认知信任和情感信任发挥作用的路径，证实了认知信任中介媒介素养、媒介信任度、可靠性感知、消费者涉入度与情感信任之间的关系，中介后三者与购买意愿之间的关系，发现情感信任在认知信任、消费者涉入度对购买意愿之间发挥了中介作用，在此基础上还证明了存在一系列的链式中介效应。在随后的访谈和参与式观察中，对上述影响因素和机制进行了溯因，进一步丰富了数据得出的结论。

本研究的结果丰富了认知信任和情感信任相关前因的文献。此前研究已反复确认认知信任是情感信任建立的基础[204]，也有不少学者以认知和情感信任作为理论基础对消费者行为进行探究[205]、[206]，本文考察的是集体主义下的中国老年群体，关注这一群体的保健品消费行为，在证实情感信任建立在认知信任之上的同时，进一步发现了前者比后者能发挥更大的影响力，访谈部分对情感信任如何超越认知信任对消费行为产生主要作用进行了有效解释。本文发现的特定文化语境下的特定群体表现出的新特征，对先前信任研究指出的中西方差异进行了补充。本研究还兼顾了老年群体线下消费和线上消费的场景，以及人际传播和媒介传播在老年人构建信任过程中的交叉作用，发现了媒介素养复杂的作用机制并对其成因展开分析，印证了老年受众对媒介给予信任是一种以获得益处为目的的委托关系[207]，并补充了媒介信任度发挥中介效应的文献。

除此之外，本研究从积极老龄化的视角解读了老年人选择保健产品的目的和做法。老年人购买保健产品本质上是对健康的积极追求，除了有不想麻烦儿女照顾的想法外，老人们还会为了持续学习、提升生命质量、进行社会参与和实现自我价值追求身体和心里上的健康。但是在这一过程中出现了数字反哺不到位、健康知识引导不正确、媒介及分发内容未完全规范、社区作用未完全发挥和保健产品行业信任危机等问题，亟待讨论

[204] McAllister D J, 同前注[14]，第 4 页。

[205] Singh K, “Influencer Marketing from a Consumer Perspective: How Attitude, Trust, and Word of Mouth Affect Buying Behavior,” *European Integration Studies*, Vol.15, 2021, p.231-241.

[206] 宗文宙：消费者认知信任影响因素分析，《商业经济研究》，2021 年第 11 期，第 58-61 页。

[207] Strömbäck J, Tsfati Y, Boomgaarden H, et al, 同前注[99]，第 17 页。

中国知网 https://www.cnki.net

和解决。

1. 信任的核心作用

理性选择论认为，在理性做出决定是否信任他人时，除了会慎重衡量潜在收益和潜在损失，还会考虑对方失信的可能性。[208]在保健品消费语境中，老年人的媒介素养水平、对媒介的信任程度、对保健产品及宣传感知到的可靠性和消费者涉入度为老年人从理性层面建立认知信任提供了参考依据，老年人根据这些因素做出决定的过程也反映出了他们在“收益-风险-成本”中进行了衡量。因此，消费情境下认知信任发挥影响作用的逻辑得到了很好的解释，研究结果丰富了认知信任的内涵。

但是在中国文化的作用下，信任不单是理性的、基于认知的。在中国人的日常生活中，人际信任边界之内是“自己人”，边界之外是“外人”。原本毫无亲缘关系的两人在生活交往中因为互相认可、欣赏、赞同，具有默契和责任，会完成从“外人”身份向“自己人”身份的转变。[209]王绍光和刘欣（2002）将信任的对象分为了亲人、朋友、熟人和陌生人四类，信任程度也依次降低，亲疏距离拉开出现的信任程度差异，呈现出了差序格局的特性[210]，且越靠近水波纹中心的关系往往因心理上的认同和情感上的亲密变得更加独特。由于中国人对公共领域和私人领域的理解不够清晰，或是受信任者传播的健康观点本就符合给予信任者理性上的认知，也使得亲疏距离比较容易改变。可以发现，保健品销售人员通过吸引老年人参与营销活动提高消费者涉入度，或是老年人本就持与虚假宣传广告类似的健康观点，认知层面上达成了共识，销售人员有了初次接触老人的契机，很容易从陌生人变为熟人，再通过与老年群体频繁的日常交往进一步实现身份的转变，成为知己朋友，甚至变得胜似亲人，关系和情感相互作用变得更加牢固和亲密，老年人信任这段关系并愿意为其承担风险。本研究还发现，保健品销售人员为了与老年客户保持密切的交流，构建了一个类似“大家庭”的公共空间，让老年消费者主动参与到保健品营销的相关活动中去。对儿女不在身边的老人们来说，可以在这个集体中相会旧友、结交新友，情感的需求让老人们愿意参加“大家庭”的活动。一套“组合拳”下来，老年人容易被他们信任的营销者误导，对健康产生错误的认识。这也对为何伪劣保健品营销骗局

[208] Coleman J S, *Foundations of social theory,* Harvard university press, 1994, p.99-101.
[209] 杨宜音：“自己人”:信任建构过程的个案研究，《社会学研究》，1999 年第 2 期，第 40-54 页。
[210] 王绍光，刘欣：信任的基础:一种理性的解释，《社会学研究》，2002 年第 3 期，第 23-39 页。

中国知网 https://www.cnki.net

和虚假宣传在我国成为一种特殊现象作出了很好的解释，集体主义的文化语境给“打亲情牌”营销策略提供了施展骗局的温床。

保健品销售人员与老年人建立强连接关系，本质上也是对老人原有的亲情、友情等情感的介入，因此老年人与自身家庭的关系不能忽视。在访谈过程中，笔者也对 8 位受访者的家庭和居住情况进行了了解。8 位老人都未和儿女一起居住，1 号、2 号、3 号、4 号、6 号受访者与子女见面的频次在两周一次以上，其余三位受访者与子女见面的频次在三个月一次以下，7 号（因生活习惯不同，与妻子异地分居；女儿工作较忙，经常出差）与 8 号（妻子在外省照顾女儿患有较严重疾病；儿子定居外市，工作较忙）是一人居住。与子女常见面的老人在无法根据自己的能力判断信息真伪的时候，会选择询问子女。而与子女不常见面的三位老人更倾向与老朋友、邻居交流这些“琐事”，或是通过各种渠道结交新朋友，子女由于未能常伴父母身旁，所以选择用金钱弥补陪伴，只要能在接受范围内，他们愿意为老人高兴买单。如 7 号受访者告诉笔者，女儿基本对自己有求必应，自己与朋友在保健品上的消费也并不过分，女儿也是知情的。邓女士的母亲早年丧偶，面对母亲购买的便宜伪劣保健产品，邓女士不会过多干预，但是一旦产品价格较高，邓女士还是会进行阻止。由此可见，子女们默认了老年人通过消费弥补情感需求的做法，并愿意提供一定的支持，从侧方面证明了老年人会因为情感需求购买保健产品，而该产品是否真正有效已不再重要。这也印证了模型显示的结果：认知信任产生了一定的影响力，情感信任发挥着最核心的作用。但实际上，常伴父母身边的女儿无法数字反哺的不到位，或是因忙于工作只能用金钱弥补亲情缺位和一定程度上的“纵容”，不仅未能做到正确引导老年人追求健康，还未能满足老年人的情感需求。

无论是对产品本身的认识，是对媒体的依赖、媒体信息的判断和选择，还是参加各类保健品营销活动，都需要通过认知信任或情感信任才能对购买意愿发挥影响，因为只有信任关系建立，才有下一步的消费行为。所以，信任在老年人消费伪劣保健产品的过程中起到了核心作用。

2. 信任危机与媒介偏见

信任危机不仅存在于“劣币驱逐良币”的我国保健品行业，也表现在老年群体对媒介及播发的保健品广告的态度。模型结果显示，虽然信任分化现象存在，但老年人无论对

中国知网 https://www.cnki.net

传统媒介还是新媒介上的保健品广告都抱着较不信任的态度，访谈部分反映出了老年群体存在媒介偏见的原因：屡禁难绝的伪劣保健产品广告和传播错误健康知识的养生节目正大光明地在电视上播出，善于伪装的品牌假新闻以报刊、杂志的方式夹杂在正规报刊中出现，大众媒体与保健品广告主构建出虚假的“合法性-权威”现实。在多次被骗的情况下，由于再次试错的成本太高，老年人索性“一刀切”地不再信任。同时，由于媒介使用经验难以复制，认为自己已经在因传统媒介上保健品广告受骗并积累了较丰富防骗经验的老人，在面对新媒介上的新套路时，如由线下养生讲堂摇身一变而来的线上健康网课，会再次变得迷茫。Marston 等人的研究证实了老年人学习新媒介技术的困难在于技术的更新速度太快，他们会认为自己的学习速度跟不上技术的改变，刚掌握的能力就被取代[211]。作为数字移民的老年群体在使用数字媒介时很难“触类旁通”或“举一反三”，在没有把关环节的海量信息中进行有效选择和判断无疑对媒介素养水平较低的老年人是一个巨大的难题。无论是线下消费还是线上消费，都难以让老年消费者放心。

媒介素养复杂的作用机制也反映出老年人仅凭自身是没有信心对保健品广告作出有效、正确的判断，一旦有旁人或保健品销售人员对其进行消费诱导，老年消费者所坚持的想法和判断很容易动摇。所以，老年群体提升自身媒介素养水平，才能免除干扰，依靠自己作出正确的判断，选择最适合自己的保健产品。

（二）局限性与展望

本研究将量化和质化的研究方法相结合，通过对保健品营销传播及普遍存在的伪劣保健品虚假宣传现象进行研究，探讨了我国老年人购买保健品意愿的影响因素，并对因素进行了溯因，深入解释了认知信任和情感信任在保健品营销中的作用机制。但由于客观方面的限制，本研究存在一定的局限性，主要有以下三点：

第一，样本存在局限性。本研究采用了网络问卷的方式收集数据，填答问卷的对象大多是居住在城市、会使用智能手机的老年人，未能涉及居住在农村、不会使用智能手机的老年群体。

第二，问卷所得结果存在局限性。本研究所设计问卷虽然在信效度上均通过检验，

[211] Marston H R, Genoe R, Freeman S, et al, “Older adults’ perceptions of ICT: Main findings from the technology in later life (TILL) study”, Healthcare, MDPI, Vol.7:3, 2019, p.86.

中国知网 https://www.cnki.net

但是受访对象在填答问卷时可能会产生不准确的理解。同时，本文采用购买意愿衡量老年人购买保健品的情况，但是购买意愿未必会完全转化为购买行为。这些因素都会导致所得数据与真实情况存在一定偏差。

除此之外，未来研究可以进一步关注传播效果，利用实验法研究保健品虚假宣传广告如何让老年人产生购买意愿，探讨是否还存在其他影响机制。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

一、中文参考文献

（一）著作类：

1.世界卫生组织：《积极老龄化政策框架》，北京：华龄出版社，2003 年。

2.李金城：《媒介素养的测量及影响因素研究》，上海：上海交通大学出版社，2017 年。

（二）论文类：

3.常路，温佳冰：城市老年群体保健食品的认知与消费行为研究，《特区经济》，2019 年第 7 期，第 74-77 页。

4.周彦莉，荣梅，冯群：社交消费中消费者信任及持久信任关系承诺的影响机制，《中国流通经济》，2020 年第 9 期，第 41-55 页。

5.张慧，周小虎，高照龙：揭开信任的面纱——基于认知和情感视角的信任双中介模型，《科技管理研究》，2021 年第 9 期，第 154-160 页。

6.刘远立：树立积极老龄观 促进健康老龄化，《行政管理改革》，2022 年第 4 期，第 15-20 页。

7.陈际华："时间银行"互助养老模式发展难点及应对策略——基于积极老龄化的理论视角，《江苏社会科学》，2020 年第 1 期，第 68-74 页。

8.胡宏伟，李延宇，张楚等。社会活动参与、健康促进与失能预防——基于积极老龄化框架的实证分析，《中国人口科学》，2017 年第 4 期，第 87-96+128 页。

9.姚进忠，潘静文：积极老龄化:社区为本老年社会工作服务项目行动研究，《社会工作与管理》，2018 年 3 期，第 12-19+58 页。

10.温书宇，李冰，穆星妍：助力新时代的积极老龄化:新型老年大学建设标准的探索与研究，《中国远程教育》，2022 年第 9 期，第 10-18+78 页。

11.王绍光，刘欣：信任的基础:一种理性的解释，《社会学研究》，2002 年第 3 期，第 23-39 页。

12.刘述：积极老龄化视角下我国香港老年人数字融入路径研究，《中国远程教育》，2021 年第 3 期，第 67-75 页。

中国知网 https://www.cnki.net

13.武晓立：跨越“数字鸿沟”:社交媒体时代老年人媒介素养的提升，《青年记者》，2020 年第 25 期，第 16-17 页。

14.杨宜音：“自己人”:信任建构过程的个案研究，《社会学研究》，1999 年第 2 期，第 40-54 页。

15.冯桂平，刘爽：基于跨理论模型的老年人医疗保健品消费行为研究，《消费经济》，2018 年第 04 期，第 74-81 页。

16.于文洁，郑中玉。基于消费构建想象的社区——对某老年保健品消费群体及其行为的研究，《社会学评论》，2018 年第 1 期，第 80-92 页。

17.聂仕倩：针对老年人的保健品营销背后的传播学现象解读，《科技传播》,2015 年第 7 期，第 45-46 页。

18.王胜源，赵怡森：健康传播视野下保健品广告神话的建构与消解——从“权健事件”谈起，《新闻研究导刊》，2021 年第 10 期，第 77-79 页。

19.韩玲，杨民：人口老龄化背景下保健品欺诈的刑法规制，《大连民族大学学报》,2019 年第 2 期，第 168-172 页。

20.张琳：“4V”营销理论下的大学生媒介素养教育，《青年记者》，2019 年第 29 期，第 99-100 页。

21.梁旭荣：我国保健品行业现状及发展趋势分析，《中国盐业》，2018 年第 3 期，第 31-35 页。

22.张静：国内保健品直销经营模式探究——以权健产品销售经营为例，《陕西行政学院学报》，2019 年第 2 期，第 82-88 页。

23.邵长凤，师东菊，张洋等：基于“互联网+”背景下保健品营销市场现状及策略研究，《中国市场》，2018 年第 5 期，第 127-128 页。

24.温佳冰，常路，张媛等：浅谈我国中老年人保健品市场的虚假宣传及其治理，《医学与法学》，2018 年第 10 期，第 64-67 页。

25.曹冰，蒋文平，段林利等：重庆市市区老年人对保健品的认识及利用现况，《中国老年学杂志》，2013 年第 17 期，第 4231-4233 页。

26.叶少剑：中国保健品行业现状分析，《医学与哲学(人文社会医学版)》，第 2011 年第 5 期，第 28-30 页。

27.谈煜鸿：老龄化背景下我国老年人保健品消费研究述评，《经济论坛》，2016 年第 6 期，第 108-111 页。

28.马素雅：国内保健品市场主要营销模式与问题分析，《商业经济》，2019 年第 3 期，第 69-70 页。

中国知网 https://www.cnki.net

29.王洵："健康老龄化"研究的回顾与展望，《人口研究》，1996 年第 3 期，第 71-75 页。

30.宋全成，崔瑞宁。人口高速老龄化的理论应对——从健康老龄化到积极老龄化，《山东社会科学》，2013 年第 4 期，第 36-41 页。

31.邬沧萍，彭青云：重新诠释"积极老龄化"的科学内涵，《中国社会工作》，2018 年第 17 期，第 28-29 页。

32.蒋俏蕾，陈宗海：银发冲浪族的积极老龄化：互联网使用提升老年人主观幸福感的作用机制研究，《现代传播》，2021 年第 12 期，第 41-48 页。

33.刘燕："机会主义行为"内容与表现形式的理论解析，《经济问题探索》，2006 年第 5 期，第 122-125 页。

34.胡怡雯：城市老年人微信使用与孤独感的关系研究，湘潭大学硕士学位论文，2020 年。

35.林宝灯，姚金丽：中老年群体网络消费信任影响因素实证研究，《贵州商学院学报》，2019 年第 3 期，第 38-47 页。

36.刘涛，周蔚昕，寇强：报纸药品及保健品广告违法现状与对策研究，《成都大学学报(社会科学版)》，2017 年第 2 期，第 15-20 页。

37.李伟民，梁玉成：特殊信任与普遍信任:中国人信任的结构与特征，《社会学研究》，2002 年第 3 期，第 11-22 页。

38.薛天山：中国人的信任逻辑，《伦理学研究》，2008 年第 4 期，第 70-77 页。

39.杨慧：现代社会的信任重构，《中国特色社会主义研究》，2020 年第 2 期，第 77-82 页。

40.徐尚昆：信任结构与信任重构论析，《中国特色社会主义研究》，2021 年第 1 期，第 71-79 期。

41.韩剑磊，明庆忠，史鹏飞等：视频社交媒体用户的旅游行为意向影响因素分析——基于信任的中介效应，《旅游研究》，2021 年第 4 期，第 1-14 页。

42.贾哲敏，孟天广：信息为轴:新冠病毒疫情期间的媒介使用、信息需求及媒介信任度，《电子政务》，2020 年第 5 期，第 14-27 页。

43.谢金文，王健美：社会信任的多学科研究及影响因素，《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》，2021 年第 6 期，第 63-73 页。

44.贾敏敏，孙建萍，杨支兰等：老年人保健品知-信-行研究进展，《中国临床护理》，2018 年第 5 期，第 448-451 页。

45.严琳：新媒体影响老年人消费行为的理论机制研究——以广州市中心城区老年人为例，《中国商

中国知网 https://www.cnki.net

论》，2020 年第 21 期，第 69-71 页。

46.江根源：媒介信任的解构与重构——评马妍妍博士的新作《信息时代媒介、受众与社会的关系研究》，《白城师范学院学报》，2020 年第 4 期，第 125-128 页。

47.程明，赵静宜：广告信任生成机制的新发展，《中南民族大学学报(人文社会科学版)》，2020 年第 1 期，第 143-147 页。

48.吴建：媒介可信度的实证研究——基于省域居民的大样本调查，《西南民族大学学报(人文社科版)》，2016 年第 2 期，第 147-152 页。

49.淡卫军：情感,商业势力入侵的新对象评霍赫希尔德《情感整饰:人类情感的商业化》一书，《社会》，2005 年第 2 期，第 184-195 页。

50.李涛，徐翔，张旭妍：孤独与消费——来自中国老年人保健消费的经验发现，《经济研究》，2018 年第 1 期，第 124-137 页。

51.费爱华：从消费的空间到空间的消费与再生产——以保健品“联谊会”为例，《华东经济管理》，2010 年第 2 期，第 95-98 页。

52.杨逊，余林：保健品广告对老年人的影响研究——卷入强度, 诉求方式影响保健品广告在老年人中的效果研究，《西南农业大学学报（社会科学版）》，2014 年第 1 期，第 162-165 页。

53.史烽，孟超，李晓锋等：基于 SOR 模型的网络团购消费者购买意愿研究，《商业经济研究》，2017 年第 20 期，第 53-55 页。

54.李琪，李欣，魏修建：整合 SOR 和承诺信任理论的消费者社区团购研究，《西安交通大学学报(社会科学版)》，2020 年第 2 期，第 25-35 页。

55.张绘：混合研究方法的形成、研究设计与应用价值——对“第三种教育研究范式”的探析，《复旦教育论坛》，2012 第 5 期，第 51-57 页。

56.李成波，杨茜，程云飞：新媒体使用对城市老年人电视信任的影响——基于西部三省市的实证调查分析，《特区经济》，2019 年第 10 期，第 103-106 页。

57.程德俊，宋哲，王蓓蓓：认知信任还是情感信任:高参与工作系统对组织创新绩效的影响，《经济管理》，2010 年第 11 期，第 81-90 页。

58.刘鸣筝，陈雪薇：基于使用、评价和分析能力的我国公众媒介素养现状，《现代传播(中国传媒大学学报)》，2017 年第 7 期，第 153-157 页。

59.闫文捷，张军芳，朱烊枢：“高选择媒体环境”下的媒介素养及其社会影响——基于新冠疫情期间

中国知网 https://www.cnki.net

中国城市居民的问卷调查，《新闻与写作》，2020 年第 8 期，第 31-42 页。

60.孟博文，殷文：老年传播视角下新媒介适老性研究——以智能手机与微信、抖音等 APP 为例，《传媒观察》，2021 年第 8 期，第 74-79 页。

61.姜素芳，潘琪，陈志良：网络食品消费者风险感知能力影响因素的实证研究——以浙江省为例，《中国食物与营养》，2019 年第 6 期，第 37-42 期。

62.周伟，窦贤惠：网络信息消费风险感知的影响因素研究，《内蒙古农业大学学报(社会科学版)》，2021 年第 1 期，第 49-54 页。

63.刘少杰：不确定条件下社会信任的分化与协调，《江苏社会科学》，2020 年第 4 期，第 61-68+242-243 页。

64.王凤翔：广告主对大众媒体的影响与控制分析——基于“广告话语权”视角并以中国医药、保健品广告为例，《新闻与传播研究》，2007 年第 3 期，第 7-14+94 页。

65.丁卓菁：新媒体环境下老年群体媒介素养教育探讨，《新闻大学》，2012 年第 3 页，第 116-121 页。

66.周裕琼：数字弱势群体的崛起:老年人微信采纳与使用影响因素研究，《新闻与传播研究》，2018 年第 7 期，第 66-86+127-128 页。

67.王树新：北京市人口老龄化与积极老龄化，《人口与经济》，2003 年第 4 期，第 1-7+13 页。

68.周彦莉，荣梅，冯群：社交消费中消费者信任及持久信任关系承诺的影响机制，《中国流通经济》，2020 年第 9 期，第 41-55 页。

69.宗文宙：消费者认知信任影响因素分析，《商业经济研究》，2021 年第 11 期，第 58-61 页。

（三）其他类：

70.中新经纬：《软文写手把没用过的保健品"吹上天":一天写几十篇 精美图片配表情》，https://finance.sina.com.cn/consume/puguangtai/2020-08-31/doc-iivhvpwy3999690.shtml?cref=cj，发表于 2020 年 8 月。

71.国家广播电视总局：《国家新闻出版广电总局办公厅关于立即停止播出 “苗仙咳喘方”等 40 条违规广告的通知》，http://www.nrta.gov.cn/art/2017/6/23/art_113_34125.html，2017 年 6 月发表。

72.海外网：《养生类电视节目“枫叶正红”被指顶风促销保健品》，http://m.haiwainet.cn/middle/352345/2014/1029/content_21299124_1.html，2014 年 10 月发表。

中国知网 https://www.cnki.net

73.新浪财经：《刘天鹏教授：对保健品要科学认知 不能期待过高也不用全盘否定》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1694296119140025599&wfr=spider&for=pc，2021 年 3 月发布。

74.中国青年报：《京东发布“银发经济”大数据：老年用户网购销量同比增长 4.8 倍》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1713595300505123478&wfr=spider&for=pc，2021 年 10 月发布。

75.扬子晚报：《花 15400 元微信看病，却入了特大性保健品诈骗团伙的坑》，https://www.yangtse.com/zncontent/476012.html，2020 年 4 月发布；中国新闻网：《广州一特大“保健品”诈骗集团被端掉 225 人落网》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1638132283449037229&wfr=spider&for=pc，2019 年 7 月发布。

76.长春日报：《超四成老年受访者曾被骗买保健品》，http://news.youth.cn/jsxw/201703/t20170330_9383618.htm，2017 年 3 月发布。

77.央广网：《中老年人上网状况及风险网络调查报告正式发布》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1604933687196965091&wfr=spider&for=pc，2018 年 7 月发布。

78.百度百科：《全国打击整治养老诈骗专项行动》，https://baike.baidu.com/item/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E6%89%93%E5%87%BB%E6%95%B4%E6%B2%BB%E5%85%BB%E8%80%81%E8%AF%88%E9%AA%97%E4%B8%93%E9%A1%B9%E8%A1%8C%E5%8A%A8/61072104，2022 年 6 月发布。

79.艾媒报告中心：《2019-2020 中国保健品行业研究报告》，https://report.iimedia.cn/repo12-0/39048.html，2020 年发布。

80.百度百科：《蓝帽子标志》，https://baike.baidu.com/item/%E8%93%9D%E5%B8%BD%E5%AD%90%E6%A0%87%E5%BF%97/9461244?fr=aladdin，2021 年 12 月发布。

81.光明网：《“积极老龄观，健康老龄化” 新时代老龄工作的重磅文件来了！》，https://m.gmw.cn/baijia/2021-11/25/1302693741.html，2021 年 11 月发布。

82.中工网：《低龄老人“主动健康”需跨越几道槛？》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1743601013175505835&wfr=spider&for=pc，2022 年 9 月发布。

83.新华社：《中国老年大健康智库在京成立》，http://www.cncaprc.cn/?c=i&a=sousuo_mod&gjz=%E6%99%BA%E5%BA%93&id=2911，2018 年 11 月发布。

84.华研科技：中国老年大健康智库“关于促进保健产品市场健康发展”的建议，http://www.51hykj.com/newsinfo/1073588.html?templateId=1133604，2019 年 3 月发表。

中国知网 https://www.cnki.net

85.新华社：《“中国老龄事业的发展”白皮书》，http://www.gov.cn/jrzg/2006-12/12/content_467201.htm，2006 年 12 月发布。

86.南方日报：《健康、参与、保障：积极应对人口老龄化的三大支柱》，https://theory.southcn.com/node_4274ee5d35/7f7cbd011a.shtml，2021 年 4 月发布。

87.新华网：《揭秘伪中医保健：打中药旗号卖保健品 投诉居高不下》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1623858521509688069&wfr=spider&for=pc，2019 年 1 月发布。

88.新京报：《我国老年人小学及以下文化程度超七成，影响其生活质量》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1654421668390192194&wfr=spider&for=pc，2019 年 12 月发布。

89.中国日报网：《保健品虚假营销:套路满满、疯狂洗脑,只为拉老人入陷阱》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1605673083950507184&wfr=spider&for=pc，2018 年 7 月发布。

90.银发产业网：《从中国足球和保健品的管理失败，谈保健营养产业何去何从？》， https://baijiahao.baidu.com/s?id=1653401795140733408&wfr=spider&for=pc，2019 年 12 月发表。

91.百度百科：《保健食品广告审查暂行规定》，https://baike.baidu.com/item/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%B9%BF%E5%91%8A%E5%AE%A1%E6%9F%A5%E6%9A%82%E8%A1%8C%E8%A7%84%E5%AE%9A/5711627?fr=aladdin，2012 年 10 月发表。

92.上观新闻：《买回假冒保健品 130 多名老人被骗 140 多万元》，https://www.jfdaily.com/sgh/detail?id=838242，2022 年 8 月发表。

93.潇湘晨报：《保健品免费畅吃还返利？上海一老人被骗走 20 万丨打击整治养老诈骗》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1742331595094317985&wfr=spider&for=pc，2022 年 8 月发表。

二、外文类参考文献

（一）著作类：

94.Coleman J S, Foundations of social theory, Harvard university press, 1994.

95.Creswell J W, A concise introduction to mixed methods research, SAGE publications, 2014.

96.Mehrabian A & Russell J A, An Approach to Environmental Psychology, Cambrige: MIT Press, 1974.

97.Simmel G, The philosophy of money, Lonjdon: Routledge, 1978.

中国知网 https://www.cnki.net

98.Luhmann N, Trust and power, Chichester: John Wiley & Sons, 1979.

99.Roderick M K & Tom R T, Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, SAGE Publications, 1995.

（二）论文类

100.Taylor J W, “The role of risk in consumer behavior: A comprehensive and operational theory of risk taking in consumer behavior,” Journal of marketing, Vol.38:2, 1974, p.54-60.

101.Crié D & Chebat J C, “Health marketing: Toward an integrative perspective,” Journal of Business Research, Vol.66:1, 2013, p.123-126.

102.McAllister D J, “Affect- and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations,” The Academy of Management Journal, Vol.38:1, 1995, p.24-59.

103.Punyatoya P , “Effects of cognitive and affective trust on online customer behavior,” Marketing intelligence & planning, Vol.37:1, 2019, p.80-96.

104.Lascaux A & Kolesnikova I, “The emergence and evolution of cognition-and affect-based trust in Russian entrepreneurial ventures,” Strategic Entrepreneurship Journal, Vol.15:4, 2021, p.685-715.

105.Boon H S & Kachan N, “Natural health product labels: Is more information always better?,” Patient education and counseling, Vol.68:2, 2007, p.193-199.

106.Rotter J B, “A new scale for the measurement of interpersonal trust 1,” Journal of personality, Vol35:4, 1967, p.651-665.

107.Boštjančič E, Ismagilova F & Maltcev A, “The Relationship between Control over a Deal and Cognitive-Based Trust in an International Business Partnership,” Organizacija, Vol.53:2, 2020, p.95-110.

108.Zucker L G, “Production of trust: Institutional sources of economic structure 1840–1920,” Research in organizational behavior, 1986, p.53-111.

109.Nooteboom B, Berger H & Noorderhaven N G, “Effects of trust and governance on relational risk,” Academy of management journal, Vol.40:2, 1997, p.308-338.

110.Chua R Y J, Morris M W & Ingram P, “Guanxi vs networking: Distinctive configurations of affect-and cognition-based trust in the networks of Chinese vs American managers,” Journal of interna

中国知网 https://www.cnki.net

tional business studies, Vol.40:3, 2009, p.490-508.

111.Urala N & Lähteenmäki L, “Attitudes behind consumers' willingness to use functional foods,” Food quality and preference, Vol.15:7-8, 2004, p.793-803.

112.Johnson D & Grayson K, “Cognitive and affective trust in service relationships,” Journal of Business research, Vol.58:4, 2005, p.500-507.

113.Tomlinson E C, Schnackenberg A K, Dawley D, et al, “Revisiting the trustworthiness–trust relationship: exploring the differential predictors of cognition-and affect-based trust,” Journal of Organizational Behavior, Vol.41:6, 2020, p.535-550.

114.Strömbäck J, Tsfati Y, Boomgaarden H, et al, “News media trust and its impact on media use: Toward a framework for future research,” Annals of the International Communication Association, Vol.44:2, 2020, p.139-156.

115.West M D, “Validating a scale for the measurement of credibility: A covariance structure modeling approach,” Journalism quarterly, Vol.71:1, 1994, p.159-168.

116.Dăniasă C I, Tomiţă V, Stuparu D, et al, “The mechanisms of the influence of viral marketing in social media,” Economics, Management & Financial Markets, Vol.5:3, 2010, p.278-282.

117.Vaughn R, “How advertising works: A planning model,” Journal of Advertising Research, Vol.26:1, 2986, p.27-33.

118.Liu B & Lu Q, “Creating a sustainable workplace environment: Influence of workplace safety climate on Chinese healthcare employees’ presenteeism from the perspective of affect and cognition,” Sustainability, Vol.12:6, 2020, 2414.doi:10.3390/su12062414.

119.Johnson R B, Onwuegbuzie A J & Turner L A, “Toward a definition of mixed methods research,” Journal of mixed methods research, Vol.1:2, 2007, p.112-133.

120.Johnson R B & Onwuegbuzie A J, “Mixed methods research: A research paradigm whose time has come,” Educational researcher, Vol.33:7, 2004, p.14-26.

121.Oliveira T, Alhinho M, Rita P, et al, “Modelling and testing consumer trust dimensions in e-commerce,” Computers in Human Behavior, Vol.71, 2017, p.153-164.

122.Bashir S, Anwar S, Awan Z, et al, “A holistic understanding of the prospects of financial loss to enhance shopper's trust to search, recommend, speak positive and frequently visit an online sho

中国知网 https://www.cnki.net

p," Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.42, 2018, p.169-174.

123.Vivek S D, Beatty S E & Morgan R M, "Customer engagement: Exploring customer relationships beyond purchase," Journal of marketing theory and practice, Vol.20:2, 2012, p.122-146.

124.Wang W, Qiu L, Kim D, et al, "Effects of rational and social appeals of online recommendation agents on cognition-and affect-based trust," Decision Support Systems, Vol.86, 2016, p.48-60.

125.Zhu Y & Akhtar S, "The mediating effects of cognition-based trust and affect-based trust in transformational leadership's dual processes: evidence from China," The International Journal of Human Resource Management, Vol.25:20, 2014, p.2755-2771.

126.Ng K Y & Chua R Y J, "Do I contribute more when I trust more? Differential effects of cognition-and affect-based trust," Management and Organization review, Vol.2:1, 2006, p.43-66.

127.Lee N M, "Fake news, phishing, and fraud: a call for research on digital media literacy education beyond the classroom," Communication Education, Vol.67:4, 2018, p.460-466.

128.Fisher C, "The trouble with 'trust'in news media," Communication Research and Practice, Vol.2:4, 2016, p.451-465.

129.Vraga E K, Tully M, Akin H, et al, "Modifying perceptions of hostility and credibility of news coverage of an environmental controversy through media literacy," Journalism, Vol.13:7, 2012, p.942-959.

130.Migge T , Kiffin-Petersen S A & Purchase S, "When Western measures meet Eastern perspectives: A prototyping analysis of xinren in buyer-seller relationships", Industrial Marketing Management, Vol.91, 2020, p.129-141.

131.Bedford O, "The relation between guanxi and interpersonal trust in the workplace," Integrative Psychological and Behavioral Science, 2021, p.1-20.

132.Lewis J D & Weigert A, "Trust as a social reality," Social forces, Vol.63:4, 1985, p.967-985.

133.Swan J E, Trawick I F & Silva D W, "How industrial salespeople gain customer trust," Industrial marketing management, Vol.14:3, 1985, p.203-211.

134.Glikson E & Woolley A W, "Human trust in artificial intelligence: Review of empirical research," Academy of Management Annals, Vol.14:2, 2020, p.627-660.

135.Zaichkowsky J L, "Conceptualizing involvement," Journal of advertising, Vol.15:2, 1986, p.4-34.

中国知网 https://www.cnki.net

136.Kandampully J, “The impact of demand fluctuation on the quality of service: a tourism industry example,” Managing Service Quality: An International Journal, Vol.10:1, 2000, p.10-19.

137.Rothschild M L, “Marketing communications in nonbusiness situations or why its so hard to sell brotherhood like soap,” Journal of marketing, Vol.43:2, 1979, p.11-20.

138.Abou-Elgheit E, “Affect-based and personality-based trust and risk in social commerce,” International Journal of Electronic Marketing and Retailing, Vol.10:2, 2019, p.173-207.

139.Hair J F, Sarstedt M, Ringle C M, et al, “An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research,” Journal of the academy of marketing science, Vol.40:3, 2012, p.414-433.

140.Fornell C & Larcker D F, “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error,” Journal of marketing research, Vol.18:1, 1981, p.39-50.

141.Tenenhaus M, Vinzi V E, Chatelin Y M, et al, “PLS path modeling,” Computational statistics & data analysis, Vol.48:1, 2005, p.159-205.

142.Wetzels M, Odekerken-Schröder G & Van Oppen C, “Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration,” MIS quarterly, 2009, p.177-195.

143.Lazer D M J, Baum M A, Benkler Y, et al, “The science of fake news,” Science, Vol.359:6380, 2018, p.1094-1096.

144.Lyu S, Sun J, “Internet use and self-rated health among Chinese older adults: the mediating role of social capital,” Geriatrics & Gerontology International, Vol.21:1, 2021, p.34-38.

145.Singh K, “Influencer Marketing from a Consumer Perspective: How Attitude, Trust, and Word of Mouth Affect Buying Behavior,” European Integration Studies, Vol.15, 2021, p.231-241.

146.Syed M , Ahmed F , Zahid N , et al, “Essentials of Healthcare Marketing,” Asian Journal of Medicine and Health, Vol.19:2, 2021, p.73-79.

147.Marston H R, Genoe R, Freeman S, et al, “Older adults’ perceptions of ICT: Main findings from the technology in later life (TILL) study”, Healthcare, MDPI, Vol.7:3, 2019, p.86.

（三）其他类：

148.World Health Organization: "Active ageing: A policy framework," https://apps.who.int/iris/handle/10665/67215, 发布于 2002 年 4 月.

中国知网 https://www.cnki.net

附录一：老年人购买保健品情况的问卷

亲爱的朋友：

您好！我是西南政法大学的一名研究生。首先非常感谢您抽空填写这份问卷，是您让我的研究更有价值。本问卷的目的在于了解老年人购买保健品的情况，收集到的数据用于研究老年人购买保健品的影响因素。本问卷采用不记名的方式，调查结果仅用于毕业论文写作，绝不会对外透露个人信息，请您放心填写。再次感谢您，祝您身体健康，幸福如意！

1.我能够从其它渠道找到证明资料，来判断保健品广告是否可以相信。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

2.我能够通过广告标题及内容，判断保健品广告是否可以相信。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

3.我能够通过信息发布来源的权威性，判断保健品广告是否可以相信。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

4.我能够判断保健品广告的内容，是真实的健康知识还是售卖产品的套话。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

5.我对电视上的保健品广告十分信任。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

6.我对报纸/杂质上播放的保健品广告十分信任。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

7.我对微信上的保健品广告十分信任。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

8.我对网购 APP 上的保健品广告十分信任。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

9.我参加过保健品公司举办的健康讲座/免费体检/专家义诊等活动。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

10.我参加过保健品公司的赠送小礼品/获得优惠购买资格等活动。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

中国知网　https://www.cnki.net

11.我参加过保健品公司组织的旅游团等活动。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

12.我不排斥保健品的销售人员来家里拜访我。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

13.保健品广告中，我认为宣传的最新医学研究和科学技术是可靠的。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

14.保健品广告中，我认为宣传的“纯天然”“自然”成分是可靠的。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

15.保健品广告中，我认为宣传的“家传秘方”“古法制作”是可靠的。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

16.保健品广告中，我认为宣传的“患者痊愈”故事是可靠的。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

17.我相信我选择的保健品商家提供了保健品真实的信息。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

18.我相信我选择的保健品商家有能力提供正规的保健品。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

19.我相信我选择的保健品商家是值得我信赖的。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

20.我认为我与保健品销售人员建立了良好的情感关系。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

21.我认为保健品销售人员是在关心我健康的情况下为我推荐相应的保健产品。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

22.我承认我在保健品公司举办的活动中投入了一定的精力、情感和信任。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

23.我会因为看了保健品广告，认为该产品对我有用而购买保健品。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

24.我会因为接触了保健品销售人员，看在与他们的情分上购买保健品。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

中国知网　https://www.cnki.net

25.比起药品，我愿意更购买保健品。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

26.我愿意作为老消费者向其他人推荐我购买的保健品。

○非常不同意　○不同意　○不确定　○同意　○非常同意

27.您的性别:

○男　○女

28.您的受教育程度

○初中及以下　○高中/中专　○大专/高职　○大学本科及以上

29.您的年龄

○55~59 岁　○60~64 岁　○65~69 岁　○70~74 岁　○75~79 岁　○80 岁以上

中国知网　https://www.cnki.net

附录二：受访者基本资料

编号	称呼	年龄	性别	受教育程度	曾从事职业
1	祁先生	83	男	中专	公务员
2	王女士 A	79	女	中专	公务员
3	向先生	90	男	大专	公务员
4	王女士 B	82	女	高中	公务员
5	陈女士	71	女	初中	工人
6	刘女士	75	女	大专	企业职工
7	周先生	78	男	中专	公务员
8	郑先生	73	男	大专	工人

中国知网 https://www.cnki.net

附录三：访谈提纲

一、保健品购买情况

1.您是第一次购买保健品是什么时候？购买的是正规保健品还是伪劣保健品？

2.您是通过什么渠道了解到该产品的？

3.您购买了哪些产品？为什么买？大概花费了多少钱？

4.您在使用这些保健品之后，是否感觉功效与宣传的相同？之后还继续购买过其他保健产品吗？

5.您是否感觉自己受到了欺骗？是否采取过维权措施？

6.您是否患有慢性病？经济能力如何？

二、传统媒介及信任

1.您是否在使用电视、报纸、杂志等传统媒介的时候，看到了保健品广告？它是如何宣传的，内容大概是什么？

2.您是否购买了产品？是如何联系购买的？能分享一下您的经历吗？

三、新媒介及信任

1.您是否在浏览微信朋友圈、购物软件、网页等时候，看到了保健品广告？它是如何宣传的，内容大概是什么？

2.您是否购买了产品？是如何联系购买的？能分享一下您的经历吗？

四、家庭角色扮演

1.您平时和谁一起居住？会觉得孤独吗？

2.您的家人是否对您购买保健品的态度如何？

3.您在拿不准的时候，是否会寻求家中晚辈帮助？

4.家中晚辈是否会教您如何去辨别保健品真伪？

五、新社交关系的建立

1.您会和保健品推销人员成为朋友吗？他们与您交往的过程中，具体做了些什么？

2.您会其他购买保健品的人成为朋友吗？

中国知网 https://www.cnki.net